

05.01.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Psychosomatik
Weppner	Hanisch	Wiehn

Klinischer Fall: Gastrointestinale Blutung

Maria Müller, 38 Jahre alt, 100 kg, hat 2 Kinder

Patientin klagte über seit 4-5 Wochen Müdigkeit und Energielosigkeit, diese Beschwerden haben sich über die Weihnachten verschlimmert. Nach Fragen hat sie gesagt, dass sie auch blass aussehe, aber das sei schon Langem so, da sie sehr starke Monatsblutung habe. Aber sie sei vor Kurzem bei Frauenärztin und ihre Blutwerte seien in Ordnung.

Zudem habe Sie seit ungefähr 3 Wochen Atemnot, der nicht bewegungsabhängig ist. Sie könne noch Treppen steigen, die Alltagsaktivitäten seien davon nicht beeinträchtigt. Brustschmerzen wurden verneint. (Deswegen habe ich kein EKG machen lassen)

Darüber hinaus hatte die Patientin seit 3 Wochen epigastrische Bauchschmerzen, die nach dem Essen vorkommen. Sie müsse auch sauer aufstoßen und habe ab und zu Blähung. Sie habe gestern auch komische, schwarze Stuhl gehabt, was sie gegooglet habe und jetzt davor Angst habe, dass es wegen Blut sein könnte. Ich habe sie beruhigt und gesagt, dass ich ihr helfe, den richtigen Grund zu finden aber es tatsächlich deswegen vorkommen kann. Die Stuhl sei flüssig, früher habe sie regelmäßigen, normalen Stuhlgang. Ich habe nach Eisentabletten gefragt, weil die auch schwarzen Stuhl verursachen können, sie nehme aber keine und meinte, dass sie früher wegen Tabletten diesen schwarzen Stuhl hatte aber dieses mal es anders sei. Kein Erbrechen wurde erwähnt. Die Patientin habe auch viel Stress zu Hause mit den Kindern, sowie in der Arbeit.

Kein Fieber, keinen Nachtschweiss, keine Gewichtszunahme oder -abnahme, obwohl die Patientin seit 2 Jahren sich vegan ernährt und hofft damit Gewicht zu verlieren. Ich habe gesagt, na ja vegan muss nicht immer bedeuten, dass es gesund ist. Sie rauche seit 20 Jahren jeden Tag eine Packung Zigaretten. Alkohol- und Drogenkonsum wurden verneint. Sie möchte auch aufhören zu rauchen. Ich habe gesagt, dass wir ihr mit Gewichtabnahme und Rauchen helfen können, sie muss nicht alles alleine schaffen (sie hat sich gefreut).

Keine Reiseanamnese, vollgeimpft, besuche die Frauenärztin regelmäßig. Die Monatsblutungen dauern 7-8 Tage, sie müsse am Tag 5-6 Binden wechseln. Vorerkrankungen, keine regelmäßige Medikamente, nur Ibuprofen 600 mg bei Bedarf, wenn die Rückenschmerzen habe. Als Kind wurde vom Magenverschluss (pylorusstenose?) operiert. Die Patientin hat auch von sich selbst erzählt, dass sie in Italien geboren und als Kind nach Deutschland gezogen ist. (Vielleicht wollten die Prüfer damit zu Thalassämie oder Sichelzellanämie oder andere genetische Erkrankungen die irgendwie in Cecillia häufig vorkommen in DD bringen, ich konnte bei dem Brief nur auf Thalassämie kommen, habe in diesem Moment an Sichelzellanämie nicht gedacht). Ich habe aber Familienanamnese gefragt, keine Erkrankungen außer Adipositas. Keine Koloskopie oder Gastroskopie wurde ihr bisher gemacht. Blutzucker wird regelmäßig beim Hausarzt kontrolliert.

KU: Da ich nicht viel Zeit hatte, habe ich schnell Vitalparametern gemessen, waren natürlich normal, dann mir wurde gesagt: HF: 98/min AF:16/min RR: 110/85 mm-Hg, Fieber habe ich vergessen zu messen, deswegen wurde auch vom Prüfer nicht erwähnt.

Danach habe ich schnell den Bauch untersucht (Inspektion -hier habe laut gesagt "Post OP Narbe, kein Ikterus, kein Aszites), Auskultation, Perkussion, Palpation --> epigastrische Druckschmerzen, ich habe keine Hepatosplenomegalie untersucht, musste man aber wegen hämolytischer Anämie, bitte nicht vergessen! Ich habe es im Brief erwähnt), hier habe ich leider total vergessen DRU zu erwähnen (auch im Brief habe ich gar nicht daran gedacht, bitte merkt euch!). Danach habe ich Lungen untersucht. Atemexkursion, Palpation, Perkussion, Auskultation--> unauffällig) Ich habe das Herz auch auskultiert, erst dann fiel mir ein, dass ich die Lunge vom vorne auch auskultieren sollte, habe ich gemacht)

Labor/Bildgebung: Dann wollte ich Blutbild sehen, der Herr Hanisch hat nur gesagt, Hb: 9.8. Dann habe ich MCV gefragt: 80. Er hat immer gewartet, dass ich genau das Wert nenne, was ich hören soll) Retikulozytenindex>2, Ferritin:4, Bilirubin, BGA und CRP unauffällig. Hier sollte man Thrombozyten und Leukozyten auch natürlich fragen, wegen Thrombozytopenie können die Patienten auch bluten oder Knochenmarkbefall von einer Malignität? --> Leukozytose? (habe ich im Brief erwähnt). Aber ich war total im Panik wegen der Zeit, hatte Schwierigkeiten sogar die VPs und Werte, die gesagt wurden, zu verstehen und einzuordnen, ich habe gar nicht daran gedacht.

Dann wollte ich Abdomen-Sono, unauffällig. Dann war ich bisschen verwirrt, was mit der Patientin zu machen, dann bin ich darauf gekommen Stuhlhämatooculttest zu fragen, der hoch positiv war. Dann habe ich gesagt, "ich lege Ihnen venösen Zugang und verabreiche 80 mg Pantoprazol. Da ich Verdacht auf gastrointestinale Blutung habe, werde ich Sie ins Krankenhaus zur Gastroenterologie einweisen." Dann hat die Patientin gefragt, was Gastroenterologie ist. Ich habe gesagt, Abteilung von Innermedizin, die vom Verdauungssystem zuständig ist. Und das war's. Ich habe im Brief alles detailliert geschrieben.

DD:

Ulcus ventriculi mit Blutung, Gastritis Typ B oder C, H. pylori Infektion, Eisenmangelanämie, Thalassämie, Chronische Erkrankung Anämie (das sollte man vielleicht nicht schreiben, CRP war negativ), Magenkarzinom

Im Brief habe ich noch erwähnt, dass ich wegen Hypothyreose TSH und T4, das ganze Blutbild kontrollieren wurde.

Weiteres Vorgehen: Nahrungskarenz, Flüssigkeitszufuhr, Hochdosierte PPI iv, Einweisung zur Gastroenterologie, Ösophagogastroduodenoskopie (Hier habe ich vergessen, blutstillende endoskopische Maßnahmen zu erwähnen --> Clips, Unterspritzung, Ligatur, Koagulation, Sklerosierung) Ggf. Ulcuschirurgie --> bei Verdacht auf Karzinom --> Biopsie, für H. pylori Schnelltest Urease

Ich finde 20 Minuten für Anamnese und Untersuchung sehr kurz, aber 30 Minute für Dokumentation reicht eigentlich aus. Die Prüfer wissen das auch, deswegen alles ihr vergessen habt, könnt ihr im Brief erwähnen) Im mündlichen Teil, kann ich leider nicht sagen die Prüfer sehr freundlich waren, ich meine sie waren zwar nett, aber auch seriös und direkt. Nur mit Herrn Wiehn hatte ich das Gefühl, das es wie in einem Gespräch ist.

Innere Medizin

Fall war Arterielle Hypertonie. P: Wie diagnostizieren wir das? Ich habe wiederholte Messungen und ggf. 24 Stunden Messung erwähnt. Wenn die Messungen passen, dann habe ich erklärt:

Prähypertonie: 130-139/85-89 mmHg

Hypertonie Grad 1: 140-159/90-99 mmHg

Hypertonie Grad 2: 160-179/100-109 mmHg

Hypertonie Grad 3 > 180/110 mmHg

P: Welche Typen gibt es? / Essentiell und Sekundär

P: Wie viel Prozent davon ist Primär (essentiell)? / 90% Primär.

P: Was würdest du bei der Diagnose untersuchen? / Hier hatte ich Schwierigkeiten genau zu verstehen, wie er die Antworten hören möchte. Ich habe angefangen mit Risikofaktoren (Adipositas, DM, Rauchen, Hyperlipidämie gesagt), also Anamnese, aber er hat es irgendwie direkt wie Labor verstanden. Dann sind wir mit Labor weitergemacht. Nierenwerte (Kreatinin, Harnstoff), Urin (Albumin).

P: Welche apparative Diagnostik? / Abdomen Sono, Nierenarterien Doppler Sono,

P: Welche Gründe gibt es für sekundäre Hypertonie? / Nebennieren Adenome (Cushing, Conn, Phäokromozytoma)

P: Wie würdest du die unterscheiden? / Cushing: Vollmondgesicht, Stiernacken, abdominales Fett, Stria, Hyperglykämie.

P: (hat mich unterbrochen) Wie verstehst du Phäo? / Schlagartige Symptome wie Flushing oder Tachykardie, die später weggehen.

P: Welche Untersuchung machst du? / Abdomen Sonografie oder CT mit KM.

P: Nein vor dem? Nicht apparativ? / Er wollte erst 24 Stunden Urin hören, was er direkt selber gesagt hat.

P: Wie soll man Urin sammeln? / Wenn die Patienten Symptome haben, müssen sie anfangen zu sammeln. (ich habe was anderes erzählt, was wir bei Pädiatrie machen, morgens erster Urin usw, aber die Antwort, die er hören möchte, war was ich oben geschrieben habe)

P: Was gibt es in der 24 Urin Flasche? / Diese Frage fand ich schon sehr absurd und ich hatte keine Ahnung, dass es in 24 Stunden Urin Flaschen irgendwas gab, in der Türkei habe ich mehrmals diese Untersuchung gemacht, die

Flaschen waren leer, deswegen musste ich nachfragen, ob ich irgendwie die Frage richtig verstanden habe, was ihm geärgert hat. Ich habe gesagt, dass ich weiß, dass wir Metanephrin und Normetanephrin untersuchen aber was in der Flasche drin ist, weiß ich nicht. Die Antwort hat er selber erzählt, habe leider nicht ganz verstanden, was er gesagt hat.

P: OK, welche Krankheiten noch? / Da hat mein Gehirn wir nachlassen zu arbeiten konnte nichts finden, habe ich gesagt Aortenstenose. Obwohl es stimmt, war das ein Fehler, das zu sagen weil ich habe eine weitere Frage über Aortenstenosen bekommen habe.

P: Wann hört man Aortenstenose und wo genau? / Ich habe bei Systole und 2. ICR rechts gesagt weil es wo wir Aortenklappe auskultieren. Aber er meinte stenose kommt von unten deswegen links? (Keine Ahnung, ob das stimmt)

P: Was noch? / OSAS

P: WAS NOCH? WAS NOCH? WAS NOCH? Am Ende hat er akzeptiert, dass ich nicht daraufkomme und gesagt, mit Schilddrüsen?

Dann war meine Antwort klar Hyperthyreose.

P: Jetzt kommen wir 4 Säulenthapie, wie ist es? / Dann habe ich natürlich direkt mit Medikamenten angefangen, ACE Inhibitoren? Betablocker?

P: Nein, Leitlinien sagen was anderes. / Lebensstilländerungen.

Gewichtabnahme, Nikotinkarenz, regelmäßige Bewegung (welche? Laufen und Schwimmen) DM Kontrolle.

P: Okay jetzt die Medikamente? / ACE Inhibitoren, AT1 Blocker, ARNI, Betablocker, Ca Kanal Blocker, Diuretika (Spironolakton und Eplerenon).

P: Bei Schwangerschaft? / Alfa methyl Dopa habe ich gesagt, Prüfer hat ergänzt: Und Ca Kanal Blocker.

P: Ok, wenn die Wirkung nicht ausreicht? / Kombinationstherapie. Hier ist wichtig zu wissen, verapamil und diltiazem mit Betablocker kombiniert werden kann, weil die keine Reflaxetaxhykardie verursachen.

P: Wenn das alle nicht reicht? / Ich hatte keine Ahnung obwohl der Prüfer schon Hinweise gegeben hat, Renale Sympathikusdenervation ist die Antwort.

Herr Weppner redet meiner Meinung nach undeutlich, was mich in Schwierigkeiten gebracht hat. Er hat ein eigenes Schema in seinem Kopf, wie die Fragen beantwortet werden sollen, was leider meinem Schema nicht ganz passte. Er ließ mich manchmal kaum reden, obwohl ich die Antwort kannte. Er hat auch ganz detailliert gefragt, dass wir ganze Zeit nur ein Thema besprochen haben aber selber erzählt er auch viel, womit man Zeit gewinnt.

Psychosomatik

P: Da wir darüber gesprochen haben, kennen sie irgendwelche Medikamente, die Innere Mediziner sehr häufig verschreiben aber Depression verursachen kann? / Ich kannte nicht, die Antwort Betablocker und PPI.

P: Depression Typen? / Unipolar, Bipolar, Saisonal, rezidivierend, chronisch länger als 2 Jahre anhaltend, Schwangerschaft und Wochenbett.

P: Welche Typen von Unipolarer? Wie therapieren wir welche? / Leicht, mittelgradig, schwer. Psychoedukation, Bewegung, Quellenfindung und -aktivierung, Psychotherapie für alle. Für mittelgradig können wir Psychopharmaka anbieten. Für schwer müssen wir Psychopharmaka noch mit allen erwähnten Maßnahmen geben.

P: Welche Psychopharmaka würden den Patienten mit Herzerkrankung nicht geben? / Wieder wusste ich nicht was er genau wollte, ich habe gesagt Mirtazapin eher nicht wegen Gewichtszunahme. Das war aber nicht, was er wollte, dann hat er die Frage umgewandelt, da er meinte, dass es Facharztniveau ist. Dann hat er gefragt, welche von diesen 2 Medikamenten würden sie diesen Patienten geben, Sertralin oder Citalopram? Da wusste ich Sertralin mit Herzerkrankungen bevorzugt werden sollte.

P: Sie bipolare Depression erwähnt, was geben wir zu den? / Lithium.

P: Was machen Sie, wenn Sie Lithium verschreiben? / Lithium kann schnell Intoxikationen verursachen. Deswegen würde ich Leber und Nierenwerte kontrollieren und EKG schreiben lassen.

P: Wenn Patient kommt und sagt dass er nicht mehr das alles aushalten. Wie gehen Sie vor? / Risikofaktoren (alt, männlich, akute Suizidalität --> Wünsche,

Gedanken, Handlungen, Suizid in der Familie, vorbestehende Strafverfahren, finanzielle Schwierigkeiten, Zugang zu einfachen Methoden wie Ärzten und Polizisten), Absprachefähigkeit und glaubhafte Distanzierung von Suizidalität (Handschütteln oder Patientenvertrag habe ich erwähnt).

P: Patient will nicht mehr leben, kann sich auch nicht distanzieren, was machen Sie in Hausarztpraxis? / Vor allen Zwangsmaßnahmen ist es wichtig, den Patienten freiwillige Möglichkeiten anzubieten. Wenn die Patienten das akzeptieren, dann schicke ich sie mit Notwagen ins Krankenhaus. Wenn nicht, dann rufe ich Polizei an, da ich in Praxis die Menschen nicht festhalten darf. Es ist wichtig die akut suizidalen Patienten nicht allein zu lassen.

P: Okay, wir haben noch bisschen Zeit. Es gibt noch eine Störung, die mit Depression häufig einhergeht, zwar Angst. Welche Angststörungen kennen Sie? / Phobien, Panickattacken und generalisierte Angststörung. Hier habe ich alle 3 grob beschrieben, er wollte noch wissen wie wir generalisierte Angststörung therapieren, ich habe gesagt, Psychotherapie und SSRI. Er meinte, SSRI eher nicht (weiß ich nicht warum) die Antwort war Expositionstherapie. Außerdem ist es wichtig die Menschen um diese Patienten auch zu therapieren, da sie auch eventuell Ängste entwickeln können.

Herr Wiehn war nett, hat versucht die Fragen gut zu erzählen damit ich verstehen kann was er hören will.

Chirurgie

P: Kennen Sie die Appendizitiszeichen? / (Hier habe ich mich sehr gefreut, da ich sie sehr gut kannte. Ich habe alle Zeichen gesagt und beschrieben was sie sind. Er sah bisschen überrascht aus. Das erwähne ich nur, weil ich denke alle Zeichen erwartet der Prüfer gar nicht, also kein Stress, wenn ihr alle nicht kennt.) Mc Burney, Lanz, Blumberg, Rovsing, für retrozökale Appendizitis Psoas und Baldwin, bei Frauen Douglas Zeichen noch dazu bei DRU.

P: Sehr gut. Eine Mutter kommt mit einer 12-jährigen Tochter, sie hatte gestern paraumbilikale Bauchschmerzen, hat auch erbrochen. Heute sind die Schmerzen im rechten Unterbauch, was denken Sie? / Appendizitis.

P: Ja, klassisches Klinikbild dafür. Alle Appendizitiszeichen sind auch positiv. Was machen sie für die Diagnose? / Abdomen Sono.

P: Sono ist unauffällig. Was würden die Amerikaner jetzt machen, was wir aber in Deutschland mit Kindern nie machen? / Da war ich wegen der Art von Frage bisschen verwirrt, da er hat es so verschrieben, als ob es illegal wäre. Ich dachte an DRU, weil die Patientin 12 Jahre alt war. Aber was er meinte CT. Ich wusste nicht, dass die Chirurgen in Deutschland bei Kindern gar keine CTs durchführen. P: Okay so keine CT. Was mache ich, ich bin ein Chirurg? / Dann habe ich verstanden, was er wollte, nämlich Laparaskopie

P: Genau, wenn Klinik passt, egal wenn Sono unauffällig ist, muss ich Laparaskopie machen. Okay. 70 jährige Patientin kommt mit unerträglichen Beinschmerzen zu Ihnen. Sie hat gestern in Garten gearbeitet und ihr Bein irgendwas angestoßen. Hat keine Wunde, Haut intakt, aber in Haut es gibt so groß (hat mit der Hand gezeigt) gräue Bereich. Wie gehen Sie vor? / Ich habe gesagt, Inspektion, pDMS, Röntgen für Fraktur.

P: Keine Fraktur. Was kann es sein, das sehr häufig übersieht wird aber unbehandelt mehr als 50% tödlich ist. / Ich wusste nicht, aber ich dachte könnte keine TVT oder pAVK ist, weil Beschreibung nicht passt. Nach bisschen Überlegung habe ich gesagt, nekrotisierende Faszitis vielleicht? Und es war richtig. Prüfer hat sich gefreut.

P: Welche apparative Diagnostik? / CT mit KM

P: Ja das ist gut aber erst was? / Sono

P: Genau, Weichteilen Sonografie.

Herr Hanisch war seriös aber hilft mit Hinweisen, erzählt nicht viel von sich selbst über das Thema, bevor man die richtige Antwort gibt.

Beschreibung der Vorbereitung/Empfehlungen: Ich habe mich im Mai 2025 für die Prüfung gemeldet, mein Wunschmonat war Dezember, habe den Termin im Januar 2026 erhalten. Also hatte ich insgesamt 8 Monate. Ich war schwanger und mein Plan war vor dem Baby zu lernen, was leider mir nicht gelungen hat, da mein Baby 2.5 Monate frühgeboren ist. Als er auf Intensivstation lag, konnte ich natürlich nicht lernen, war tatsächlich eine ganz schwierige Zeit. Nach seiner Entlassung habe ich im Ende Oktober langsam angefangen, was aber mit einem frühgeborenen Baby sehr unregelmäßig war. Ich kann sagen, dass ich im November ungefähr 2-3 Stunden am Tag aber nicht jeden Tag,

nachdem ich die Einladung bekommen habe, ab Dezember 5-6 Stunden am Tag gelernt habe. Letzte 10 Tage intensiver vielleicht 8-9 Stunden täglich.

Ich habe mich Anfang an mit Protokollen vorbereitet. Die habe ich ausgedruckt, wie ein Buch machen lassen und die Antworten auf die Fragen einfach gezielt an Seiten geschrieben.

Als Quellen habe ich Amboss, Chatgpt (Amboss Gpt) und PDF von Vorbereitung für Kenntnisprüfung (auch ausgedruckt und gelernt) benutzt, was ich im Telegram gefunden habe. Ich habe keinen Kurs besucht, keine

Privatunterrichten gemacht. 50 Fälle von EKG habe ich noch gelesen. Ich habe 2 Jahre in der Türkei bei Pädiatrie und 1 Jahr in Deutschland bei KJP gearbeitet.

Da ich zeitlich nicht in gutem Zustand war, habe ich mich entschieden, die Fragen von Allgemeinmedizin und Psychosomatik nicht zu lernen, bis ich die Einladung bekomme, was glücklicherweise in meinem Fall funktioniert hat, da ich als 3. Fach Psychosomatik bekommen habe. Diese Methode würde ich euch natürlich nicht empfehlen, aber falls ihr Zeitdruck und ein Baby habt, wie ich, vielleicht hilft das zumindest zu wissen, dass man es immer noch schaffen kann, wenn man sich Möglichkeiten sucht.

Da ich von Protokollen sehr profitiert, mich sogar einfach nach Protokollen orientiert habe, möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen herzlich bedanken, die ihre Erfahrungen mitgeteilt haben und natürlich bei Herrn Basel Naser, für die tolle Arbeit mit Prokollen, die praktisch mich gerettet hat.

05.01.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Psychosomatik
Weppner	Hanisch	Wiehn

Bei mir war der gleiche Fall,

Innere Medizin: Alles über arterielle Hypertonie und Vorhofflimmern.

Psychosomatik: Depression, Suizidalität und Hypochondrie.

Chirurgie: „Big Five“ Fall: Aortendissektion, ABCDE-Schema, was ist FAST, Fälle von Pneumothorax und Spontanpneumothorax sowie Beschreibung des Röntgenbildes beim Pneumothorax.

05.01.2026 Bad Nauheim Bestanden (2. Versuch)		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Akinci	Volkmann	Simons

Klinischer Fall: pAVK

Der 60-jährige Mann (183 cm groß und 120 kg schwer) stellte sich wegen seit 3 Monaten bestehender, zunehmender Schmerzen im rechten Unterschenkel vor. Die schmerzfreie Gehstrecke ist in diesem Zeitraum kürzer geworden (vor 3 Monaten: 500 m, aktuell: 100 m). Er macht eine kurze Pause, um die Schmerzen zu lindern, und läuft dann weiter. Zudem hatte er Taubheitsgefühle und Kribbeln im rechten Bein. Schmerzen sind auf NRS 7/10 angegeben. Es gibt keinen Ruheschmerz und keine Hautveränderungen. Es gibt keine LWS-Beschwerden und keine Kraftminderung. Keine Reiseanamnese und keine Immobilität. Vorerkrankungen: Arterielle Hypertonie, chronische Bronchitis

Vor-OPs: Appendektomie, irgendeine Fraktur (operativ versorgt) Vegetative

Anamnese: Unauffällig

Medikamente: Ramipril 2,5 mg 1-0-0

Noxen: Eine Schachtel Zigaretten pro Tag seit 40 Jahren, kein Alkohol

Familienanamnese: Unauffällig Beruf: LKW-Fahrer

KU: Dann habe ich dem Patienten gesagt, dass er sich auf die Liege legen und das rechte Bein freimachen soll. Ich habe meine Hände desinfiziert. Dann habe ich mit Vitalparametern angefangen. Den Puls habe ich beidseitig getastet (von den Carotiden bis zur Dorsalis pedis). Dann hat der Prüfer gesagt, dass auf der rechten Seite die Dorsalis pedis und die Tibialis posterior fehlen. Den Blutdruck habe ich einseitig gemessen und gesagt, dass ich ihn beidseitig messen werde. Danach habe ich mit der gezielten Untersuchung begonnen. Zunächst habe ich das rechte Bein untersucht (Blase, Haarverlust, trophische Veränderungen), dann habe ich mit pDMS begonnen. Ich habe die Muskelkraft und die Sensibilität überprüft. Anschließend habe ich kurz Herz, Lungen und Bauch untersucht. Danach habe ich gesagt, dass ich jetzt den ABI messen werde. Der Puffer hat mir ein Papier mit den systolischen Blutdruckwerten von beiden Armen und dem rechten Bein ausgehändigt. Ich muss den ABI messen und im Brief erwähnen. Anschließend habe ich BB, Entzündungswerte, Cholesterinwerte, Krea, Gerinnungsparameter und TSH-Wert angeordnet. Ich habe mit der medikamentösen Therapie mit ASS/Clopidogrel und Statinen begonnen, Gehtraining empfohlen, Tabakkarenz empfohlen und den Patienten

an einen Gefäßchirurgen überwiesen. Der Patient fragte nach dem weiteren Vorgehen. Ich musste ihn über die FKDS, die CT-A und die mögliche Stentimplantation als Therapieverfahren aufklären.

Dann war die Zeit um und ich habe mit dem Brief angefangen. Im Brief habe ich zusätzlich eine rasche Lagerungsprobe als weiteres Vorgehen genannt (sonst alles, was ich im praktischen Teil erwähnt habe). Ich empfehle euch, den Brief wenn möglich strukturiert zu schreiben (aktuelle Anamnese mit 3-4 Sätzen, andere Anamnese, Untersuchung und weiteres Vorgehen als Stichpunkte), sodass ihr einen guten ersten Eindruck bekommt.

Chirurgie

1. 80-jährige Frau im Altenheim auf dem Boden liegend aufgefunden und mit RTW ins Krankenhaus gebracht. Sie sind die aufnehmende Ärztin in der Notaufnahme

Bild von einer liegenden Patientin mit Schürfwunde am linken Hüftgelenk sowie am linken Kniegelenk. Die Patientin war sonst mobil, hat aber Demenz. Was vermuten Sie: Proximale Femurfraktur. Diagnostik: Röntgen- er zeigte Röntgenbild von proximaler Femurfraktur. Weiteres Vorgehen: Operativ- warum machen Sie eine OP bei einer so alten Patientin: Aufgrund möglicher Komplikationen wie Thromboembolie, Pneumonie, Dekubitus...

Richtig. Jetzt kam der Anästhesiologe und sagte, die Patientin nehme Marcumar ein. Was machen Sie jetzt: Hier war ich bisschen verwirrt und sagte das Marcumar pausiert und eine frühelektive OP durchgeführt werden sollte. Daraufhin sagte er, ob ich alle Komplikationen, die ich genannt habe, erlitten lassen möchte. Die brauchen nicht viel Zeit, um sich zu entwickeln. Da habe ich gesagt, dass ich die OP durchführen werde und dass ich PPSB oder Vitamin K geben kann. Er sagte, dass der Chirurg weitere Blutungen schon stillen kann.

2. 1-jähriges Kind kommt mit Vater, Kind im Schule auf die rechte Seite gestürzt. Bild von Kind mit rechtem Arm in Schonhaltung. Was vermuten Sie: Distale Radiusfraktur- Ja, was noch: Suprakondyläre Humerusfraktur- Ja, Röntgenbild einer suprakondylärer Humerusfraktur gezeigt. Wie behandeln Sie es: K-Draht Osteosynthese-Richtig. Welche Komplikationen können bei diesem Verfahren auftreten: Nervenverletzung. Welche- Nervus ulnaris. Fragen zum klinischen Bild bei einer Verletzung des Nervus ulnaris, Nervus medianus und Nervus radialis.

3. Bild von einem Fußballspieler im Fußballfeld mit Sprunggelenkfraktur. Was vermuten Sie: Sprunggelenkfraktur. Röntgen gezeigt-Diagnose: Bimalleoläre Sprunggelenkluxationsfraktur (hier Luxation war der Schlüsselwörter). Was ist am wichtigsten in diesem Fall, was muss zuerst gemacht werden: Reposition am Ort. Warum machen wir Reposition am Ort bei Sprunggelenkluxationsfraktur: Gefahr von Nekrose (Er hat hinzugefügt, dass der Hautnekrose ist der Komplikation)

4. 14-jähriges Mädchen kam mit ihrer Mutter, klagte über Schmerzen im rechten Unterbauch. Zusätzlich Fieber, Erbrechen und Übelkeit. Weiteres Vorgehen: Vitalparameter und klinische Untersuchung- Außer Druckschmerzen im rechten Unterbauch war alles unauffällig. Welche diagnostischen Verfahren: Blutbild, CRP, Schwangerschaftstest. Mögliche Differenzialdiagnosen: akute Appendizitis, Harnwegsinfekt und Meckel- Divertikulitis.

Allgemeinmedizin

Er fragt immer mit Bildern und man muss Blickdiagnose nennen

1. Morbus Dupuytren (Bild): Was ist das: Kontraktur der palmaren Aponeurose. Wie wird sie behandelt: Überweisung zum Handchirurgen, ggf. operative Release der Kontrakteure.

2. Bild von einer einseitigen Fazialisparese (Mundwinkel auf der Gegenseite), Typen: Zentrale und periphere. Die Unterschiede zwischen zentraler und peripherer Fascialisparese: Das Stirnrunzeln ist bei zentraler Parese intakt.

3. Bild von einem Keloid in der Schulterregion nach einer OP wegen Hautkrebs bei einem Hautarzt: Diagnostizieren, Definition. Kann der Patient in diesem Fall dem Hautarzt vorwerfen, dass er falsch behandelt hat, was zur Bildung eines Keloids bei der Patientin geführt hat? Nein, manche Leute haben eine Tendenz, eine hypertrophische Narbe oder nach einer OP ein Keloid zu entwickeln.

4. Fall: Ein älterer Mann mit Typ-2-Diabetes mellitus hat beim Gartenarbeiten zu Hause plötzlich geschwitzt, war verwirrt und ängstlich. Sie haben ärztliche Bereitschaftsdienst und seine Frau ruft ihnen an. Sie zeigt Ihnen einen Medikationsplan (dann zeigt er mir einen Medikationsplan). Auf dem Plan stehen Metformin, Bisoprolol, Allopurinol, Ramipril und Insulin. Ich musste die Gruppe der Medikamente nennen. Dann fragte er: „Was machen Sie jetzt?“

„Hausbesuch machen.“ Verdachtsdiagnose: Hypoglykämie. Sie überprüfen den Zuckerwert und zeigen LO an (wenn der Blutzucker zu niedrig ist, wird LO auf dem Glucosemeter angezeigt). Können Sie die Blutzuckerwerte schätzen? Ich habe gesagt, dass er weniger als 40 mg/dl sein könnte. Er hat korrigiert: „Ja, ...“ Es kann auch weniger als 20 mg/dl sein. Was machen Sie jetzt? Wenn er etwas oral einnimmt, Traubenzucker, ansonsten Glucose 40 %, 20–60 ml, und danach eine Infusion mit Glukose 5 %.

4. pAVK Stadium nach Fontaine im Detail.

5. ABI: Systolischer RR im rechten Arm: 110 mmHg, systolischer RR im rechten Unterschenkel: 220 mmHg. ABI ausrechnen- 2. Diagnose: Mönckeberg-Mediasklerose bei Diabetes mellitus. Warum ist der ABI hier mehr als 1,2?

6. Bild von EKG-Veränderungen in verschiedenen Stadien eines STEMI. Der Patient kommt zu Ihnen nach einem abgelaufenen STEMI mit persistierenden ST-Hebungen, ist aber symptomlos. Diagnose: Herzwandaneurysma. Ist das gefährlich? Muss das behandelt werden? Ja, es kann eine Quelle für Thromben sein, führt zu Herzinsuffizienz, Ruptur. Was machen Sie in diesem Fall: Überweisen den Patienten zum Kardiologen. Er hat zugestimmt und gesagt, dass es medikamentöse und chirurgische Verfahren gibt, aber das entscheidet der Kardiologe.

4. EKG von Bigemini

5. Bild des medialen Oberschenkels mit Thrombophlebitis (Varizen und oberflächliche Rötung). Diagnose? Welche Gefäße sind betroffen? Welche Anatomie haben die oberflächlichen und tiefen Beinvenen und wie werden Varizen behandelt? Welche Untersuchungen sind vor dem Stripping wichtig? Die tiefen Venen müssen auf Durchgängigkeit überprüft und eine Thrombose muss ausgeschlossen werden.

Innere Medizin

1. Zuerst über den Fall (pAVK)-Risikofaktoren: Arteriosklerose, bzw. beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren habe ich detailliert

erklärt. Der Patient hat arterielle Hypertonie, erhöhte Cholesterinwerte und wiegt mehr als 100 kg, Diagnose: Metabolische Syndrom. Ja, richtig, welche KH kann er noch haben? DM. Dann wurde alles über Diabetes mellitus gefragt: Diagnose, wie unterscheidet man diagnostisch zwischen Typ 1 und Typ 2 (C-Peptid-Bestimmung) und Antidiabetika (Wirkung und Nebenwirkung) ausführlich. Dann hat er über exokrine Pankreasinsuffizienz gefragt - Klinik: Diarrhoe und Steatorrhoe. Welche Diagnostik: Messung der Elastase-1-Konzentration im Stuhl. Therapie: Substitution von pankreatischen Enzyme

2. EKG: AVNRT-Therapie: Zuerst Vagusreizung, Valsalva-Manöver, danach medikamentös mit Adenosin und danach langfristige Therapie mit EPU und Katheterablation.

3. Röntgenthorax-Befund: Schritt für Schritt befunden. Es gab einen Schrittmacher. Dazu noch beidseitige Pleuraergüsse, gestaute Lungenvenen, eine Vergrößerung der Hilus, keine Kardiomegalie. Diagnose: kardiale Dekompensation, er hat zugestimmt und nach der Therapie gefragt: nachlast- und vorlastsenkende Medikamente.

4. Fall: Patient mit erniedrigtem TSH, erhöhtem T3 und T4. Welche Werte möchten Sie noch bestimmen? Thyreoid-Antikörper. Ja, es handelt sich um Morbus Basedow. Wie behandeln Sie ihn? Medikamentös mit Beta-Blockern und Thionamiden, Radiojodtherapie und Thyreoidektomie.

Dann wurde ich gebeten, draußen zu warten, und nach 1–2 Minuten wurde mir mitgeteilt, dass ich die Prüfung bestanden habe.

Vorbereitung/Empfehlungen: Die Vorbereitungszeit ca. 1-1.5 Jahre, allerdings nicht regelmäßig, da ich parallel gearbeitet habe. Ich habe den Kurs von Valeria besucht. Hauptsächlich habe ich mit den Skripten von Valeria gelernt. Da bei meinem ersten Versuch der praktische Teil sehr schwierig für mich war, habe ich zusätzlich den Tag in Praxis bei Valeria absolviert. Dies kann ich besonders denjenigen empfehlen, die Angst vor dem praktischen Teil haben. Valeria und ihre Kolleginnen bereiten gezielt und sehr praxisnah auf den praktischen Prüfungsteil vor. Als weitere Lernquelle habe ich für einzelne Themen und insbesondere für Bilder AMBOSS genutzt. Wenn man wenig Zeit hat, um alle wichtigen Themen ausführlich zu lernen, kann ich außerdem die Lernkarten für den mündlichen STEX empfehlen. Ich würde dringend empfehlen, mit einem Lernpartner zu lernen und – wenn möglich – den praktischen Teil gemeinsam zu üben, damit man am Prüfungstag sicherer ist und weniger Angst hat. Die Prüfungsprotokolle von Kolleginnen und Kollegen waren für mich extrem

hilfreich, insbesondere die prüferspezifischen Fragenprotokolle. Ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die ihre Prüfungserfahrungen in der Gruppe geteilt haben. Besonderer Dank gilt Herrn Basel Naser für seine hervorragende Arbeit mit den Protokollen sowie Valeria für den großartigen Kurs und die sehr gut strukturierten Skripte – absolut empfehlenswert und vollständig prüfungsorientiert.

Ich schreibe hier auch die erste Prüfung, die ich abgelegt und nicht bestanden habe; wer möchte, kann einen Blick darauf werfen:

Ich habe meinen 1. Versuch der KP am 06.03.2025 in Marburg abgelegt. Die Prüfungskommission bestand aus **Dr. Grimm** (Innere Medizin und Vorsitz), **Dr. Meyer** (Chirurgie) und **Dr. Brenck** (Allgemeinmedizin).

Klinischer Fall: GERD

Die Prüfer saßen hinter einer schwarzen Glaswand. Vor dem Untersuchungsraum hing ein Schild mit der Information: "Frau Weimer kommt mit Thoraxschmerzen".

Die Patientin hieß Annette Weimer, war 35 Jahre alt und von Beruf Sozialpädagogin.

Sie stellte sich wegen seit der vorherigen Nacht bestehenden Brustschmerzen vor. Die Schmerzen waren brennend und wurden mit 4/10 auf der NRS angegeben. Sie hatte keine Atemnot, kein Schwitzen, keine Übelkeit, kein Erbrechen und keinen Durchfall. Zuerst ließ ich ein EKG schreiben, das unauffällig war. Die Patientin berichtete, dass sie am Vortag fettig gegessen und Alkohol getrunken hatte. In meinem Kopf entstand dadurch früh der Verdacht auf eine GERD. Die Reiseanamnese war unauffällig. Die Patientin hatte keine Schmerzmittel eingenommen. Vorerkrankungen, Familienanamnese, Allergien und Unverträglichkeiten waren unauffällig. Sie trinkt etwa 2x/Woche Alkohol und raucht seit mehreren Jahren 1 Packung Zigaretten tgl.

KU: Die VP waren unauffällig. Bei der KU habe ich nur das Abdomen untersucht, welches ebenfalls unauffällig war. Die Untersuchung von Herz und Lunge, die bei Thoraxschmerzen wichtig gewesen wäre, habe ich leider nicht durchgeführt. Das war rückblickend ein großer Fehler und ist wahrscheinlich durch den Stress in der Prüfung passiert. Als weitere Diagnostik habe ich ein

Blutbild und Entzündungswerte veranlasst, die ohne Auffälligkeiten waren. Eine Troponinbestimmung, die bei Brustschmerzen eigentlich notwendig ist, habe ich ebenfalls nicht angeordnet. Ich habe für die Patientin eine Therapie mit Pantoprazol 40 mg einmal täglich für eine Woche begonnen und sie zur weiteren Abklärung an einen Gastroenterologen überwiesen. Im Arztbrief schrieb ich als Verdachtsdiagnose eine Refluxösophagitis / GERD. Als Differenzialdiagnosen nannte ich: akute Cholezystitis, akute Appendizitis, akutes Koronarsyndrom. Als weiteres Vorgehen erwähnte ich unter anderem Trop T und eine ÖGD. Während des gesamten praktischen Teils war ich sehr angespannt, wodurch ich mehrere wichtige Punkte übersehen habe.

Allgemeinmedizin

1. 2-jähriges Kind mit Fieber: DD- Zunächst habe ich an eine Otitis media gedacht. Dann wurde die Beschreibung des Trommelfells bei Kindern in der Otoskopie gefragt. Weiteres Vorgehen: Racheninspektion. Er möchte eine EBV-Tonsillitis hören.
 2. Bild eines Fußes einer älteren Frau mit Hallux valgus, Varizen und Spreizfuß- ich musste alles erkennen. Definition des Spreizfußes.
 3. Impfungen im Altersheim: Influenza, COVID-19, Herpes zoster, Pneumokokken und RSV.
 4. (Seit August 2024 empfiehlt die STIKO allen Personen ab 75 Jahren eine RSV-Impfung!)
-

Chirurgie

1. 65-jähriger Mann mit chronischem Reizhusten: DD-Bronchialkarzinom, COPD.
2. Diagnostik: Röntgen-Thorax und CT-Thorax. Er hat eine CT-Thorax mit zentrale Raumforderung in der rechten Lunge gezeigt. Weiteres Vorgehen: Biopsie mit Nachweis eines NSCLC, danach TNM-Staging, Tumorkonsil und Therapieentscheidung.

3. 70-jähriger Mann mit starken Rückenschmerzen: Vorgehen - EKG, VP. Der Patient war im Schock. Fragen zum Schockmanagement. Weitere Diagnostik - CTA- Aortendissektion-Therapie der Aortendissektion.

4. Röntgen-Abdomen mit freier Luft: Vorgehen bei einer Hohlorganperforation.

Innere Medizin

1. Big Five der Thoraxschmerzen, KU bei Perikarditis und Pneumothorax

2. EKG: Vorhofflimmern bei einem 75-jährigen Mann - Therapie: Thromboembolieprophylaxe, Frequenzkontrolle, Rhythmkontrolle; mehr nicht.

3. 75-jähriger Mann mit Lungenödem: Therapie des akuten Lungenödems.

4. Chronische Nierenerkrankung: 5 wichtigste Ursachen - DM, aHT, zystische Nierenerkrankungen, Glomerulonephritis und tubulointerstitielle Erkrankungen.

5. Einteilung nach GFR; Definition der GFR und der arteriellen Hypertonie.

6. EKG mit AV-Block II. Grades: Ursachen. Er möchte unbedingt die reversiblen Ursachen wie Borreliose und Betablocker hören.

Nach einer kurzen Wartezeit wurde mir mitgeteilt, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Die Prüfer erklärten, dass der praktische Teil sehr schlecht gewesen sei, auch wenn der mündlich-theoretische Teil insgesamt gut gelaufen ist.

09.02.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Psychosomatik
Voswinkel	Hanisch	Akinci

Klinischer Fall: Bronchialkarzinom

Der 60 jähriger Patient Herr Müller stellte sich wegen seit 3 Tage plötzlich einsetzender dumpf rechtseitiger ohne Ausstrahlung Thoraxschmerzen vor. Er berichte auch über Dyspnoe aber leidet an COPD. Keine B Symptomatik. Die Schmerzintensität wird auf 5,6/10 auf NRS angegeben. Wasserlassen und Stuhlgang unauffällig. Raucher seit 30Jahre (1 Pack/Tag). Keine Drogen. Alkohol regelmäßig.

Gewicht: 105 Kg Größe: 1.60cm

Vorerkrankungen: COPD, Arterielle Hypertonie, Diabetes Mellitus Typ II

Medikamente: Ramipril 5mg 1-0-0 , HCT: 25mg 1-0-0 , Metformin 500mg 1-0-0

Impfstatus vollständig.

Reise Anamnese unauffällig

Familienanamnese: 2 gesunde Kinder, Vater pAVK, Mutter TVT.

Beruf: Lackierer, Maler

KU: alles war unauffällig aber ich habe etwas positiv geschrieben bei der Lungenuntersuchung wegen der Raumforderung.

Labor/Bildgebung: Mir wurde gefragt, welche Labor- und bildgebenden Verfahren ich indizieren soll. Dann habe ich Zettel bekommen.

Hb: 14

Leuco:13.000

GPT: 44

GOT: 46

Harnstoff: 9,6 (Ich habe ihm nach Gicht gefragt, und er hat gesagt, ein Mal hatte ein Gichtanfall aber aktuell keine Symptome mehr)

EKG: unauffällig

CT Thorax: Raumforderung im rechten Unterlappen (war dann klar die Diagnose)

Dann Patienten-Aufklärung und ins Krankenhaus überweisen.

Innere Medizin

Zuerst Fragen zum Fall:

Welche andere DD kann ich nennen? Tuberkulose, Abszess, Empyem. Er wollte Metastasen hören.

Welche Tumoren können in der Lunge metastasieren? Prostata, KRK, Haut

Welche Tumormarker für Prostatakarzinom? PSA

Welche Tumormarker bei Lungenkarzinom? Cyfra 21-1 und NSE

Was bedeutet NSE? Neuronenspezifische Enolase

Histologische Klassifikation von Lungenkarzinom (kleinzelliges und nicht kleinzelliges)

Und nicht kleinzelliges? (Adeno, Platten und Großzelliges Karzinom)

Welches ist häufige bei nicht Raucher? Adeno

Welches kann der Patient haben? Platten (Er ist raucher)

Keine Frage nach Therapie

Er hat mir ein EKG gezeigt: VHF bei Tachyarrhythmie absoluta (typisch und klar)

Dann Therapie von VHF (Thromboseprophylaxe nach CHADS₂VASC₂Score, Frequenz- und Rhythmuskontrolle) ok das ist richtig, aber was machen wir zuerst? Ich sagte nach Vorerkrankung, Medikamente, Allergien fragen. Er sagte, ja, das stimmt was noch? Mir ist in diesem Moment nicht aufgefallen, dann hat er gefragt, was passiert bei VHF? Thromboembolien. Und Was noch, was kann dann passieren? Mesenterialischämie, akuter arterieller Verschluss, Schlaganfall und so weiter. Und dann, was machen wir vor der Therapie? Jetzt habe ich gesagt ECHO zum Ausschluss von Thromben, GENAU. Welche ECHO am besten? TEE, sehr gut.

Dann Welche Thromboseprophylaxe? UFH unter aPTT Kontrolle. Ja das stimmt aber braucht man viele Kontrollen, welche andere Möglichkeit? NMH. Welche? Enoxaparin. OK, was Noch. NOAK. Welche? Apixaban, Rivaraxoban. Dann hat er die andere 2 genannt und hat gefragt welche Mechanismus NMH? Hemmung Faktor Xa. Und NOAK? Hemmung Faktor Xa. Und was noch hemmt, Dabigatran? Hemmt Faktor IIa. OK

Welche Medikamente bei Frequenzkontrolle? B-Blocker Metoprolol. Wann darf nicht B-Blocker geben? Bei Asthma und COPD. Er sagt na ja, bei COPD kann man vorsichtig geben aber bei Asthma unbedingt nicht. OK der Patient leidet an Asthma, welche andere Möglichkeit? Ca-Antagonisten. Welche? Verapamil Typ. Richtig, Der Patient kann nicht Verapamil, welche andere? Amiodaron.

Ja es ist möglich aber wir benutzen andere Möglichkeit, welche. Digoxin wollte er hören. Dann, was kann Amiodaron verursacht? Verlängerung der QT-Zeit.

Was geben wir für Rhythmuskontrolle? Flecainid oder Propafenon. Was noch? Elektrische Cardioversion. OK

Dann hat er einige Bilder gezeigt: Caput Medusae, Spieder naevi, und Palmar Erythem. Was ist das? Leberhautzeichen. Welche Krankheit? Leberzirrhose. OK

Welche anderen Hautzeichen kannst du nennen? Plantarerythem, Weißnägel, Gynäkomastie, Magenfundus-, Ösophagusvarizen wegen portaler Hypertension....

Welches Medikament kann eine portale Hypertension senken? Propranolol.

Komplikation einer Leberzirrhose? Aszites mit SBP. Wie kann man Diagnostiziert? Aszitespunktion und Analyse. Er wollte hören erhöhte Neutrophilenzahl >250 Zellen.

Dann Diabetes Mellitus Typ I. Diagnose. Was passiert? Wie kann man diagnostiziert? Wie ist pH, Bicarbonat. Was kann man geben? Was passiert wenn ein Patient mit DM Typ I kein Insulin mehr benutzt? Hyperkaliämie, Hyperglykämie, Kussmaul...er wollte diabetische Ketoazidose hören.

Wann müssen wir Metformin nicht geben? Wie soll GFR sein? Ich habe gesagt GFR>60 können wir geben. Er sagt genau. Und unter 50 nicht geben wegen Risiko Laktatazidose.

Psychosomatik

Sie fängt mit langen Geschichte an. Besser so bis zum Ende lassen und so gewinnen wir Zeit. Obwohl am Ende man nicht weiß, was sie hören will.

So, lange Geschichte eine Frau mit Depression. Diagnose. Haupt-, Nebenkriterien. Klassifikation. Wann ist leicht, mittelschwer und schwer. Wann geben wie Medikamente und Welche (SSRI) Beispiel (Citalopram, Sertralin).

Andere lange Geschichte, war Suizidalität. Sie wollte Risikofaktoren, wohin schicken wir den Patienten. Was sollen wir den Patienten fragen? (Direkt nach Suizid, und Suizid in der Vorgeschichte).

Andere lange Geschichte ein Mann, der allein wohnt, an Diabetes leidet und geht in der Praxis um ein Metformin Rezept abzuholen aber organisiert alles heftig und hat Angst: Ich habe Hypochondrie gesagt, somatoforme Störung. Und dann hat sie gefragt welche somatoforme Störung kenne ich. Die Einteilung, das wusste ich nicht. Und dann hat sie gesagt, das ist tief und kompliziert. Dann warum hat sie gefragt? Keine Ahnung. Ich habe gesagt, anhaltende somatoforme Schmerzstörung, Hypochondrische Störung, Somatisierungsstörung. Und sie sagte, das ist richtig aber gibt's andere Klassifikation. Also keine Ahnung aber nichts schlimmes, müssen wir das nicht wissen. Am Ende wollte sie Panikstörung hören (Also der Fall war nicht somatoforme Störung, sondern Panikattacke, na ja). Dann hat sie gefragt, was soll ich in der Praxis machen. Ich habe gesagt nach Suizidfragen haha, sie sagte ja, man muss auch mit dem Patienten unterhalten. Und welche Medikamente geben wir. Benzodiazepin. Welche? Lorazepam, Diazepam. Wie lang? Kurzfristig. Warum? Risiko Abhängigkeit. Ok gut.

Dann fragt Sie, Welche Medikamente geben wir den Patienten, das schnell wirkt. Ich habe gesagt, kann man Johanniskraut geben. Sie sagte, ja, das ist eine Option. Welche NW? Photosensibilität, gastrointestinale Beschwerden. Ok super. Welche andere kann man geben. Ich habe Lithium gesagt. Sie sagte nein. Dann habe ich gesagt, keine mehr. Weil die antidepressiva erst nach 3 Woche wirken. Und Benzodiazepine nur kurzfristig geben. Sie stimmt mir zu.

Chirurgie

Definition akutes Abdomen. Welche Zeichen (Abwehrspannung, Druckschmerzen, Loslassschmerzen, Resistenten). Ok, Was ist Abwehrspannung (Anspannung der Bauchmuskulatur). Welche Muskulatur (M. rectus abd) Warum passiert das? Reizung des Peritoneums. Wie heißt das? Peritonitis. Also alle Fragen von Protokoll gar nix neues.

Welchen Begriff in diesem Fall? Ich wusste nicht was er meinte, obwohl die Antwort einfach war, er sagte ich weiß es doch: bretthartes Abdomen. Na ja ich weiß, das Problem ist wie er die Frage formuliert, aber war nicht schlimm.

Dann Welche andere Zeichen können wir bei akutem Abdomen überprüfen? Appendizitiszeichen. Welche und Erklärung. Wie können wir ein akutes Abdomen diagnostiziert? Ich habe mit Anamnese, KU, Labor gesagt, er wollte

direkt US hören. Dann hat ein Bild gezeigt, ich musste nur Korkadephänomen sagen.

Dann fragt, was können wir mit der KU diagnostizieren? Totenstille bei Paralytisches Ileus, hochgestellte klingende Geräusch bei Mechanischem Ileus. Dann fragt er wann ist normal, wollte hören glucksende Geräusche in allen Quadranten. Dann Intra- und extraperitoneale Ursachen ein Akutes Abdomen.

Ich habe viele genannt und auch akutes Skrotum und er sagte das wäre sehr schlimm aber selten in erwachsenem Alter. Dann fragt er danach. Wie können wir das diagnostizieren, Prehn Zeichen. Wie? und dann welche Komplikation: Nekrose. Was passiert, wenn ein Arzt nicht schreibt in der KU, im Brief, bei Akutes Abdomen, oder vergisst Skrotum zu untersuchen und dann das Kind verliert das Skrotum wegen Nekrose. Also die Eltern verklagt den Arzt, wollte er hören. Er hat gefragt welche Schock am häufigsten bei Akutem Abdomen: Septisch. In Welche Gruppe ist der Septischer Schock (distributiv) Welche andere Schock kenne ich. Beispiel bei Obstruktivem Schock, 3 wichtigste: LAE, Spannungspneumothorax und Perikardtamponade. Und typische Frage von Herr Hanisch, was ist Sepsis.

Vorbereitung/Empfehlungen: Ich habe zuerst drei Monate lang den FIA-Kurs gemacht, das war ein Zeitverlust. Danach habe ich den gesamten Valeria-Kurs besucht, und ehrlich gesagt: Man braucht nicht mehr – Valeria ist mehr als genug. Danke, Valeria. Ich habe den Kurs sogar zweimal gemacht, weil ich vorher keinen Termin hatte. Das war mein erster Prüfungsversuch. Ich habe auch Amboss ab und zu benutzt, nur um gezielt Dinge nachzuschlagen. Meine Empfehlung ist, nicht allein zu lernen. Lernt immer in kleinen Gruppen oder mindestens mit einer Kollegin bzw. einem Kollegen. Ich hatte tolle Kolleginnen, und wir haben uns bis zum Ende Mühe gegeben, sehr vielllllll geübt und wiederholt, vor allem in den letzten vier Wochen. Und wir alle haben die Prüfung geschafft.

09.02.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Psychosomatik
Voswinkel	Hanisch	Akinci

Klinischer Fall: Brustschmerzen

Eine 60-jährige Patientin stellte sich mit seit vier Tagen bestehenden dumpfen thorakalen Schmerzen vor. Es bestand keine Ausstrahlung. Begleitend berichtete sie über Dyspnoe, weitere Symptome wurden verneint. Aufgrund der Konstellation unterbrach ich die Anamnese und erklärte, dass zunächst eine akute kardio-pulmonale Abklärung erforderlich sei. Ich veranlasste:

- ein 12-Kanal-EKG
- eine Blutentnahme, insbesondere Troponin und D-Dimere

Das EKG zeigte einen Rechts-schenkelblock sowie einen AV-Block Grad I, insgesamt ohne akute Gefährdung.

Anschließend plante ich ein Thorax-Röntgen. Dr. Voss wies darauf hin, dass kein Röntgen-Thorax, sondern ausschließlich ein CT-Thorax zur Verfügung stehe. Daraufhin befundete ich das CT entsprechend.

Im Anschluss führte ich eine vollständige körperliche Untersuchung durch, einschließlich:

- Inspektion und Auskultation von Herz und Lunge
- Abdomen
- systematische Lymphknotenuntersuchung (zervikal, supraklavikulär, axillär)
- Beurteilung des Allgemeinzustands und der Vitalparameter

Die körperliche Untersuchung war unauffällig.

Innere Medizin

a) Differentialdiagnosen und Vorgehen zum Thoraxschmerz-Fall

Wir besprachen die Differentialdiagnosen thorakaler Schmerzen und ich erklärte mein Vorgehen von der Erstbeurteilung über Diagnostik bis zur Therapie/Weiterleitung (inkl. relevanter Red Flags, EKG/Labor/Röntgen, Verlauf und ambulante Weiterbetreuung).

b) Diabetes mellitus – Typen, Antidiabetika, Hypo-/Hyperglykämie

Anschließend wurde Diabetes thematisiert:

- Überblick über Diabetes-Typen
- Überblick über Antidiabetika und NW .

Wir besprachen Gefahren bei Entgleisungen:

- Hypoglykämie: akute neurologische Gefährdung (Bewusstseinsstörung, Krampf, Koma), v. a. sofort behandlungsbedürftig
- Hyperglykämie: je nach Konstellation DKA oder hyperosmolares Syndrom (HHS), Dehydratation, Azidose (bei DKA)

c) Kollaps auf der Straße – Akutmanagement

Es wurde ein Fall mit plötzlich kollabierter Person besprochen. Ich schilderte mein Vorgehen nach ABCDE:

- Eigenschutz, Hilfe holen/Notruf
- Vitalfunktionen prüfen, Bewusstsein/Atmung/Kreislauf beurteilen
- Blutzucker als schnelle, entscheidende Diagnostik
- Suche nach Hinweisen: Diabetes-Ausweis, Medikamente/Insulinpen, Begleitpersonen (Fremdanamnese)
- je nach Zustand: präklinische Versorgung und Transport in die Notaufnahme / Übergabe Rettungsdienst

Therapieprinzipien bei Hypoglykämie und bei DKA/HHS wurden besprochen (z. B. Glukosegabe vs. Volumen/Insulin/Elektrolyte unter Monitoring).

d) Synkope

Danach: ältere Patientin mit Synkope. Wir besprachen die wichtigsten Ursachen (z. B. kardial/arrhythmogen, orthostatisch, vasovagal, neurologisch/sonstige) und wie man die Ursache eingrenzt (Anamnese,

Medikamentenanamnese, Orthostase, EKG, ggf. Labor, weitere kardiologische Abklärung).

Im EKG zeigte sich ein AV-Block III°. Ich erklärte, dass zuerst die Stabilität beurteilt wird:

- instabil: sofortige Akuttherapie (z. B. Atropin je nach Situation, transkutanes Pacing, Katecholamine, Notfallmanagement)
- stabil: Überwachung, Ursachenklärung, kardiologische Vorstellung; dauerhaft meist Schrittmacherindikation

Psychosomatik

1) Wir sprachen über die Patientin aus dem vorangegangenen Teil und worauf zu achten ist:

- mögliche Anpassungsstörung
- mögliche depressive Episode
- Abklärung von Suizidalität (Gedanken, Absichten, Plan, Mittel, Schutzfaktoren)

2) Depression – Symptome und Schweregrade

Es folgten Fragen zu Merkmalen der Depression. Ich nannte die typischen Symptome (Affekt, Antrieb, Interessenverlust, Schlaf, Appetit, Konzentration, Schuld, Zukunftsperspektive, Suizidgedanken etc.).

Auf Nachfrage erklärte ich die Einteilung in leicht, mittelgradig, schwer und ordnete die Patientin eher leicht bis mittelgradig ein.

Therapie und Vorgehen:

- ambulante/teilstationäre/stationäre Behandlung je nach Schweregrad, Funktionsniveau und Suizidalitätsrisiko
- Psychotherapie (z. B. kognitive Verhaltenstherapie)

- ggf. Antidepressiva inkl. Aufklärung über Nebenwirkungen und Verlauf

3) 18-jährige Patientin – Verdacht auf Essstörung (Anorexia nervosa)

Fall: 18-jährige Patientin kommt mit der Mutter, Mutter berichtet, dass die Tochter „nicht isst“.

Mein Vorgehen:

- umfassende Anamnese (Essverhalten, Gewichtsverlauf, Körperbild, Erbrechen/Laxantien, Sport, Zyklus, psychische Belastung)
- körperliche Untersuchung und Gewicht/Größe, Berechnung BMI = Gewicht (kg) / Größe² (m²)
- bei deutlich niedrigem BMI und passender Psychopathologie Verdacht auf Anorexia nervosa

Bei der körperlichen Untersuchung erwähnte ich mögliche Zeichen einer Essstörung,

Diagnostik:

- Labor inkl. Blutbild und Elektrolyte (v. a. Kalium, Phosphat, Magnesium) wegen Risiko für Arrhythmien und Komplikationen, außerdem ggf. weitere internistische Abklärung je nach Befund.

4) Alkohol – Laborbefund und Entzug

Letzter Fall: Patientin mit hohem Alkoholkonsum. Im Labor waren Leberwerte auffällig, außerdem ein erhöhtes MCV als Hinweis auf chronischen Alkoholabusus. Wir besprachen:

- Kriterien einer Alkoholabhängigkeit
 - Entzugssymptome und Risiken
 - Prinzipien der Entzugsbehandlung und weiterführenden Therapie (Entgiftung, Motivation, Rückfallprophylaxe)
-

Chirurgie

a) Pneumothorax / Spannungspneumothorax (Definition, Pathophysiologie, Vorgehen)

Wir besprachen Pneumothorax-Formen (traumatisch vs. spontan; offen vs. geschlossen; Spannungspneumothorax).

Definition/Pathophysiologie:

- Pneumothorax: Luft im Pleuraspalt → Lungenkollaps (teilweise oder komplett).
- Spontaner Pneumothorax: ohne Trauma (primär z. B. bei apikalem Bulla/Riss; sekundär z. B. bei COPD).
- Spannungspneumothorax: Ventilmechanismus → zunehmend intrapleuraler Druck, Mediastinalverlagerung, Behinderung des venösen Rückstroms → obstruktiver Schock (lebensbedrohlich).

Diagnostik/Klinik:

- Klinik: akute Dyspnoe, pleuritische Thoraxschmerz, Tachykardie; ggf. Hypotonie und gestaute Halsvenen bei Spannungspneumothorax.
- Körperliche Untersuchung: einseitig vermindertes Atemgeräusch, hypersonorer Klopfeschall, ggf. Zyanose.
- Bildgebung: Thorax-Röntgen zur Bestätigung bei stabilem Patienten.

Bei klinischem Spannungspneumothorax gilt: Therapie sofort, keine Verzögerung durch Röntgen.

Therapie:

- Bei Verdacht auf Spannungspneumothorax: sofortige Nadelentlastung (Notfallentlastung) und anschließend Thoraxdrainage.
- Drainage-/Punktionspunkte wurden besprochen:

o Monaldi-Position (v. a. Entlastung/Punktion, klassisch 2. ICR medioklavikulär .

o Bülow-Position (Thoraxdrainage, typischerweise 4.–5. ICR vordere/mittlere Axillarlinie im „safe triangle“)

Außerdem wurde thematisiert, welche Befunde man in der Auskultation erwartet und in welchen Situationen man zuerst ein Röntgen anfertigt (stabil) vs. sofort behandelt (klinisch instabil, Spannung).

b) Aortendissektion (Anamnese, körperliche Untersuchung, Therapieprinzip)

Als zweite Frage wurde die Aortendissektion besprochen.

Worauf achten (Anamnese):

- Vernichtungsschmerzen zwischen den Schulterblättern , plötzlicher, oft Rücken/Inter-skapularbereich
- Risikoprofile: Hypertonie, bekannte Aortenaneurysmen..

Körperliche Untersuchung / Auffälligkeiten:

- Blutdruckdifferenz zwischen Armen, asymmetrische Pulse
- neue Herzgeräusche (z. B. Aortenklappeninsuffizienz)
- Zeichen der Minderperfusion (neurologische Defizite, Bauch-/Nierensymptome, Extremitätenischämie)

Ich erwähnte, dass Komplikationen u. a. Myokardinfarkt (z. B. durch Koronarostienbeteiligung) oder neurologische Ausfälle auftreten können.

c) Schlaganfall – klinisches Bild

Auf Nachfrage schilderte ich das klinische Erscheinungsbild eines Schlaganfalls, u. a.:

- Gesichtsasymmetrie/Fazialisparese
- Sprachstörung, Arm-/Beinschwäche, Sensibilitätsstörung (je nach Lokalisation)

d) Röntgen-Thorax – Befund

Ich erhielt einen Thorax-Röntgen und sollte es befunden. Der Befund war ein Pneumothorax.

e) Schock – Definition und Schockformen

Zum Schluss wurde Schock besprochen (Definition und Einteilung), u. a.:

- septischer Schock
- hypovolämischer Schock
- kardiogener Schock
- obstruktiver Schock (z. B. Spannungspneumothorax, Lungenembolie, Tamponade)

Ich nannte jeweils Beispiele und die Grundmechanismen.

Vorbereitung/Empfehlungen: Zur Vorbereitung habe ich FIA Kurs besucht sowie Unterricht bei Valeria. Den Kurs würde ich persönlich nicht empfehlen, weil er für mich wenig effizient war. Bei Valeria war der Unterricht dagegen sehr strukturiert, klar und ohne Zeitverlust – davon konnte ich direkt profitieren.

16.02.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Psychosomatik
Jungbauer	Hanisch	Wiehn

Klinischer Fall: NSTEMI, Hinterwand Infarkt

Helga Wiedenbrück 63J, kam zu uns in hausärztlichen Praxis, seit 2 Wochen druckend Gefühl nach Belastung dauert bis 5 Minuten verbessert sich mit Rest, sie ist gestern aufgewacht wegen starke Schmerzen was war besser nach 15 Minuten nach aufsitzen, sie hat im Moment keine Beschwerde außer dass sie unruhig ist und Angst wegen was sein konnte und das ihr Vater von Herzinfarkt verstorben ist.

VOps keine , VE : BHT, nimmt Ramipril und Bisoprolol , Raucht seit 40 Jahren 1 Schachtel pro Tag. Alles andere unauffällig.

Ich habe alles gefragt bis zum Ende und letzte 7 Minuten habe ich KP gemacht und EKG, es zeigte ST Hebungen in II, III und aVF. ST Senkung in I und AVL, sehr einfach und eindeutig. Dann habe ich sie beruhigt und gesagt, dass sie ins Krankenhaus musste , Notarzt anrufen und die ASS geben mit Blutabnahme, um das Troponin zu bestimmen.

Innere Medizin

Dr. A.Jungbauer war nett, allgemein aber anstrengend.

Was habe ich gesehen in EKG, welche Ableitungen sind für Hinterwand , dann warum sind II , III , aVF sind Hinterwand Ableitungen ? ich habe geantwortet dass jede Ableitung misst elektrische Aktivität von unterschiedliche Winkel , dann hatte er mich gesagt welche Winkel hat jede Ableitung , ich wusste ehrlich nicht ich habe ihm auf meine Körper gezeigt war nicht so begeistert.

Dann war ein Fall von eine Patientin 22 Jahre, ist sehr unruhig seit gestern und hyperventiliert, hatte Vitalparameter von: BD 100\60, HF: 120, AF: 24, Spo2: 98%, wie gehen Sie vor? Ich habe gesagt dass sie im Schock ist und zugäng legen Blutabnahme und Flüssigkeit anhängen , Blut , HB 14 , Leuko 6000 , alles anders normal, dann wollte ich BGA machen , hat mir BGA gezeigt : (pH: 7.19 , pCO2 : 14 , K : 5,9 , Glu : 340 , Lactat : 8) .

Ich habe gesagt, dass es Wahrscheinlich sie DKA, hat gesagt richtig wie gehen Sie vor , Insulin geben und im Verlauf Glukose und Kalium und Glucose kontrollieren , warum ? , dann was ist der Unterschied zwischen DM typ 1 und 2 , wie kann man das schnell identifizieren , C-Peptid.

Warum Laktat ist erhöht in DKA, ich habe gesagt dass weil keine Glukoseaufnahme möglich ist dann wird Fettigen Sauren metabolisiert und das bildet Ketone was zu azidose führen, er hat gesagt aber Ketone sind keine Laktat , war nicht zufrieden , dann hat er gefragt wann Laktat erhöht ist, ich habe beim Ischämie und anaeroben Stoffwechsel dann sagte er aber gibts auch andere Ursachen , wie DKA aber warum ? ich wusste nicht.

Ursachen von Hyperkaliämie und wie man Hypokaliämie behandelt (oral Substitution mit Brause, Saft, wenn nicht möglich dann Iv durch ZVK am besten)?

Formen von Schock mit Beispiele, dann Fragen über LE, wie Diagnose gemacht kann, dann warum stirbt man bei LE? dann wann Thrombolyse? dann wann intubiert man bei LE? Ich wusste das nicht, dann Zeit war um.

Psychosomatik

Dr. T. Wiehn war sehr netter Prüfer und freundlich.

Fall mit Hyperventilation, was macht man, dann Bulimie, was sieht man bei solchen Patienten, in KU und Labor. Suizidalität: Was macht man als Patient beim Hausarzt und will sich umbringen. Polizei anrufen und Zwangseinweisung in Psychiatrie.

Dann PTBS was ist das, wie kann man Patient helfen,

Nebenwirkungen von Benzodiazepine.

Chirurgie

Dr. E. Hanisch war sehr nett, spricht langsam und deutlich.

Fragen alle von Protokolle.

Akutes Abdomen (Definition, Ursachen Intraabdominell und Intraabdominal) waren eigentlich alle Fragen in diesem Zusammenhang.

Ileus Typen, was hört man bei jedem Typ.

Peritonitis Zeichen, Akute Appendizitis Diagnose, Divertikulitis Klassifikation, Mesenterialischämie und Diagnose und was sieht man bei KU. dann Sepsis Definition und Kriterien und was macht man bei Sepsis. (Blutkulturen, Antibiose, Fokus Suche)

Unterschied zwischen Sepsis und septischem Schock.

Die Prüfung ist sehr machbar, habt ihr kein Angst ich weiß das ist einfach zu sagen, aber die Prüfern waren nett und haben mir geholfen ich könnte alles nicht so schnell beantworten trotz die einfache Fragen, ich hoffe das euch alle bestehen, viel Erfolg, Kollege und Kollegin.

16.02.2026 Bad Nauheim Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Kaltwasser	Schmidt-Matthiesen	Wunder

Klinischer Fall: Rheumatoide Arthritis

Die Patientin hatte seit längerer Zeit Schmerzen in den MCP-Gelenken, die sich in den letzten 2–3 Wochen verschlechtert haben. Zusätzlich Fieber und Nachtschweiß.

Vorerkrankungen: Arterielle Hypertonie und allergische Rhinokonjunktivitis.

Medikamente: Candesartan 1x1 und Cetirizin bei Bedarf.

Familienanamnese: Mutter mit RA, kein Kontakt zum Vater.

KU: positives Gänseliesel- und Flaschenzeichen.

Labor: erhöhte Entzündungswerte, ANA und Anti-CCP-Antikörper positiv.

Innere Medizin

1. Fall: Älterer Mann mit diffusen Rückenschmerzen. Ich sollte mein Vorgehen erklären (Anamnese, klinische Untersuchung, Labor). Danach zeigte er ein Bild mit verhärteter A. temporalis → Diagnose: Arteriitis temporalis. Therapie:

Glukokortikoide. Bei Augenbeteiligung und Visusminderung: hochdosiertes Prednisolon 500–1000 mg i.v.

Ohne Augenbeteiligung: Prednisolon 25–50 mg p.o.

Außerdem Verlaufskontrolle mit BSG und langsames Ausschleichen.

Er war sehr zufrieden.

2. Fall: Meningitis.

Fragen zu Erregern, Diagnostik, Therapie, Komplikationen sowie Unterschiede im Liquor zwischen bakterieller und viraler Meningitis.

Ich konnte alle Fragen beantworten.

Chirurgie

Ein Patient mit starken Bauchschmerzen wird vom Rettungsdienst gebracht. Er spricht kein Deutsch. Ich sollte erklären, wie ich vorgehe. Ich habe gesagt: Anamnese (falls möglich), dann klinische Untersuchung (Inspektion, Auskultation, Palpation). Verdachtsdiagnosen nennen. Dann Labor, Röntgen Abdomen in Linksseitenlage und AP.

Frage: Warum Linksseitenlage? (Nachweis freier Luft).

Diagnose: perforiertes Ulkus.

Therapie: operative Versorgung (Laparoskopie oder Laparotomie).

Der Prüfer fragte dann sie sind jetzt im Magen und sehen weiß-gelbliche, klebrige Beläge. Wissen Sie, was das ist? Ich habe kurz überlegt. Dann sagte der Professor, dass ich das eigentlich nicht wissen muss. Er wolle nur etwas tiefer fragen, weil ich die vorherigen Fragen alle richtig beantwortet hatte.

Ich habe geantwortet, dass ich nicht ganz sicher bin, aber vermute, dass es sich um Fibrinbeläge handelt.

Er hat zugestimmt und gesagt, dass er sehr zufrieden ist und nichts Weiteres braucht.

Allgemeinmedizin

1. Fall: 84-jährige Patientin mit Schwindel.

Schrittweise Vorgehen: Anamnese, klinische Untersuchung, Labor.

Labor unauffällig, dann EKG → Vorhofflimmern.

Therapie: Thromboseprophylaxe und Frequenzkontrolle.

Rhythmuskontrolle nur nach TEE im Krankenhaus.

Fragen zum CHA₂DS₂-VASc-Score und Entstehung von Thromben (Vorhoffibrillation).

2. Fall: Bild eines Kindes mit kleinen roten Flecken an Händen und Füßen, Halsschmerzen, Beläge.

Differentialdiagnosen.

Diagnose: Hand-Fuß-Mund-Krankheit.

Erreger und Therapie.

3. Fall: Bild mit roten Augen.

Wichtig war, ob der Bulbus schmerzhaft ist.

Diagnose: virale Konjunktivitis, Therapie symptomatisch.

Die Atmosphäre war sehr angenehm. Ich hatte das Gefühl, dass wir wie Kollegen die Fälle besprochen haben. Die Prüfer haben sehr gut auf meine Antworten reagiert, was mir geholfen hat.

Da zwischen waren auch vielen anderen Fragen.

Vorbereitung/Empfehlungen: Lernmaterialien: Amboss, Offene Vorlesungen von Valeria (sehr prüfungsorientiert), 444 KP Vorbereitung, MEXX Karten, Kurs bei FIA (für mich leider nicht hilfreich).

16.02.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Voss	Volkmann	Wagner

Klinischer Fall: AVNRT

Ein 45-jährigen Patienten stellte sich mit den klassisch in den Leitlinien beschriebenen Symptomen vor. Und zwar hatte er zwei Tage vorher eine etwa 20-minütige Episode mit Schwindel und Palpitationen. Zwei Tage später traten die Symptome erneut auf, woraufhin er seinen Hausarzt aufsuchte. Dieser schrieb ein EKG und überwies den Patienten in die Notaufnahme.

Bei Aufnahme war der Patient beschwerdefrei und gab an, aktuell keine Symptome zu haben. Nach Anamnese und körperlicher Untersuchung begann ich, dem Patienten seine Situation zu erklären. In diesem Moment fragte Herr Voss, wie ich weiter vorgehen würde. Er gab mir eine EKG. Nachdem ich mein Vorgehen kurz erläutert hatte, war die Zeit abgelaufen und ich wechselte in den Dokumentationsteil.

Innere Medizin

Differenzialdiagnosen

Noch vor Beginn stellte Herr Voss Fragen zu meinen Differenzialdiagnosen aus der Simulation:

- Warum kein Vorhofflimmern?
- Warum keine AVRT?
- Warum kein Vorhofflattern?

Ich nannte jeweils die typischen Merkmale in knapper Form.

EKG-Diagnostik

Herr Voss zeigte verschiedene EKGs (AVNRT, AVRT, typisches Vorhofflattern, Vorhofflimmern und WPW) und überprüfte, ob ich diese korrekt erkennen konnte.

Labor und Anämie

Laborbefund eines 84-jährigen Patienten:

- MCV 108 fl
- Hb 6,8 g/dl
- Erythrozyten 1,8 Mio./ μ l

Ich stellte die Diagnose einer megaloblastären Anämie.

Als Ursachen diskutierten wir insbesondere Mangelernährung im Alter sowie Gastritis (inklusive Typen und Ursachen).

Elektrophorese

Ich interpretierte eine Elektrophorese-Grafik.

Die Differenzierung zwischen multiplem Myelom und Leberzirrhose erklärte ich anhand einer selbst skizzierten Kurve und ging dabei besonders auf die sogenannte „Gamma-Bridge“ (Beta-Gamma-Fusion) ein.

Hepatitis

Gefragt wurden:

- Hepatitis A–E
- Übertragungswege
- Chronifizierungsrisiko
- Zusammenhang mit Leberzirrhose und hepatozellulärem Karzinom (HCC)

Herzinsuffizienz

Ich sollte die Herzinsuffizienz nach Ejektionsfraktion klassifizieren:

- HFrEF
- HFmrEF
- HFpEF

Anschließend wurde gefragt, warum man bei erhaltener Ejektionsfraktion dennoch von Herzinsuffizienz spricht. Ich erklärte dies mit der diastolischen Dysfunktion und fasste die Pharmakotherapie zusammen.

Allgemeinmedizin

Herr Wagner stellte schnelle, aufeinanderfolgende Fragen und erwartete kurze, präzise Antworten.

Diabetes mellitus

Einstieg: „Patient mit Blutzucker 180 mg/dl – was machen Sie?“

Ich fragte zunächst, ob es sich um einen Nüchtern- oder postprandialen Wert handelt.

- Postprandial: kann physiologisch sein.
- Nüchtern: Verdacht auf Diabetes mellitus.

Ich erläuterte kurz die diagnostischen Kriterien sowie die Therapiebasics (Lebensstiländerung, Beginn mit Metformin). Danach wechselte er sofort zur nächsten Frage.

Gichtarthritis

Fall: Bauarbeiter mit Schmerzen und Schwellung im Vorfuß.

Therapie: zunächst NSAR, bei fehlender Besserung Glukokortikoide.

Frage: „Nebenwirkungen von NSAR?“

Anschließend: „Was passiert bei einmaliger Gabe eines Glukokortikoids?“
(Ich ging von einer Nebenwirkung aus.)

Antwort: Hyperglykämie.

Antikoagulationsmanagement

- Vorhofflimmern → CHA2DS2-VASc-Score → Indikation für DOAK
- Präoperatives Management von DOAK und Vitamin-K-Antagonisten
- Ziel-INR präoperativ
- Akute Blutung bei erhöhtem INR: Gabe von Prothrombinkomplexkonzentrat und Vitamin K

Chirurgie

Vollständig auf Frakturen.

Pädiatrischer Patient

Kind, das einen Arm mit dem anderen hält. Radiologisch: suprakondyläre Humerusfraktur.

Erste Maßnahme: pDMS-Kontrolle (periphere Durchblutung, Motorik, Sensibilität). Postoperative Risiken und mögliche Nervenläsionen wurden besprochen.

Geriatrischer Patient

82-jährige Alzheimer-Patientin nach Sturz aus dem Bett.

Aufgrund der eingeschränkten Kommunikation lag der Fokus auf Schmerzreaktionen und einer systematischen körperlichen Untersuchung. Warum ist das Frakturrisiko im Alter erhöht? (z.B. Osteoporose).

Dann zeigte er das Röntgenbild derselben Patientin:

Schenkelhalsfraktur.

Radiologisches Vorgehen und operative Optionen wurden besprochen. Warum muss die Patientin schnell operiert werden? Ich nannte mögliche Komplikationen und betonte die Notwendigkeit einer möglichst frühen Mobilisation („so schnell wie möglich“). Meine Antworten wurden als ausreichend bewertet.

Tibia-Fibula-Fraktur

Proximale Fraktur.

Frage: „Wie gehen Sie vor?“

Zusätzlich: „Was sehen Sie noch im Röntgen?“ Ich erkannte, dass der Fuß in 90°-Innenrotation lag (erkennbar an der Fersenprojektion im unteren Bildbereich), was positiv hervorgehoben wurde.

Es folgten Fragen zu Komplikationen und zum weiteren Management. Operative Osteosyntheseverfahren wurden nicht vertieft.

Vorbereitung/Empfehlungen: Mit der Vorbereitung begann ich im September. Da ich jedoch zunächst keine klare Strategie hatte, war die Anfangsphase wenig effizient. Zusätzlich konnte ich mich aufgrund der Arbeit kaum konzentrieren. Zwei Monate vor der Prüfung begann ich intensiv zu lernen.

Ich arbeitete mit einem 444-seitigen KP-Skript, Prüfungsfragen und zusätzlich mit ChatGPT. Das war absolut ausreichend – rückblickend bin ich sogar der Meinung, dass ich teilweise zu sehr ins Detail gegangen bin.

Die Vorbereitungszeit und die Prüfung selbst fühlten sich wie ein psychologischer Kampf an. Oft musste ich trotz Hoffnungslosigkeit weitermachen.

Am Ende habe ich es geschafft – und darüber bin ich sehr glücklich. Ich wünsche allen, dass sie diese Stressphase möglichst bald hinter sich lassen können.

09.03.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Bargon	Schütz	Simons

Klinischer Fall: Herzinsuffizienz

Herr Hofmann, ein 65-jähriger Patient, geb. am xx.03.1961, stellte sich mit seit 3 Monaten bestehender Leistungsminderung, Dyspnoe beim Treppensteigen bereits nach einer Etage sowie seit 2–3 Wochen bestehenden peripheren Ödemen an den Beinen und Nykturie vor.

Beim Aufnahmegespräch war Herr HoBmann zu Ort, Zeit, Situation und Person voll orientiert. Der Patient berichtete, dass er sich derzeit nicht mehr so leistungsfähig fühle und beim Treppensteigen eine Pause einlegen müsse, um wieder zu Atem zu kommen.

Darüber hinaus gab er an, zwei- bis dreimal pro Nacht aufstehen zu müssen, um Wasser zu lassen. Des Weiteren berichtete er, eine Veränderung der Hautfarbe an den Beinen sowie eine Zunahme der Beinschwellung bemerkt zu haben.

Er stellte sich vor einer Woche beim Urologen vor; laut Patient seien die Laborparameter unauBällig gewesen.

Zudem klagte der Patient über Schlafstörungen, Müdigkeit, arbeitsbedingten Stress sowie Schwindel.

Vegetative Anamnese:

Bis auf Müdigkeit, Schlafstörungen, Schwindel sowie vermehrtes Wasserlassen unauBällig.

Vorerkrankungen:

Arterielle Hypertonie und Psoriasis.

Operationen:

Pyloromyotomie und Tonsillektomie.

Aktuelle Medikation: Candesartan 16 mg 1-0-1 Bisoprolol 5 mg 1-0-1

Allergien:

Allergien und Unverträglichkeiten wurden verneint.

Noxen:

Der Patient habe über einen Zeitraum von 10 Jahren täglich zwei Zigaretten geraucht, jedoch inzwischen damit aufgehört. Er trinke am Wochenende 2–3 Gläser Wein.

Herr H. sei verheiratet, selbstständig in einer kleinen Firma tätig, wohne in einer Eigentumswohnung und habe zwei gesunde Kinder.

Die Mutter des Patienten habe an Diabetes mellitus Typ 2 gelitten.

Der Vater des Patienten sei bereits verstorben.

KU: Ich habe mit dem Vitalparameter angefangen. Die waren unauffällig. Danach habe ich die Beine untersucht, danach habe ich ein Photo bekommen



(es war ähnlich wie diese)

Ich begann mit der Erhebung der Vitalparameter; diese waren unauffällig. Anschließend untersuchte ich die Beine. Danach erhielt ich ein Foto (es sah ähnlich aus wie dieses).

Ich sagte laut, dass ich die peripheren Pulse sowie das Ödem palpieren wolle. Die Pulse waren unauffällig, der pDMS-Status war intakt und bei festem Druck auf das Ödem zeigte sich eine Fovea (positives Fovea-Zeichen). Anschließend tastete ich erneut alle relevanten Pulse ab und erklärte dabei, welche Pulse ich untersuchte und wie ich dabei vorging.

Danach untersuchte ich den Thorax. Ich begann mit der Auskultation der Herzklappen und erklärte erneut laut, wo und was ich untersuchte. Es fanden sich keine pathologischen Herzgeräusche. Der Herzspitzenstoß war im 5. ICR links palpabel.

Anschließend untersuchte ich die Lunge. Ich überprüfte die Atemexkursion; es zeigten sich keine pathologischen Atemgeräusche. Danach führte ich eine

Perkussion der Lunge durch und erklärte dabei stets, was ich machte und warum.

Labor/Bildgebungen: Ich erhielt ein EKG (unauffällig) sowie Laborparameter (Kreatinin 1,5 mg/dl; leichte Anämie, Hyponatriämie und erniedrigter Hämatokrit). Zusätzlich forderte ich Troponin an; die Werte waren unauffällig.

Währenddessen fragte mich der Patient, ob alles in Ordnung sei oder ob eine Operation notwendig wäre. Er äußerte seine Angst, möglicherweise eine Bypass-Operation zu benötigen oder plötzlich zu sterben. Ich erklärte ihm daraufhin die Laborwerte sowie das EKG und versuchte, ihn zu beruhigen.

Anschließend forderte ich eine Echokardiographie an. Dabei zeigte sich eine linksventrikuläre Ejektionsfraktion von unter 39 %. Ich erklärte dem Patienten die Bedeutung dieses Befundes.

Dr. Bargon teilte mir mit, dass ich noch zwei Minuten Zeit hätte und fragte mich, ob ich noch etwas ergänzen wolle. Daraufhin erklärte ich dem Patienten das weitere Vorgehen: eine Anpassung der Medikation, weitere Laborkontrollen sowie diätetische Maßnahmen.

Zu Beginn und vor der körperlichen Untersuchung desinfizierte ich meine Hände. Außerdem entschuldigte ich mich beim Patienten dafür, dass wir keinen Kittel für ihn hatten und er sich für die Untersuchung teilweise entkleiden musste.

Als ich anschließend den Arztbrief schrieb, bemerkte ich, dass ich das NT-proBNP vergessen hatte. Das war jedoch kein großes Problem, da ich es später noch erwähnte und dazu einige Fragen erhielt, zum Beispiel, warum ich die Werte für Kalium und Kreatinin wissen wollte. Ich erklärte, dass ich dem Patienten aufgrund der Ödeme ein Schleifendiuretikum geben wollte und mögliche Nebenwirkungen vermeiden möchte.

Chirurgie

Eine Patientin mit diagnostiziertem DM Typ 2 kommt mit einseitigem Beinödem. Es ist rot, schmerzhaft und die Patientin ist in reduziertem Allgemeinzustand. Wie gehen Sie vor?

- Anamnese: Welche Medikamente, Schmerzanamnese, Unfall, Verletzungen.

Sie hatte diese Beschwerden vor einer Woche, jedoch sind sie stärker geworden. Sie hatte keine Verletzung und keinen Unfall. Sie nimmt Antidiabetika und ist gut behandelt.

- Ok, dann würde ich gerne die Vitalparameter messen. Sie hat Fieber, Tachykardie und niedrigen Blutdruck.

- Bei der KU sehe ich: Folgt die Verletzung den Lymphgefäßen oder hat sie ein bestimmtes Muster?

Es folgt keinem richtigen Muster. Es fängt in den Waden an und strahlt nach vorne hin aus.

- Ich habe den Verdacht auf Phlegmone und Erysipel als DD, da die Patientin unter Immunschwäche leidet.

Gut, wie könnten wir Phlegmone von Erysipel unterscheiden?

- Der Erreger der Phlegmone ist Staph. aureus und beim Erysipel ist es normalerweise Streptococcus beta-hämolyticus. Phlegmone ist auch als Zellulitis bekannt und könnte gefährlicher sein, da der Erreger auch MRSA sein könnte. Phlegmone ist auch eine tiefere Infektion.

Sehr gut, was machen Sie danach?

- Ich würde eine Probe nehmen und ein Antibiotogramm anfordern. Ich würde der Patientin auch ein Analgetikum geben, einen venösen Zugang legen und auch die chirurgische Abteilung informieren, da eine OP notwendig wäre.

Es ist MRSA. Welche Medikamente geben Sie?

- Breitspektrumantibiotika, z. B. Pip/Tazo oder ein Carbapenem.

Bei Erysipel?

- Penicillin V oder G.

Wenn es kein MRSA, sondern nur ein normaler Staph. ist, würden Sie Penicillin geben? - Nein, da er schon Resistenzen entwickelt hat.

Der Zustand der Patientin ist schlimmer geworden. Was machen Sie?

- Ich habe es vergessen, aber von Anfang an würde ich die Läsion delimitieren. Wir könnten sie chirurgisch weiter behandeln mit Debridement und Drainage, da wir weitere Komplikationen vermeiden möchten.

Welche Komplikationen?

- Schock oder nekrotisierende Faszitis.

Was ist eine nekrotisierende Faszitis, ganz grob?

- Eine ischämisch-nekrotisierende bakterielle Infektion der Faszie und der darunterliegenden Muskeln.

Wie heißt es, wenn die Muskeln entzündet sind? - Myositis.

Sehr gut. Ok, Sie haben eine andere Patientin. Sie klagte über obere Bauchschmerzen. Sie hatte vor einer Woche schon die Schmerzen, hat ein Analgetikum eingenommen, es war kurz besser, aber heute haben sich die Schmerzen plötzlich verschlimmert. Wie gehen Sie vor?

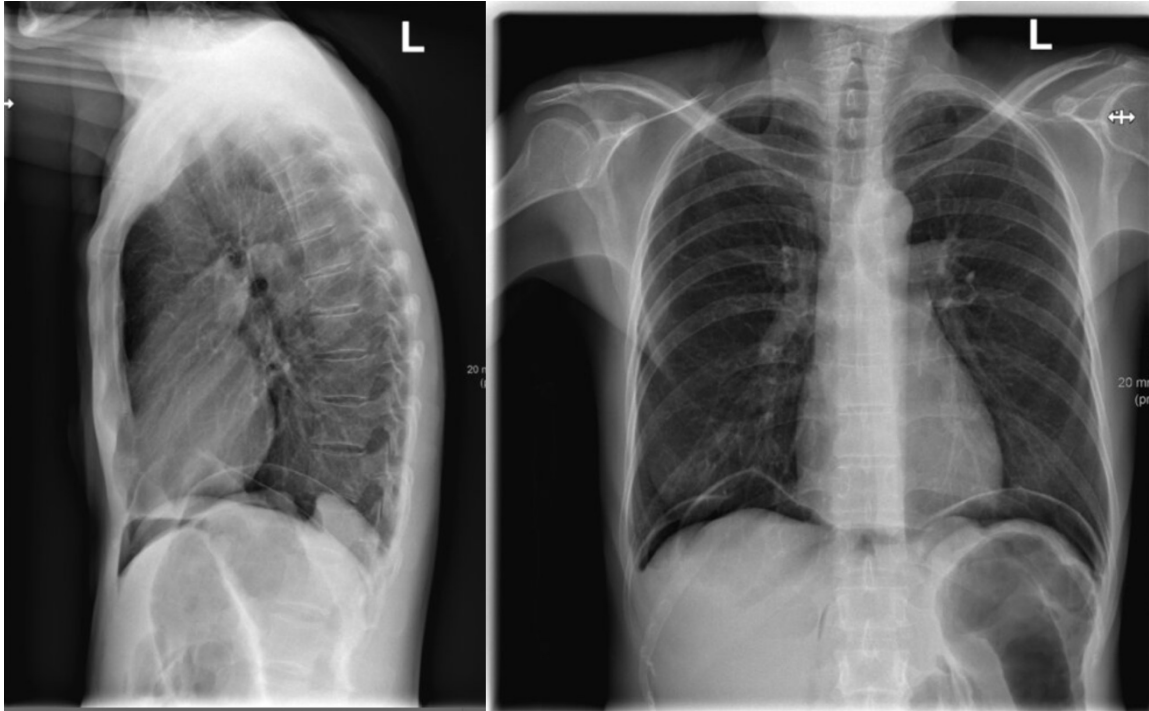
- Ich würde erstmal fragen: Vorerkrankungen, welche Medikamente, seit wann und wie viel? Waren die Schmerzen am Anfang nach oder vor dem Essen? Veränderungen beim Stuhlgang?

Was Sie wissen möchten, ist gut, aber die Patientin ist ziemlich unruhig und hat viele Schmerzen. Sie kann die Fragen nicht so gut beantworten.

- Ich würde dann mit der KU fortfahren. Hat die Patientin ein bretthartes Abdomen, Abwehrspannung? Und ich würde gerne die Vitalparameter messen.

Richtig, die Patientin ist sehr instabil: HF 118, Blutdruck 98/69. Alles richtig mit Loslassschmerz. Woran denken Sie und was machen Sie?

- Ich habe an ein akutes Abdomen gedacht. Laut Definition ist es ein Schmerz im Bauchbereich, der aufgrund der Bedrohlichkeit und Intensität aufgeklärt und behandelt werden muss. Ich würde gerne ein Röntgen des Abdomens anfordern, im Sitzen oder in Linksseitenlage. Ich habe folgendes bekommen:



Was sehen Sie und warum wird die Aufnahme in zwei Ebenen durchgeführt?

- Die Aufnahme in zwei Ebenen dient dazu, die gastrische Luftblase von freier Luft unter dem Zwerchfell zu unterscheiden. In diesem Fall sehe ich freie Luft im Abdomen, was auf eine Perforation eines Hohlorgans hindeutet. Daher würde ich die Patientin notfallmäßig operativ versorgen, entweder laparoskopisch oder laparotomisch.

Sie sehen, dass die Patientin ein Ulkus im Pylorus hat. Wie behandeln Sie es?

- Zunächst würde ich Biopsien aus dem Ulkus entnehmen und anschließend das Ulkus operativ übernähen.

Wie erfolgt der Schnitt?

- Der Schnitt erfolgt quer, um eine Pylorusstenose zu vermeiden. Dieses Verfahren entspricht der Heineke-Mikulicz-Pyloroplastik.

Warum möchten Sie Biopsien entnehmen?

- Ein Ulcus ventriculi kann mit einem malignen Prozess assoziiert sein.

Außerdem möchten wir prüfen, ob eine Infektion mit *Helicobacter pylori* vorliegt, um diese entsprechend behandeln zu können.

Sie haben die Patientin operiert. Welche Medikamente geben Sie postoperativ?

- Postoperativ würde ich eine Thromboseprophylaxe, Antibiotika, einen Protonenpumpenhemmer (PPI) sowie eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr verordnen.

Sie haben etwas vergessen. Was ist ebenfalls wichtig? - Natürlich eine adäquate Schmerztherapie.

Allgemeinmedizin

In diesem Teil der Prüfung bekam ich außerdem Bilder sowie chirurgische Instrumente (z. B. Pinzetten) gezeigt



Ein Mann hatte nach mehreren Monaten Schmerzen und er kann diese Finger nicht mehr bewegen.

- Es ist eine Kontraktur. Hat der Patient etwas eingenommen? Trinkt der Patient viel Alkohol? Hat er bemerkt, dass es irgendwann schlimmer wird? Nein, der Mann hat nur Schmerzmittel bekommen. Was machen Sie?

- Ich würde den Patienten überweisen, da wir es in der Praxis nicht behandeln können, und ich würde erklären, dass er eine OP braucht.

Gut, aber Sie haben bis jetzt keine Diagnose gestellt.

- Ah ja, das ist eine Kontraktur der Sehnen.

Wie heißt es genau und welche anatomischen Strukturen sind betroffen?

- (Ich habe den Namen Dupuytren vergessen, dann sagte er, es ist ein

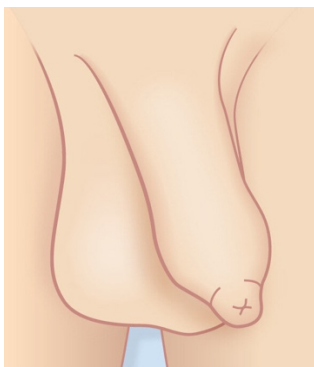
französischer Name.) Ah ja, Dupuytren-Kontraktur und die **Fascia palmaris** ist betroffen. Nächstes Bild:



Wie heißt das?
- Abduzensparese.

Welcher Muskel ist betroffen? - M. abducens.

Welche Innervation hat dieser Muskel und zu welcher Gruppe gehört sie? - Hirnnerven. Es ist der N. abducens bzw. der VI. Hirnnerv.:



Wie heißt das? - Phimose.

Wie wird es behandelt? - Chirurgisch.

Welches Gewebe ist schuld? - Die Vorhaut.

Dann hat er mir verschiedene Pinzetten gezeigt. Er wollte wissen, wie sie heißen und wofür wir sie benutzen?



In Reihenfolge:

- Anatomische Pinzette (um Gewebe zu manipulieren), chirurgische Pinzette (beim Nähen), Splitterpinzette (zur Entfernung von Glas), Läusekamm, Zeckenpinzette und Adson-Pinzette. Nasal Speculum

Eine Frau ruft ihn an, weil ihre Tochter nicht richtig einatmen kann. Die Frau sagte, dass ihre Tochter sich von ihrem Freund getrennt hat und seitdem geht

es ihr nicht so gut. Sie kennen die Patientin, sie ist 15 Jahre alt, hat keine Vorerkrankungen und war immer gesund. Wie gehen Sie vor?

- Ich würde erstmal gerne wissen, ob die Patientin etwas Neues gegessen hat oder ob sie einen Unfall hatte.

Sie haben alle Informationen, die Sie brauchen.

- Ok, dann würde ich der Patientin eine Tüte geben, damit sie dort hineinatmen kann.

Aber Sie haben bis jetzt keine körperliche Untersuchung durchgeführt.

- Ah ja, sorry. Ich würde schauen, ob sie zyanotisch ist oder Atemhilfsmuskulatur benutzt.

Die Hände sind verkrampft und auch der Mund der Patientin. Was hat sie? - Elektrolytstörung.

Welche?

- Calcium.

Warum?

- Hypokalzämie.

Wie heißt das?

- Hyperventilationstetanie.

Sollen wir der Patientin Kalzium geben?

- Nein, weil die Hypokalzämie reversibel ist und wir keine Herzstörungen begünstigen möchten.



Sie haben diese Patientin, sie kommt aus Afghanistan. Was sehen Sie? - Es ist eine Lymphknotenschwellung.

Sehr gut, was könnte es verursachen?

- Tuberkulose.

Ja, was noch?

- Malignome bzw. Krebs. Ok, was noch?

- Virale Infektionen: Mononukleose, CMV, HIV

- Bakterielle Infektionen: Listeriose, Brucellose

- Parasitäre Infektionen: Toxoplasmose, Malaria, Schistosomiasis

Gut, was machen Sie danach?

- Ich möchte einen Interferon-Test anfordern.

Meinen Sie den Quantiferon-Test? Er ist positiv, und das sagt nur, dass sie irgendwann Kontakt mit Tb hatte. Was machen Sie danach?

- Ok, ich würde auch gerne eine PCR oder Kultur oder eine mikroskopische Testung durchführen.

Wie machen Sie das, was brauchen Sie?

- Ich brauche eine Biopsie von dem Lymphknoten.

Genau! Sie sagen, dass die Patientin zum HNO gehen muss, um ihn biopsieren zu lassen. Was müssen Sie noch machen?

- Ich muss es melden, da es Tb ist, und ich muss den Kollegen vom HNO auch informieren. Sehr gut, aber ich meinte: Welche Färbungen oder außer PCR, welchen Agar brauchen Sie? - Färbungen: Ziehl-Neelsen oder Auramin-Rhodamin und Löwenstein-Jensen-Agar.

Sehr gut, und was machen Sie?

- Ich muss die Patientin isolieren.

Nein, das ist falsch, da sie keine Tb in den Lungen hat.

- Es tut mir leid, ja, das stimmt.

Was erwarten Sie von dem histologischen Befund?

- Tb-Nachweis, aber was genau, weiß ich leider nicht. (Dann hat Dr. Schütz gesagt, dass die Frage sehr schwierig war.) (Antwort: Epitheloidzellgranulom)

Kein Thema. Wie behandeln Sie es?

- RIPE: Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid und Ethambutol. Welche Nebenwirkungen kennen Sie?

- Alle außer Ethambutol sind hepatotoxisch. Neurotoxizität, Optikusneuritis. Wir müssen der Patientin auch sagen, dass sie nicht schwanger werden darf, da die Medikamente teratotoxisch sind.

Ok, die Patientin ist jetzt zurück im Krankenhaus und sie sagt: „Herr Doktor, ich pinkele rot.“ Warum?

- Ja, ich habe es total vergessen, Rifampicin macht das. Sehr gut.

Jetzt haben Sie in der Notaufnahme einen Patienten mit bekannter COPD. Der Patient hat Tachypnoe, die Atemmuskulatur arbeitet stark. Was machen Sie?

- Ich würde erstmal die Anamnese erheben, danach KU und BGA sowie Leukozyten, Entzündungsparameter und klinische Chemie bestimmen.

Er gab mir eine BGA: SpO₂ 60, pCO₂ 50, pH: 7,36.

Was machen Sie? Welche Sorgen haben Sie?

- Es ist eine Ventilationsinsuffizienz und eine Ateminsuffizienz.

Richtig, normalerweise haben wir partielle oder globale Insuffizienz gesagt, aber jetzt benutzen wir diese Begriffe.

Was machen Sie jetzt?

- Ich würde auch eine Nasenbrille geben, Sauerstoff, aber nur bis 90 %, da man bei COPD nicht zu viel geben sollte. Ich würde Salbutamol und ICS oder sogar Kortikosteroide i.v. sowie Antibiotika geben.

Sehr gut, aber es hilft nicht. Was machen Sie danach?

- Intubieren oder einen CPAP benutzen. Nicht CPAP, aber was bedeutet CPAP? - Continuous Positive Airway Pressure. Sehr gut, und warum nicht CPAP?

- Wir brauchen BiPAP, weil das Problem nicht nur in einer Richtung besteht.

Dann hat er mir eine Ganzkörperplethysmografie (Bodyplethysmographie) gegeben. Er hat gefragt, was FEV1, VC, TLC und FRC bedeuten und was dabei wichtig ist. Ich habe auch den Tiffeneau-Index erklärt. Ich musste es interpretieren. Der Patient hatte einen Tiffeneau- Index < 50 . Er fragte, ab wann es nicht mehr mit dem Leben kompatibel ist. Ich habe < 30 gesagt, aber ich war nicht sicher.

Sehr gut, der Patient ist nach einigen Tagen viel besser, aber er kommt danach und sagt, dass seine Frau sich über ihn beim Schlafen beschwert. Er wiegt 120 kg. Was denken Sie?

- Schlafapnoe.

Was ist Schlafapnoe?

- Nächtliche Atmungsstörung mit klinischer Beschwerdesymptomatik und/oder gesundheitlichen Risiken. Sie könnte eine arterielle Hypertonie verursachen, insbesondere vom Non-Dipping-Typ.

Pathophysiologie der Schlafapnoe?

- Schlafbezogene Atemstörung mit Obstruktion der oberen Atemwege durch Kollaps der Schlundmuskulatur während des Schlafens.

- Atemantrieb und damit Atembewegungen bleiben erhalten.

Sehr gut, was machen Sie?

- Diesmal CPAP geben und auch empfehlen, eine Ernährungsberatung zu machen und Sport zu treiben.

Und die Zeit war zu Ende.

Dr. Bargon sagte, dass ich 5 Sekunden draußen bleiben sollte, aber dass ich nicht so weit gehen solle. Ich war nervös, da ich nicht alle Fragen beantworten konnte oder manchmal ein bisschen länger gebraucht habe, um zu antworten. Nach 5 Sekunden haben die Prüfer mir gesagt, dass ich wieder reinkommen

sollte. Dr. Bargon sagte, dass sie sehr zufrieden waren und dass ich die Prüfung bestanden habe.

Vorbereitung/Empfehlungen: Sobald ich meine Berufserlaubnis bekommen habe, habe ich mit dem Lernen angefangen. Erstmal habe ich langsam angefangen, etwa eine oder zwei Stunden täglich. Ich habe Amboss, MEX-Bücher sowie Fälle und Karteikarten benutzt. Für EKG habe ich „EKG für Isabel“ benutzt. Ich möchte mich bei den Kollegen bedanken, da die Protokolle unglaublich hilfreich waren.

Mein Wunschmonat war Dezember, aber ich habe den Termin erst im März bekommen, deswegen hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit. Im letzten Monat habe ich 4 Wochen Urlaub von der Arbeit genommen und viel am Tag gelernt, sogar 6–7 Stunden.

Ich habe mit anderen Kollegen geübt und Simulationen gemacht, das war auch sehr hilfreich. Ohne die Hilfe dieser Kollegen hätte ich es nicht geschafft. Wir haben eine Discord-Gruppe gemacht, wo wir uns regelmäßig zum Lernen verabredet haben. Vielen Lieben Dank B/M!

Vielen Dank für ihre Hilfe und Zeit. Ich habe zweimal am Kurs von Mohamad teilgenommen, das war auch sehr hilfreich, da ich danach wusste, wie man antwortet und wie man auf schwierige Fragen reagiert.

Ich glaube, dass wir alle sehr fähig sind. Wir sind schon Ärzte und wahrscheinlich hatten wir schwierige Prüfungen in unserem Heimatland. Bleibt stark und seid sicher, dass ihr es schafft! Lasst nicht Nervosität oder Angst gewinnen.

09.03.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Schoppet	Heuschen	Hüttner

Klinischer Fall: Rheumatoide Arthritis

Herr Müller, 35 JA, 65 kg, 1,75 m, Bankangestellter, kam wegen Schmerzen am MCP I-V und MTP I-V seit 2 Monaten und starke Müdigkeit. Er habe 37,9 °C Fieber gehabt. Er habe ASS und Ibu genommen, war erfolglos. Keine Vorerkrankungen. Keine Voroperationen. Keine Medikamente. Keine vegetative Symptomatik. Die Mutter habe Rheuma.

Labor: Die Labor-Werte habe ich nicht angefordert, aber Herr Schoppet hat mir diese gegeben in 3 Zeilen. BB Normal, BSG 21/47. Rheumafaktor: 120, Anti-CCP 140 (nicht sicher), ANA-Titer: 1/80. Harnsäure: 4,7, Ferritin: 24. (Ich war mit dem 1. Teil innerhalb 12 Minuten fertig. Ich hatte leider keine Fragen mehr. Der Patient hatte viele Fragen, daher sagte ich, dass ich fertig bin. Die Kommission sagte, das ist ok. M. Schoppet war nicht zufrieden, aber Herr Heuschen und Herr Hüttner waren sehr zufrieden mit gezielten Fragen und körperlicher Untersuchung.)

Chirurgie

*Themen: **Aortenisthmusstenose, Aortendissektion, Magen-Karzinom im Antrum, Weber-Fraktur, Leistenhernie.***

Er ist sehr hilfreich und nett. Er versucht, dass ich die richtige Antwort finde. Ich konnte aber die Art seiner Fragestellungen nicht richtig verstehen.

F: Warum haben Sie den Blutdruck beidseitig gemessen?

A: Wegen Blutdruckdifferenz.

F: Ursachen?

A: Aortendissektion, Aortenklappenstenose, Subclavian-Steal-Syndrom.

F: Noch? Aortenstenose oder Aortenisthmusstenose? Welcher und Was sind diese?

A: Beide. Verengung der Aortenklappe. Für die Isthmusstenose hatte ich keine Antwort. Prüfer hat diese selbst erzählt.

F: Was ist die Diagnostik bei Aortenstenose?

A: Echo.

P: Vorher?

A: körperliche Untersuchung. Stenosegeräusch auch in Carotiden. F: Was ist Therapie bei Aortenstenose?

A: TAVI.

F: Was ist die Aortendissektion?

A: Abriss in Media der Aorta.

F: Klassifikation?

A: Nach Stanford. A: Aorta ascendens, B: Ab Arcus Aorta. F: Symptome?

A: Sehr starke Schmerzen, Vernichtungsschmerzen in Brust, im Rücken besonders zwischen beiden Scapulae.

F: Warum hat der Patient sehr starke Schmerzen?

A: Das ist Aorta?

F: So?

A: Die Nervenfasern enden in demselben Neuron im Rückenmark, daher fühlt sich der Patient sehr starke Schmerzen an anderer Stelle.

F: Nein, aber Aorta hat keine sensible Neuronen.

A: ok.

F: Das ist Ischämie-Schmerzen. Dann hat er Vieles erzählt. Noch welche Symptome?

A: hängt von Versorgungsgebiet. MI, SA, Akute Ischämie von Armen und Beinen, Niereninfarkt, Mesenterialischämie.

F: Therapie?

A: Stanford A: Notfall Operation mit Prothese. B: bei unkompliziert EVAR oder TEVAR, bei kompliziert offene Operation.

F: Was ist Weber-Fraktur?

A: Fibula-Fraktur. Weber A: unterhalb Syndesmose, B: in Höhe von Syndesmose, C: oberhalb Syndesmose.

F: Therapie?

A: Plattenosteosynthese? Mit Näht der Syndesmose und Membrana interossea.

F: Nein.

A: Schraube?

F: Ja aber welche?

A: wusste ich nicht.

F: Stellschraube.

A: ok. Prüfer wollte noch besondere Techniken hören. Diese habe ich nicht verstanden. Er hat auch vor der Prüfung an einer Tafel die Weber-C Fraktur gezeichnet. Es gab eine Fibula-Fraktur fast am Knie. Es gab auch noch Frakturen der Femur, Oberschenkelhals und Oberschenkelkopf. Diese hat er nicht gefragt.

F: Ein Fall: 40-jähriger Mann, seit 6 Monaten Vollgefühl, Blähung, Gewichtsverlust 6 kg. Was machen Sie weiter?

A: Der Patient hat Gewichtsverlust. Daher muss ich ein Karzinom ausschließen. Ich mache ÖGD, schaue Ösophagus und Magen.

F: Ok. Im ÖGD sehen Sie ein Ulkus im Antrum, groß wie ein Euro. Biopsie gemacht. Die Diagnose ist Diffuser Typ nach Laure. Was machen Sie weiter?

A: Wir haben die Diagnose. Ich muss jetzt Staging machen, ob es eine Metastase gibt. CT-Thorax- Abdomen usw.

F: Es gibt keine Metastase. Weiter? A: Man muss operieren?

F: Noch 2 Sache vorher?

A: Tumor-Konferenz.

F: Ja richtig. Sonst würden Sie beklagt. Ein Kollege wurde beklagt und musste die Arbeit kündigen. Dann hat er diese erzählt. Die andere Sache hat er vergessen. Ich hatte auch keine Antwort.

F: Ein Fall: Ein älter Mann, Schwellung am linken Leiste, Rötung, Schmerzen. Was machen Sie weiter?

A: Ich habe den Verdacht auf inkarzerierte Leistenhernie. Ich mache Ultraschall. Er muss operiert werden.

F: Ja, aber wie?

A: Laparoskopisch.

F: Ja, aber wie?

A: Wir schneiden die Haut, gehen rein? Ich verstehe nicht, was Sie meinen?

F: Ok. Wie sieht die Hernie in der Laparoskopie aus?

A: ...

F: Wie operiert man?

A: Wir müssen den Darmabschnitt wieder umdrehen und die Vitalität überprüfen. Wenn es avital ist, müssen wir diese entfernen.

F: Ok. Aber Wie? A:

F: Okkk. Wir müssen meisten offen machen. die Leistenkanal öffnen. Sehr komplexe operation usw. er hat noch erzählt, ich hatte keine Interesse.

Innere Medizin

*Themen: **Laborbefunde, EKG, Röntgen-Thorax, Medikamente.***

Er ist sehr seriös, lächelt nie und stellt direkte Fragen.

F: Ein Fall. Ein 60-jähriger Patient hatte heute Morgen Brustschmerzen. Er hatte nochmal sehr starke Brustschmerzen. Er ist heute um 15:00 Uhr zu Ihnen gekommen. Hier ist der Laborbefunde von um 16:00 Uhr. Jetzt hat er keine Beschwerden mehr. Was hat er?

A: Laborwerte waren von 02.03.2026 bis zum 06.03.2026. CK leicht erhöht am Anfang, im Verlauf sehr erhöht. Im Verlauf waren auch CRP erhöht, Leukozytose, Hyperlipidämie, CK sehr erhöht, D- Dimer negativ. Ich habe gefragt, ob ein EKG geschrieben wurde und warum Troponine nicht bestimmt. Er hatte starke Schmerzen, diese müssen wir ausschließen.

F: EKG ST-Senkung. Troponine sind im Labor da. (Aber nicht da) Der Prüfer hat sich entschuldigt und sagte, Troponine sind auch leicht erhöht am Anfang. Was können Sie mit diesen Laborbefunde ausschließen?

A: Dann das ist NSTEMI. Wir müssen Katheteruntersuchung durchführen. D-Dimer negativ. Keine LAE. F: Was können Sie noch ausschließen mit negativer D-Dimer?

A: Aortendissektion.

F: Ok.

F: Dann hat er mir ein EKG gegeben, nur Ableitung I-II-III. Es war VHF. Der Patient ist 76 JA. Was machen Sie weiter?

A: Das ist VHF. Ich muss Thromboseprophylaxe, Rhythmuskontrolle und Frequenzkontrolle. F: Geben Sie ihm direkt Antikoagulantien?

A: Ja.

F: Warum?

A: Er ist 76. CHA2DVACS-Score müssen wir geben. Er hat schon 2 Punkte. F: Gut. Was geben Sie?

A: UFH, NMH, DOAK, Vitamin-K-Antagonisten.

F: Welche genau?

A: meistens DOAK.

F: Welche genau?

A: Apixaban, Rivaroxaban, Enoxaban, Dabigatran. F: Worauf muss man achten?

A: Nierenwerte und nicht bei volvoläres VHF.

F: Gibt es einen Wert dafür?

A: GFR<30 nicht geben.

F: Unter 30 könnte man geben, aber wie?

A: Die Hälfte der Dosis.

F: Ok.

F: Ein EKG gegeben. Was ist das?

A: EKG war etwas komisch. Nur 3 Ableitung gab es. Aber man sieht nicht, welche Ableitung diese sind. Es war Rhythmisch, keine P-Welle, QRS-Breit. Diese habe ich gesagt.

F: Ok. Der Patient nimmt ACE-Hemmer. A:

F: Der Patient nimmt auch Spironolacton. A: Hyperkaliämie.

F: Ja. Welche Nebenwirkung hat ACE-Hemmer?

A: Husten, Hyperkaliämie.

F: Was machen wir bei Husten?

A: Auf Sartane umstellen.

F: Kontraindikationen von ACE-Hemmer?

A: Hyperkaliämie, Nierenarterienstenose, Schwangerschaft. F: ok.

F: Ein EKG gegeben. Alle Ableitungen da. Was ist das? A: ST-Hebung in II, III und AVF. Hinterwandinfarkt.

F: Wo genau?

A: ...

F: wo genau der Infarkt? Was ist der Hinterwand?

A: Ich sagte, ich habe diese oberflächlich gelernt, nur Hinterwandinfarkt und Vorderwandinfarkt kenne ich. Es gibt auch lateralwandinfarkt, Anterioseptalinfarkt. Ich weiß aber nicht, welche Ableitungen für diese zeigen.

F: Ok. Wann machen Sie Lyse-Therapie?

A: Zuerst müssen wir aber Katheteruntersuchung machen.

F: Ja, aber in welcher Situation macht man Lyse?

A: Wenn der Patient die Katheteruntersuchung ablehnt...?

F: ja das zählt. Aber man macht auch, wenn innerhalb 2 Stunden der Patient nicht ins Katheterzentrum verlegt werden kann.

F: Ein Röntgen-Thorax gegeben.

A: Pleuraerguss links ganz deutlich.

F: Welche Ursache?

A: Pneumonie, LAE.

F: LAE? Was ist die Pathophysiologie?

A: ich konnte nicht beantworten.

F: dann das macht das nicht. Welche Ursache noch für diesen Röntgen?

A: Pneumonie, Tuberkulose, Hemothorax.

F: Was noch?

A: ich bin ganz durcheinander. Ich kann nicht mehr klar denken.

Entschuldigung. F: Ok. Der Patient ist Raucher.

A:

F: Das ist Lungenkrebs. (Es war ganz deutlich, Pleuraerguss und Rauchen. Ich war der letzte Prüfling und war sehr müde)

Allgemeinmedizin

*Themen: Fragen zum klinischen Fall (**Rheumatoide Arthritis, Rheumatisches Fieber**), **DM-Komplikation, Metabolisches Syndrom**.*

Er ist ganz nett und freundlich. Er hilft immer und sagt, dass er weiß, dass ich die Antwort weiß. Er kam immer zu mir, um zu sehen, was der Innere gegeben hat.

F: Sie haben als Therapie DMARDs geschrieben. Was ist das? Andere Prüflinge hat das auch geschrieben. Ich wusste das nicht, daher musste ich vor 3. Teil im Internet gucken. (Das sagte er)

A: diese sind modifizierte anti rheumatika. Methotrexat, Ciclophosphamid, Azathiopurin usw. F: Diese sind aber Biologicals, nicht DMARDs.

A: ...

F: Wie nimmt man Methotrexat?

A: Oral, einmal wöchentlich.

F: Welche Nebenwirkungen?

A: Man muss auch Folsäure daneben nehmen.

F: Ja richtig. Nebenwirkung?

A: Übelkeit?

F: naja. (Dann hat er die Nebenwirkung gesagt, ich habe aber leider vergessen)

F: Warum haben Sie als DD nicht an Rheumatisches Fieber gedacht? Was ist der Unterschied zwischen Rheumatisches Fieber und Rheumatoide Arthritis? Ihre Diagnose ist richtig. Ich würde aber fragen, wenn der Patient vor 2 Monaten 40°C Fieber gehabt hätte.

A: Das sollte ich fragen. Das könnte sein. Der Patient hat Gelenkschmerzen symmetrisch, die Mutter hat auch Rheuma, er hat keine andere Beschwerden bei Herz und Lungen. Körperliche Untersuchung war unauffällig außer Gelenkschmerzen.

F: Welche Symptome hätte der Patient bei Rheumatisches Feiber? A: Myokarditis, Tonsillitis, Fieber, Müdigkeit, Arthritis.

F: Myokarditis? Ich glaube nicht. Wo genau im Herz betroffen?

A: Endokarditis.

F: Was verursacht diese Krankheit?

A: Streptokokken A.

F: Wie diagnostizieren wir diese Bakterien? Warum entsteht diese Krankheit?

A: Antistreptolysen-O Titer ist erhöht. Das entsteht wegen Kreuzreaktion. Unser Immunsystem kennt unsere eigenen Zellen als Antigen von Streptokokken.

F: Therapie?

A: Penicillin.

F: Geben Sie Penicillin, wenn unser Patient Rheumatisches Fieber hätte? A: Ja.

F: Nein. Das war vor 2 Monaten. Er hat keine Erreger mehr.

A: ...

F: Warum muss man Diabetes mellitus immer behandeln?

A: wegen Komplikationen.

F: Welche?

A: Mikroangiopathische: Retinopathie, Neuropathie, Nephropathie. Makro: MI, KHK, pAVK, SA usw. F: für mich sind noch 2 Komplikationen wichtig. Welche diese?

A: Diabetisches Fußsyndrom und Hyperosmolares Koma.

F: Diese sind auch wichtig. Warum entsteht aber Neuropathie? Was ist wichtig für Neuropathie?

A: (ich habe nicht verstanden, was er meinte)

F: Haben Sie schonmal diabetische otonome Neuropathie gehört?

A: Ja. Z.B. bei MI kann der Patient mit DM die Schmerzen nicht fühlen, auch die Verletzungen besonders am Fuß.

F: Ganz genau. Was ist denn mit dem Gehirn bei DM? A: DM ist ein Risikofaktor für vaskuläre Demenz.

F: Warum?

A: wegen Mikroangiopathie.

F: Aber warum genau? Was passiert bei Mikroangiopathie? A: Atherosklerose.

F: noch was?

A: ...

F: Am Hals?

A: Wegen Karotis-Stenose.

F: Genau. Was machen Sie als Therapie bei DM?

A: Lebensstilveränderungen. Mehr Bewegung. Gewichtsreduktion usw.

F: Ja diese sind sehr wichtig. Die Patient machen aber diese nicht. Der Patient kommt in 3 Monaten wieder zu Ihnen. HbA1c immer noch erhöht.

A: Orale Antidiabetika.

F: Was geben Sie?

A: ich fange mit der Therapie unter Metformin an.

F: ok. Aber vorher?

A: wir müssen Nierenwerte bestimmen.

F: ok. Nebenwirkung von Metformin.

A: Meistens Durchfall, Unverträglichkeit.

F: Wie wirkt Metformin?

A: Das verhindert die Gluconeogenese in der Leber, reduziert periferen Insulinresistenz.

F: Wie reduziert Metformin Insulinresistenz?

A:

F: Das macht die Zelle insulinsensitiver. Wie viel mg Metformin?

A: ich beginne zuerst mit 500 mg.

F: wie hoch kann man geben?

A: 2000 mg täglich.

F: naja. Man kann 3000 mg geben, aber ab 2000 mg wirkt Metformin nicht mehr. Wann geben wir Metformin?

A: Morgens.

F: Nein.

A: Abends.

F: Ja und warum? A:

F: Denken Sie bitte, was wir vorher gesprochen haben? A: Neuropathie?

F: Ja.

A: (ich hatte keine Ahnung)

F: Was macht Metformin und was hat der DM-Patient am Magen?

A: ahh, Magenentleerungsstörung.

F: Genau. Wegen Gastroparese bei Neuropathie. Haben Sie von Metabolisches Syndrom gehört?

A: Ja, Hyperlipidämie, Hyperglykämie, arterielle Hypertonie, Adipositas also Erhöhung der Bauchumfang.

F: Was ist mit der Bauchumfang gemeint? A: Fette im Bauch?

F: ja, Also?

A: ...

F: Viszerale Fette. Es gibt heutzutage etwas. Das ist ganz neu. Sie müssen das nicht wissen. Was kommt noch als Diagnose-Kriterien für Metabolisches Syndrom?

A: ...

F: Ok. Ein Patient mit DM, Adipositas. Er ist morgens sehr müde. A:

F: Er kann auch nicht gut schlafen.

A: ...

F: Er ist adipös!!!

A: Schlafapnoesyndrom. (Dann hat er darüber erzählt)

09.03.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Psychosomatik
Neubauer-Saile	Volkmann	Wiehn

Klinischer Fall: Interkostal Neuralgie

Es handelte sich um einen 56-jährigen Patienten, Herrn Schmidt, der sich wegen seit fünf Tagen bestehender Schmerzen im 5 rechten Interkostalbereich vorgestellt hat.

Der Patient berichtet über stechende bewegungs- und atmen abhängige Schmerzen entlang der rechten Rippen, ohne Ausstrahlung. Die Schmerzen verstärken sich insbesondere bei der Inspiration und in geringerem Maße auch bei der Expiration. Eine Linderung der Beschwerden tritt bei Abduktion der rechten oberen Extremität auf.

Die Schmerzen seien erstmals aufgetreten.

Dyspnoe, Husten sowie thorakales Druckgefühl oder Palpitationen wurden verneint. Ein vorangegangenes Trauma wird ebenfalls verneint. In der vegetativen Anamnese berichtet der Patient über keine Nachtschweißepisoden, kein Fieber und keine ungewollte Gewichtsabnahme. Hautausschläge seien bislang nicht aufgefallen. Miktion und Stuhlgang sind regelrecht, unauffällig.

Der Impfstatus ist altersentsprechend, jedoch besteht keine Impfung gegen Herpes zoster.

Vorerkrankungen: aHT, Zustand nach Appendektomie im Alter von 10 Jahren

Familienanamnese: Mutter gesund. Vater verstorben infolge eines Myokardinfarkts

Sozial- und Reiseanamnese: Der Patient berichtet, in den letzten sechs Monaten keine längeren Reisen unternommen zu haben.

KU: Patient in guten AZ und EZ (186cm/90kg), wach vollständig orientiert in Ort, Zeit und Persönlichkeit. VP: RR 135/80 Puls 68, kein Pulsdefizit AF 17

LK Palpation: zervikal, axial unauffällig.

Cor: rein und regelrecht kein Geräusch

Pulmo: vesicular kein rassel Geräusche, gimmen brummen.

Abdomen: weich, tastbar, schmerzlos in allen 4 Quadranten.

Thorax: Konfiguration normal, haut ohne Ausschlag und mit normalen Kolor.
Palpation Schmerzhaft in 5 ICR, kein tastbare Ödeme und Raumforderung.

Auskultation: Peristaltik in alle 4 Quadranten.

Unteren Extremität haut unauffällig mit normalen Kolor, kein Ödeme,
Palpation schmerzlos.

Mit Diagnose die Prüfer waren sehr zufrieden

Dann habe ich Arztbrief geschrieben, dafür der Zeit ist genug (30 min). Nach dem lange Wartezeit, ungefähr 2 Stunden, es war schwierig.

Chirurgie

Herr Volkmann hat viele Bilder gezeigt.

Kurze fall über Mann mit aufgetretender Thoraxschmerzen und Dyspnoe

Erste Fall: **Pneumothorax**

Dann er hat Bild mit Mantelpneumothoraks gezeigt.

Weter wir haben viel über Pneumothorax und Drainageanlage gesprochen.

Nächster Fall: **Akutes Abdomen**

Alles wurde darüber gesprochen, besonders Appendizitis mit OP und Komplikationen.

Drite Fall: **Leisten Hernie** mit einem Bild

Auch viel darüber gesprochen.

Nächste Fall: **Kompartmentsyndrom** alles muss erzählen dazu Stadien.

Dann ungewöhnlicher Fall mit einem Bild von **Olympiade** dieses Jahr, auf dem Berg liegt eine Frau. Ich muss Verdachtsdiagnose feststellen. Ich habe Verdacht auf Spiralfaktur der Tibia und Fibula mit Ruptur der Kreuzbänder sowie Ruptur der Membrana interossea. Dann er hat Röntgenbild gezeigt, es war richtig aber dazu fibula Luxation. Dann wir haben viel darüber gesprochen

Innere Medizin

Es war eines großen Gespräch über Pankreas und alle mögliche Krankheiten mit Ätiologie Pathophysiologie, Befunde bei Untersuchung, Behandlung und Komplikationen besonders hypovolemische Schock. Auch dazu haben wir über Neuigkeiten in Behandlung des Pankreaskarzinoms diskutieren

Psychosomatik

Depression. Haupt und Nebensymptomen mit Behandlung und Nebenwirkungen von Medikamenten

Dann Zwangsstörung und PTBS und es ist sehr wichtig, alles über Suizid gut zu wissen. Am ende war sehr lustig Frage: Herr hat gesagt, dass er eine eigenen Praxis offen will, wo genau muss er die Couch stellen, ich wusste es nicht, aber habe ich gesagt, dass es wichtige ist, die Griffe von Fenster raus zu nehmen. Wir haben gelacht. Und Antwort war weit von der Tür. Dann Prüfung war beendet.

In 1 Minute wurde ich benachrichtigt, dass ich die Prüfung erfolgreich geschafft habe.

Vorbereitung/Empfehlungen: Approcoaching kurs mit privaten Unterrichten war super hilfreich, vielen Dank Valeria.

09.03.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Schoppet	Heuschen	Hüttner

Klinischer Fall: Rheumatoide Arthritis

Ausstattung: Stethoskop, mechanisches Blutdruckmessgerät, Stimmgabel (die Teile sind getrennt).

Patient Herr Müller, 35 J., klagte am Anfang nur über seit 2 Monaten bestehende Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit. Nach Nachfrage gab er auch druckende Gelenkschmerzen (NRS 3–4 (kleine Handgelenke, PIP, kleine Fußgelenke, symmetrisch) in der Nacht mit Morgensteifigkeit über 2 Stunden, Kraftminderung (kann nicht mehr Flasche halten), Fieber (heute gemessen 37,9) an. Feine Fingerbewegungen seien auch nicht möglich (aktive Nachfrage), nach Aussage Hände und Füße seien geschwollen und weitere Anamnese – klassisch für rheumatoide Arthritis (RA) mit posit. Familienanamnese (RA bei Mutter, Gicht bei Vater). Andere Fragen – keine fallbezogenen Besonderheiten.

KU: Ich habe VP, fallbezogene Untersuchungen gemacht, Inspektion, Palpation von betroffenen Gelenken, Gaenseln-Zeichen (+ bds), Oppositionstest (+ bds), ... Beweglichkeit (schmerzhaft, eingeschränkt), Sensibilität (o. PB), Muskeltonus (o. PB), Muskelkraft (deutlich eingeschränkt, Hände bds.), Reflexe (o. PB) obere und untere Extremitäten überprüft (symmetrisch, lebhaft).

Da meine Anamnese + spez. KU relativ lang dauerte, hatte ich nicht genügend Zeit, um alle geplanten KUs zu machen (da ich noch Neuropathie ausschließen wollte mit Pallaesthesieprüfung – das habe ich nicht zeitlich geschafft, obwohl ich Stimmgabel zusammen gemacht habe und vorbereitet, der war nicht vollständig, nur getrennte Teile). Schon während der Untersuchung haben mir Prüfer gesagt, dass ich noch 2 Minuten habe.

Ich habe Patienten mein VD erwähnt. Er hat gefragt: „Heutzutage hat die Medizin beste Möglichkeiten für Behandlung, ist meine Krankheit heilbar?

–Mit heutigen, moderneren Medikamenten können wir Ihre Symptome wie Schmerzen langfristig lindern und die Funktion der Gelenke etwas verbessern, versprechen kann ich leider nicht, dass diese Krankheit komplett heilbar ist.

Labor: Prüfer: Machen Sie noch was in der Praxis? – Ja, ich nehme noch Blut ab, Entzündungsparameter, spezifische Antikörper. Sie haben mir sofort Blutwerte gegeben (ohne Referenzwerte): BSG erh. Rheumafaktor: erh, Anti-CCP 365, ANA-Titer: 1:80. Harnsäure: 4,7, Ferritin: 24. Ich wollte alle Patienten aufklären, habe angefangen, aber die Kommission hat gesagt: Das können Sie im Brief

schreiben. Patient und Kommission waren sehr freundlich. Während der Anamnese und KU alle 3 Prüfern haben notiert in Protokollen, was ich mache.

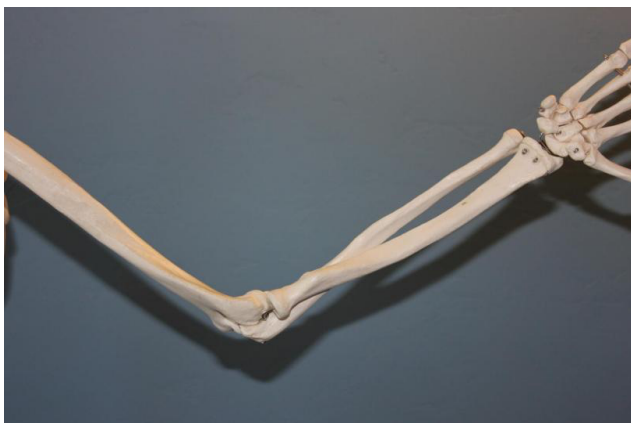
DD: Gicht, reaktive Arthritis, SLE, Osteoarthritis.

Weiteres Vorgehen: Vorstellung Rheumatologie, NSAR, GKS, DMARDs (1. Wahl: Metotrexat, 2. Wahl Sulfasalazin, Leflunamid), Laborwerte – Verlaufskontrollen (detailliert).

Nach Teil 2 habe ich während der Pause (insgesamt meine hat die Pause ca. 1 Stunde gedauert) im Flur mit meinem Musterpatienten gesprochen. Er hat mir erzählt, dass er ein Professor für Hygiene ist und dass er Handdesinfektion beobachtet hat und dass alle Prüflinge die Hände nicht richtig desinfizieren, **aber Prüfern diese Prozedur nicht bewerten. Wichtig war, dass man nicht Seife und Desinfektionsmittel mischen darf!** Aber er sagte, dass deutsche Ärzte desinfizieren Hände auch nicht immer richtig (deswegen für diese Prüfung ist das nicht dramatisch), hat mir richtig viel über RKI und Regeln erzählt)

Chirurgie

1. Professor kam zu mir mit anatomischem Modell des Handes (Knochen, Arterien, Venen ähnlich wie auf dem Foto) und sagte: „Sehen Sie: Arterien, Venen... und ich habe sofort angefangen, Gefäße zu nennen, aber er sagte: „Nein, nein) sehen Sie Knochen.“



- Welche häufigsten Frakturen kennen Sie in diesem Bereich? (Ober- und Unterarm)? / Distale Radiusfraktur
- Wissen Sie die Arten von dieser Fraktur? / Colles und Smith

- Was passiert öfter? / Colles

-Ja, 90%. Mechanismus von dieser Fraktur? / Beim Colles-Extension, beim Smith-Flexion (habe gezeigt)

-Warum passiert diese Frakturart öfter, als Smith? / Physiologische Schutzposition, wenn Patient fällt.

-Zeigen Sie bitte, wo gequecht und wo gedehnt (auf dem Modell). Zeigen Sie— palmar oder dorsal?

Welche Seite ist stabil und welche nicht stabil?

Welche Behandlung? Wie lange Ruhigstellung? / 4 Wochen

-Wie heißt diese Struktur (zeigt Olecranon)

-Bei Olekranonfraktur, welche Osteosyntheseart nutzt man? / Zuggurtung

Welches Prinzip nutzt man bei Zuggurtung Osteosynthese?

Bei welchen Frakturen wird das auch benutzt?

Hat gezeigt auf dem Röntgenbild Weber-B-Fraktur, wie heißt Fraktur?

Wenn noch malleus medialis gebrochen ist? Ist Sprunggelenk Gelenk betroffen? / Ich habe erwähnt, dass bei einer Piton-tibialen Fraktur das Gelenk beteiligt ist. Therapie?

2. Angiologie: Zu Ihnen kommt eine junge Mutter, während der Schwangerschaft – Krampfadern, Bein geschwollen, schmerzhaft. Sie sagt: Ich möchte Krampfadern entfernen lassen, meine Freundin hat eine OP gemacht und jetzt sieht das sehr schön aus. Ich möchte mich operieren lassen.

– zuerst Ultraschalluntersuchung

– US: Sie hat TVT und Varikosis. Dürfen wir operieren? / Nein, weil tiefe Venen insuffizient sind und wenn wir oberflächliche Entfernen.

- Ja, das wird Kunstfehler

– Warum entsteht Thrombose?

Virchow Trias. Warum bei Schwangeren? / Gerinnungsveränderungen und v. cava inferior Kompression.

- Was passiert mit Trombus physiologisch? / Löst sich auf. Hier habe ich grammatisch falsch gesagt (anstatt „löst sich auf – löst sich ab, deswegen hat er gesagt: Ja, das ist Richtung Thrombose“ und er meinte physiologisch, dann habe ich meinen Fehler verstanden).

– Warum entsteht nach TVT CVI? / Sterile Entzündung, Klappenschädigung

- Wie verbinden sich tiefe Venen mit oberflächliche? / Durch Perforansvenen.
 - Was empfehlen Sie dieser Frau? / Nur Kompressionsstrumpfe.
- Ja, das ist das Einzige, was wir machen können.

3. Zu ihnen kommt junge Pt. mit Bauchschmerzen, Abwehrspannung, RR 90/60 und Ps 120. Wie gehen Sie vor?

– Pt. in Schock. Sofortige Maßnahmen: nach ABCDE stabilisieren, ich lege größtenmögliche venöse Zugänge, Kristalloide, Notfalllabor, Blutgruppe, Kreuzblut, EK. Parallel Notfallgastroskopie. VD: obere/untere GIB, DD: Perforation, Pneumoperitoneum...

- Okay, sie haben 3 EKs transfundiert, er ist stabil.
 - Wird eine Gastroskopie durch Chirurgen oder durch Gastroenterologen durchgeführt? / Gastroenterologen.
 - Sie sehen endoskopisch Forrest I. Was bedeutet das? / Aktive spritzende Blutung,
 - Lokalisation – Duodenum, hinterwand. Welche Arterie? / a. gastroduodenalis
 - Therapie? / Endoskopische Blutstillung. Bei a. gastroduodenalis Blutung Adrenalin unterspitzung/wahrscheinlich nicht genügend. Ligatur, Fibrinkleber
 - Ok. Sie haben die Blutung endoskopisch gestillt.
- In 1 Tag Patient wieder instabil, RR 80/60; Taktik? / A: Laparoskopie oder Laparotomie und Blutstillung.
- Duodenum Hinterwand. Bei Laparotomie können Sie die Hinterwand Sehen? / Nein! (Ich dachte ja)
- Was machen Sie? [Ich habe ca. 3 Sekunden nachgedacht]
- / Man muss Vorderwand von Duodenum schneiden und durch Vorderwand zu Hinterwand hinkommen.
- Ja. Was machen mit Ulkus? / Ränder exzidieren, vernähen.

– Ränder kann man nicht exzidieren (das liegt am Pankreaskopf). Hat erzählt: Nath Technik (richtig – nur vernähen!)

4. Was ist Gicht? Pathophysiologie. Diagnostik. Behandlung.

Klinische Muster-Gelenkbeteiligung.

Wie heißt am Fuß? Therapie?

Was kann man chirurgisch machen?

/ Punktion.

- Nein! Darf man nicht (obwohl nach Amboss darf man diagnostische Gelenkpunktion machen. Wahrscheinlich wollte Prüfer hier chirurgische Behandlung von Tophi hören).

Es gab noch weitere kleinere Fragen, an die ich mich leider nicht erinnern kann.

Allgemeinmedizin

U. Hüttner (sehr nett und freundlich!)

– Wie heißt Gicht an der Hand? / Chiragra

DD Müdigkeit: außer klassischen DD-sen:

Bei Hyperthyreose – welcher Grund für Müdigkeit?: Hier meinte er, dass ich Schilddrüsen-OP, nach RIT und Thyreostatikatherapie erwähnen sollte (obwohl das für mich das bedeutet nicht Hyper- sondern Hypothyreose), er wollte auch Exikose hören (warum ältere Leute, wenn Sie Jetzt am Frühling auf dem Sonne spazieren-haben Müdigkeit? hier habe ich zu Richtung Hyperkalzämie gekommen, aber Dr. Hauschen hat mir Hautfalte an sich kurz gezeigt und ich gabe natürlich erwähnt, was er wollte hören - Exikose).

Hypertonie-Definition (ich habe auch zusätzlich die Definition bei der 24-St Blutdruckmessung genannt.

Klassifikation: Ursachen für essenzielle aHT?

(keine bestimmten Ursachen, Sondern Risikofaktoren) und sekundäre aHT alle Ursachen.

Was bedeutet Dipper- und Non-Dipper-BD Profil - Definition.

Welches Profil haben mehrheitlich die Pt mit aHT (Dipper) – bei essenzieller aHT.

Alle Medikamente bei aHT mit Wirkmechanismen. (Wichtig war, Aldosteronantagonisten zu nennen.)

Physiologie RAAS, Alle Wirkungen von AT II (4 Mechanismen), ADH Physiologie und wie wirkt ACE-Hemmer auf Ausschüttung? / Hemmen ADH. Noch kleinere Fragen in diese Richtung.

Organschäden bei aHT (bei Enzephalopathie wichtig: Demenz zu erwähnen,

Hypertensive Nephropathie – hat nach Laborkriterien für

Mikroalbuminurie gefragt (30–300 mg/24 h; 20-200 mg, war sehr zufrieden)

Hypertensive Retinopathie und Carotis-Atherosklerose, Aneurysmen)

Bei Myokardschädigung – außer Hypertrophie, Remodeling von Myokard, KHK, ACS, HI, wollte unbedingt noch HRST hören, besonders VHF hören, VHF-Pathophysiologie (Mikro- Reentry etc.), Therapie.
Anämien – alle Ursachen und Mechanismen (Pathophysiologie), Labordiagnostik.

Innere Medizin

Dr. Schoppert hat angefangen mit Laborbefund

Patient nach Katheterlabor hat Hypotonie, sie bekommen solche Laborwerte:

(2 Seiten Laborbefund, 6 oder 7 Blutabnahmen, jeden Tag 2–3 Mal: BB, klinische Biochemie) – Ich habe sofort gemahnt: Hb-Abfall / Anämie progressiert, Leukozytose, Hyponatriämie.

– Nennen Sie 3 wichtigste Befunde, obwohl es noch mehrere nicht signifikante Laborveränderungen gibt (andere Prüfer haben gesagt: Sie hat schon erwähnt)

– Bei Hb ist das ein starker Abfall? Während des Tages (–1 g/dL , –2 g/dL) – Ja/akute Blutung wahrscheinlich

– Am Ende Hb steigt. Warum? / Wahrscheinlich hat Patient EKs bekommen.

– Warum hat er Hyponatriämie? [Hier habe ich noch mal die ganzen 2 Seiten geschaut und nachgedacht]. Er sagte: Dort steht keine Antwort!

Dann habe ich gesagt: Vielleicht Nierenschädigung aufgrund Kontrastmittelgabe.

– Aber Nierenwerte waren in Ordnung. Dann fragte er: Was passiert im Katheterlabor? Ich habe Ablauf von Herzkatheteruntersuchung erklärt und Zugänge / durch a.femoralis oder a.radialis.

– Welche 3 wichtigsten RF bestehen bei Herzkatheteruntersuchung? Er hat selbst gesagt 1. Röntgenstrahlen, dann ich weiter:

/ Kontrastmittel und mechanische Wirkung von Kathetern

Dann habe ich nach anderen Symptomen, Ödemen, gefragt.

– Geschwollenes Bein.

Ich habe erwähnt: Wahrscheinlich hat sich ein Aneurysma spurium gebildet. a. Femoraliskatheter, akute Blutung. [Ich gehe davon aus, ich sollte einfach sagen: Hyponatriämie aufgrund der Blutung]

– Welche Symptome hat Hyponatriämie? Das ist mir nicht sofort aufgefallen,

nur allgemeine Symptome. Neurologische Symptomatik (hat er selbst gesagt)
Was machen wir diagnostisch bei diesem Pt? / CT-Angio
– Aber Patient hat schon Strahlenbelastung während der Katheteruntersuchung bekommen. Trotzdem CT? / Ja. Diagnosesicherung.
– Passiert so eine Komplikation bei radialem Zugang (Gefäßperforation)? – Ja, kann passieren. Er sagte: sehr selten.

Dann gab er mir 3 EKG-s:
in 1s habe ich erkannt, die ersten 2 EKGs waren ziemlich klassisch
EKG 1: AV-Block II. Typ Wenkenbach. Therapie. Keine HSM routinemäßig.

EKG 2: ventrikuläre ES, Bigeminus.
Ist das schlimm? Die Fragen von solcher Art habe ich nicht erwartet.
Ich habe mit der Klassifikation von VES nach Lown angefangen. Wenn wir bei 24 St -EKG das sehen, ist Lown Klasse III und das ist „schlimm“. -Aber kann das bei gesundem Herz sein? Wenn das ein paar Sekunden dauert / ja, aber Bigemenus
Anhaltendes – III. Klasse nach Lyon braucht schon Therapie und erweiterte Diagnostik, unwahrscheinlich bei gesundem Herzen.

EKG 3 – nur 3 QRS-Komplexe,
ich habe sofort folgende Veränderungen genannt: ST-Depression 3–3,5 mm in V1-V6- ischäme Zeichen vordere-laterale Wand
– Was kann ein Grund für ST-Depression sein? / Hypert. Notfall, Entgleisung, KHK...

Welche Medikamente können das verursachen? / Digitalis.

Welche Empfehlungsklasse Digitalis bei HI? / IIB.

Welcher Grundrhythmus liegt vor? Wahrscheinlich Richtig wäre VHF sofort zu nennen (ich habe erwähnt, dass ich sehe keine P-wellen, auch keine Flimmervellen, RR nicht regelmäßig, aber ich sehe nur 3 QRS komplexen, zwischen 1 und 2 QRS HF wäre 70 pro Min/ 0,8s/ dann Pause (zwischen 2 und 3 QRS Komplex HF wäre 50 pro Min /1,2 s/- Bradykardie), deswegen nur mit 3 Komplexen - kann ich nicht genau Rhythmus bestimmen), höchstwahrscheinlich VHF.

– Mit welcher Geschwindigkeit kommen Flimmerwellen bei VHF?

Röntgenbild: Hilus verbreitet, bilaterale Lymphadenopathie?

Mögliche Diagnosen? Zentrales Bronchialkarzinom, Sarkoidose, Lymphom.

– Wissen Sie Klassifikation HI nach HFrEF, HFmpEF? / Ja. Hat nicht weitergefragt.

– Zu ihnen kommt Pt mit HFrEF und möchte sich impfen lassen. Was empfehlen sie ihm?

/ Pneumokokken, RSV, H. Zoster, Influenza.

– Ist H. Zoster für Kardiopatienten (mit HI) spezifische Impfung? / Nein. [Ich habe COVID-19 vergessen zu nennen]

Andere Professoren haben mir geholfen. „Vor 3 Jahren was für Infektion haben wir gehabt?]

/ Ah, klar (COVID-19)

-Sind Sie Kandidatin für COVID-Impfung? /Ja.

-Warum?

-Ich habe keine HI Arbeit im Gesundheitssystem.

Klassische Fragen habe ich nicht detailliert beschrieben, dazwischen kamen noch einige kleine Fragen. Insgesamt habe ich versucht, sehr schnell zu antworten und auch mehr zu erzählen, als gefragt worden ist (diese Strategie klappte aber nicht bei mir mit Dr. Schoppert).

Persönlicher Eindruck: *Prof. Hauschen und Hüttner waren 74üper freundlich, haben mir geholfen und sogar während der Prüfung meine Antworten gelobt, Dr. Hüttner kam zu meinem Tisch, um zu schauen, was für EKG und Röntgen ich beschreibe, während des Innere-Teils. Das finde ich sehr unterstützend.*

Herr Dr. Schoppert war sehr ernst, sprach manchmal leise, manchmal schnell und undeutlich für mich.

Rechnen Sie bitte damit, dass er nach der Antwort keine verbale oder nonverbale Reaktion zeigt, ob das richtig oder falsch war, nur alles unemotional im Protokoll notiert und zusätzliche oder weitere Fragen stellt, sehr kurz und direkt. Und weil er keine positiven Emotionen zeigt, kann man den Eindruck haben, dass die Antworten falsch sind. Das wirkt stressig, und am Anfang hat mich solche Art der Fragestellung sogar blockiert. Aber sie sollten sicher bleiben und sicher antworten, und auch wenn ich laut nachgedacht habe – nach seinen direkten geschlossenen Fragen, versuchte ich, zusätzliche Fragen zu stellen –, erklärte er, was er gemeint hat, und führte Dialog. Deswegen ist er auch hilfsbereit, man muss aber psychologisch bereit sein, mit seiner Kommunikationsart gut umzugehen. Und am Ende beim Gratulieren lächelt er auch genau wie auf dem Foto, sogar mehr)) aber nur, wenn man es verdient))

Vorbereitung/Empfehlungen: 5 Monaten

Ausgangszustand: im Heimatland nach der Uni – Weiterbildung in Innere (Arbeit in Kardiologie Staz. 2 J, Uniklinikum), Klinische Ordinator 2 J (Uniklinikum), dann 4 J in privatem Diagnostischen Zentrum (mit vertiefter Labordiagnostik), in Deutschland – nur Hospitation 3 Mo in Praxis für Allgemeinmedizin. Vorbereitung ohne Arbeit und Kinder.

1 Monat – für Verständnis, was KP ist, Materialsuche, Gruppensuche, Protokolle lesen (ich habe 2025 J 1 Teil (Dr. Besel, danke!) am Anfang komplett gelesen und verstanden, was und wie wird gefragt), Suche nach besserer Lernart für mich. Ich habe am Anfang für die Vorbereitung 3 Monate eingeplant. Im Endeffekt hat sich die Prüfung um 2 Monate verschoben und 1 Monat für Startphase Lernen (Amboss 444, +vertiefte Verständniss mit Amboss). 4 Monaten für Wiederholung, parallel mit weiterem Lernen und Training (Simulationen)

Ambossplan am Anfang – war aber zeitlich unmöglich, mit M3 Ambosslernplan sich vorzubereiten, deswegen Stopp.

Amboss 444 Seiten konnte ich in 1 Monat beherrschen und mit Wiederholungen beginnen.

Ich habe gelesen, dass man es mindestens 6 Mal wiederholen soll, damit die Info im Kopf fest bleibt. Ich empfehle euch, euch auf die wichtigsten Themen zu konzentrieren und diese mehrmals zu wiederholen.

Deswegen habe ich 3 Monate Vorbereitung geplant mit 3 Wiederholungszyklen pro Monat (alle Themen in 8-10 Tagen sollte ich wiederholen). Natürlich war es sehr schwer, mit diesem Plan zu lernen, und manchmal habe ich 2-3 oder 4 Tage komplett frei vom Lernen gemacht, was auch sehr gut wirkt))

Wiederholung mit Struktur – täglich disziplinbezogen (z.B. 1 Tag für Pulmunologie + Endo, 1 Tag Kardio, 1 Tag Gastro ...):

- • Notfälle
- • Pharmakologie
- • Bilder, Blickdiagnosen/EKGs
- • Anatomie – für sich ausdrucken wie Aufgaben (Antworten auf Rückseite)

- • Eigene Karten (Klassifikationen, wichtigste Dosierungen und alles, was sie ständig

vergessen – für tägliche Wiederholung)

- • Wichtigste Laborwerte
- • Audio Meditorium! Hilft beim Lexik, verbessert Sprache, Aussprache von spezifischer

Terminologie: Wichtigste Themen habe ich mind. 2 Mal gehört in Vollversion, ca 2 Stunden pro Tag beim Laufen in aktiver Lernphase, dann Kurzversion.

Nicht jeden Tag, aber systematisch habe ich auch gelernt mit:

- ☞ MSTEX-Karten 2024
- ☞ KU – auf meinem Mann habe ich trainiert mit Patientenaufklärung, was ich gerade plane

und mache, und Befunde ihm aufklären. Das soll man eigentlich sehr schnell, sogar

automatisch bei der Prüfung machen.

- ☞ Protokolle 2024–2026!!! Maximal wichtig
- ☞ Protokoll mit Fragen, aussortiert von Prüfernamen in Hessen (bemerken Sie, dass

manche Prüfer von diesen Protokollen schon verstorben sind (mindestens 2)

- ☞ Protokoll „Fälle in Hessen“
- ☞ Immer Videos und Bilder und meist gefragte Themen in Amboss
- ☞ Offene Vorlesungen Valeria Müller – einfach TOP! Soll man nicht verpassen, ich

habe das spät verstanden und nur 5 Vorlesungen habe ich besucht)

- ☞ Simulieren in Gruppe oder individuell – sehr wichtig, ich empfehle Wechsel, aber

mehr individuell oder in kleinere Gruppen simulieren. Mindestens 3-4 Tagen pro Woche

- Private Simulationen mit Valeria Müller (*5 Mal, vor der Prüfung) - ich finde, dass es sehr wichtig ist, von einer erfahrenen Spezialistin individuelle Tipps und Korrekturen

zu bekommen! Das war für mich sehr hilfreich!

Vielleicht haben sie eine andere „Lernart“. Das ist sehr individuell, Deswegen kennen Sie besser Ihre eigenen Schwächen und Stärken, um sich besser vorzubereiten.

Tipp Verhalten*: Immer emotional stabil und sicher sein. Diese Sicherheit bedeutet für Prüfer, dass die Prüfung für Sie kein großer Stress ist (damit zeigen Sie, dass Sie bei der Arbeit viel mehr Stress erlebt haben, als in der Prüfung (emotional, zeitlich) und sind für stressige ärztliche Arbeit bereit).

Dankbar: Herr Nazar Basel, der Protokolle gesammelt hat, meine lieben Kollegen aus verschiedenen Ländern (Konstantin, Diana, Julia, Wissam, Asif), Valeria Müller! Sie sind die Besten!

09.03.2026 Bad Nauheim Bestanden (3. Versuch)		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
?	?	?

Klinischer Fall: Herzinsuffizienz

Herr Hermann Hoffmann, 65 Jahre alt.

*Die Prüfung begann sofort nach meinem Eintritt in den Raum: kurze Vorstellung der Prüfer*innen und des Schauspielers, schnelle Routinefrage, ob ich in der Lage bin die Prüfung abzulegen, kurzer Hinweis, wo ich meine Hände desinfizieren darf – alles dauerte maximal 40 Sekunden. Gleichzeitig wurden von anderem Prüfer der Tisch und Stühle vorbereitet, ich war die allererste bei dieser Gruppe der Kommission. Dann begann der Schauspieler sofort zu*

sprechen, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, mich als Assistenzärztin vorzustellen oder mich hinzusetzen.

Durch diesen Chaos habe ich wenigstens die wichtigste gemerkt: Belastungsknick, Dyspnoe und Ödeme, und Verdachtsdiagnose hatte ich schon im Kopf. Ich habe gar nicht gemerkt wie der Patient heißt, ich hatte das Gefühl, dass alles schief geht, ich lasse einfach den Schauspieler auszureden und Prüfern nicht mit meinem Gesichtsausdruck ("Ich werde jetzt dritten Mal nicht bestehen") provozieren. Deswegen habe ich bei erster aufgetretener Pause so zu reden angefangen: "Guten Morgen! Mein Name ist... ich bin Assistenzärztin in dieser Praxis.

Es ist sehr gut, dass sie hierhergekommen sind. Wir werden alles sorgfältig abklären und uns um Sie kümmern" (Dank „Approcoaching“ von Valeria „Tag im Praxis“) Und dann war ich sehr zufrieden dass ich endlich die Situation im Griff habe, deswegen lächelte ich und habe einfach an Patienten geschaut, um zu verstehen ob ich ihm beruhigt habe. Ich habe gesehen wie er angefangen zu strahlen im Gesicht hat und dann habe ich ganz sachlich das Anamnese Gespräch weitergeführt: "Zuerst könnten Sie mir bitte Ihren Namen buchstabieren (so konnte ich endlich sein Namen notieren), und dann alles nach Standard Anamnese Schema... Wesentliche war: Nykturie 5-6 mal, keine B-Symptomatik, Bisoprolol Candesartan, Leistungsknick und Atemnot nach 1. Stock.

KU: *Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen, dafür würde ich Sie gerne bitten, Oberkörper freizumachen" (Ps, BD, Herz, Lungen, Beine - ich habe gebeten Socken und Schuen auch auszuziehen), als ich Beine auf Ödeme untersucht habe, bekomme ich ein Bild wie tatsächlich bei Patienten es aussah (weil der Schauspieler natürlich keine Ödeme hatte). Ich habe beim Prüfer gefragt ob die Ödeme eindrückbar seien, da es sah auch wie eine prätibiale Myxödeme aus, und der Prüfer hat bestätigt: "Eindrückbar". Den Patienten habe ich gesagt, dass gegen die Wasserablagerung bekommt er Furosemid (Wasserlassende Tabletten).*

Labor/Bildgebung: *Ich informierte den Patienten, dass ich jetzt Blut abnehmen werde um BB, Glucose, Elektrolyte, Lipidprofil und NTproBNP zu bestimmen. Dann werde ich ein EKG schreiben. Ich habe dem Patienten erklärt, dass die Laborwerte in ein paar Tagen vorliegen werden und dass ich ihn bestellen werde. Falls sich sein Zustand verschlechtert, soll er sofort wieder in der Hausarztpraxis erscheinen.*

Der Prüfer sofort sagte, dass alles unauffällig, außer Kreatinin (1,5) und NTproBNP (530) ist.

Ich informierte den Patienten, dass er eine Herzinsuffizienz (Was ist das Frau Doktor? → Die Pumpleistung Ihres Herzens ist vermindert, deswegen bekommen Sie nicht genug Sauerstoff und deswegen haben Sie solche Beschwerden: Leistungsknick, Atemnot) hat, die weitere Untersuchung (EchoKG) (was ist das Frau Doktor? → Ultraschalluntersuchung des Herzens, um zu bestimmen, wie stark seine Pumpleistung reduziert ist) braucht, (in diesem Moment habe ich Ergebnisse von EchoKG bekommen, dort stand Dilatation von linken Ventrikeln und Ejektionsfraktion 30%) und erklärte dem Patienten verständlich die Situation sowie die medikamentöse Therapie.

Er hat schon Bisoprolol genommen und ARB, deswegen habe ich ihm gesagt, dass ich ARB durch ACE Hemmer ersetzen werde, dazu noch Diuretika (Spironolacton. Dieses Mal habe ich Furosemid nicht erwähnt) und Empagliflozin verordnen werde, dazu ist es wichtig zu verstehen, dass das Medikament HWI verursachen kann, überwiegen aber Vorteile des Medikaments bezüglich seiner Erkrankung: das Empagliflozin reduziert Hospitalisierungsrate und verbessert die Prognose der Erkrankung.)

Es war Pause. Dann fragte ich: "Haben Sie noch irgendwelche Fragen zu mir?" Er fragte "was ist mit Ödemen? warum habe ich das?" Ich erklärte, dass wegen der reduzierten Pumpleistung, entsteht ein Stau in den Gefäßen, was durch Druck die Flüssigkeit ins Gewebe durchpresst und dadurch Ödeme entstehen. Ich werde eine Wasserlassende Tablette dafür verordnen. Er scheint beruhigt und zufrieden. Ich hatte gefragt, ob er irgendwelche Fragen noch hat. Er hat geantwortet, dass er keine Fragen mehr hat, vielen Dank. Dann habe ich ihm gute Besserung gewünscht. Ich denke das alles dauerte ungefähr 10-13 Minuten.

Jetzt hatte ich beruhigendes Gefühl, dass ich sehr gut bei praktischem Teil war und das hat mir Selbstvertrauen gegeben.

Anschließend schrieb ich den Brief strukturiert mit Anamnese und Befund, mit NYHA II und HFrEF als Diagnose, mit Beschreibung der Therapie (s.o.) – alles wie in Lehrbüchern.

Ich habe gelesen das Protokoll von anderem Prüfling der dieselben Patient und Kommission und es wurden schon bei Anamnese Gespräch mehr Details gegeben, obwohl bei mir war entweder unauffällig oder gesund oder nur eine Vorerkrankung.

Der Schauspieler hat auch Pause gehabt, als ich gefragt habe „Wann sind Sie geboren“ Er antwortete 65 Jahre alt, also er überhaupt an die Frage sich nicht vorbereitet hat. Meine Anamnese war fast ähnlich wie bei obengenanntem Prüfling. Den Link für seinen Protokoll werde ich hinzufügen.

Fast alle Fragen bei Allgemein Medizin und Chirurgie habe ich ausführlich geantwortet genauso wie in Lehrbücher steht, deswegen habe ich nicht viel zusätzliche Fragen bekommen, ich habe einfach viel und ausführlich geantwortet einschließlich der häufig gestellten Fragen bei der Prüfung (schon im Voraus, natürlich elegant das in Antwort eingebunden) und Prüfern folgten aufmerksam was ich erzähle. Professor von Innere Medizin wollte aber eigentlich selbst das Gespräch steuern, hat aber auch ganz gut funktioniert.

Chirurgie

Es wurden mehrere Fälle vorgestellt, an die zahlreiche Fragen angeknüpft wurden.

Polytrauma – diesen Block habe ich ganz ausführlich geantwortet genauso wie bei zahlreichen Kursen geschult wurde oder im Amboss steht:

- cABCDE-Schema
- Trauma-Check
- Versorgung im Schockraum. Schockraumteam.
- FAST-Sonografie was ist das, wo sind die Punkte, was sucht man bei Polytrauma im Abdomen? Suche nach freier Flüssigkeit
- in welche Situationen sprechen wir über Polytrauma? Hier habe ich angefangen zu zählen: „Hochgeschwindigkeitstrauma, Tod eines Fahrzeuginsassen...“, wurde aber unterbrochen und Prüferin musste sich genauer ausdrücken: sie meinte: Welche Verletzungen noch definitionsgemäß gelten als Polytrauma?

Weitere Themen:

- Diagnostik und Therapie von Frakturen
- Komplikationen bei Frakturen
- Behandlung von Trümmerfrakturen

Für alle diese meiner Antworten bekam ich von der Prüferin ein „Sehr gut!“.

Ein Fall war:

Epikondyläres Humerusfraktur (19-jährige Patient) Therapie: Osteosynthese mit Kirschner-Draht

Ich habe gar nicht darüber gedacht, dass 19-jähriger zählt man als Kind in dem Fall. Deswegen habe ich leider nicht Kirschner Draht genannt, obwohl ich das eigentlich wusste. Die Prüferin war darüber sichtbar unzufrieden. Ich frage mich im Nachhinein, ob sie sich einfach versprochen habe: „Ein Patient 9... 10 Jahre alt“, die ich bloß akustisch als „19 Jahre alt“ wahrgenommen habe (?).

Hier hatte ich das Gefühl, dass ich Boden verliere, versuchte aber strukturiert zu antworten entsprechend der Grundprinzipien der Osteosynthese.

Dann Fall junge Patientin mit Unterbauchschmerzen was kann das sein, und Fragen die ausführliche geantwortet wurden, waren: was ist akutes Abdomen. Die möglichen

Ursachen anhand der Lokalisation. Was ist CED, was sieht man bei apparativer Diagnostik bei M. Crohn, Unterschied, welche Komplikationen haben CED. Hier immer wieder habe ich „Sehr gut!“ bekommen, dass ich doch Hoffnung hatte, dass eigentlich es gut läuft!

Allgemeinmedizin

Hypothetischer Fall:

Gleiche Symptomatik wie im praktischen Teil, aber zusätzlich Fieber und ein neu aufgetretener Rechtsschenkelblock (RSB). Was konnte es sein?

- Lyme-Karditis
- Myokarditis

Weitere Fragen:

- Therapie von Lyme-Karditis, Myokarditis und infektiöser Endokarditis
- antidiabetische Therapie (Medikamentengruppen, Wirkmechanismen, Nebenwirkungen)
- Anwendung von SGLT-2-Inhibitoren und DPP-4-Hemmern auch außerhalb der Diabetesbehandlung.

Sulfonylharnstoffe Nachteile im Vergleich zu anderen Antidiabetika

Die oben genannten Fragen aus der Allgemeinmedizin habe ich ausführlich beantwortet, genau so, wie es in den Lehrbüchern steht. Deshalb erhielt ich nicht viele zusätzliche Fragen; ich habe einfach umfassend geantwortet, und die Prüfer folgten meinen Antworten aufmerksam. In meinen Antworten habe ich bereits die häufig gestellten Prüfungsfragen elegant eingebunden. Den gesamten Text hierher zu tippen, halte ich für sinnlos, da es im Grunde das ist, was in den Büchern steht und leicht nachzuschlagen ist.

Hallux valgus (Bild)

- konservative Therapie • operative Therapie

Bildbefund

Fibrinbelegter Rachen → mögliche Komplikationen nach Tonsillektomie

Innere Medizin

1. Pneumonie

- Klinik. Was hört man bei der Pneumonie? (*kleinblasige Rasselgeräusche*) • Diagnostik
- strukturierte Beschreibung eines Röntgen-Thorax
- Therapie
- CRB-65
- Welche Tests macht man bei stationärer Aufnahme? (Covid Test; Influenzas A, B und RSV)
- CAP vs. HAP
- Risikoeinschätzung
- Antibiotikatherapie Weitere Themen:

2. „Big Six“ der Thoraxschmerzen. Alles: Klinik, Diagnostik, Diff. Diagnostik. 3.

EKG: Vorderwandinfarkt / ACS. Vorgehen und Therapie. Alles

4. Anämien – Einteilung, Ursachen, Diagnostik und Therapie

Es waren noch Fragen leider kann ich sie nicht alle erinnern.

Dann wurde ich gebeten, den Raum zu verlassen und kurz zu warten. Nach ungefähr 30 Sekunden wurde ich wieder hereingebeten.

Ich wurde gefragt: „Vorher haben Sie aber viel länger gewartet?“

„Ja.“

„Haben Sie ganz viel gelernt?“

„Ja.“

„Das hat sich gelohnt. Glückwunsch!“ Und er hat mir die Hand geschüttelt.

Ich habe vor Glück geweint.

Atmosphäre der Prüfung

Zwei Prüfer ließen mich ausführlich antworten und folgten meinen Erklärungen aufmerksam.

Ein Prüfer wollte den Gesprächsverlauf stärker steuern, sodass ich mich etwas bremsen musste – was aber gut funktioniert hat.

Dieses Mal habe ich mich genau so präsentiert, wie es die Dozenten des mibeg Institut Medizin empfohlen haben.

Ob das mein Ergebnis beeinflusst hat, weiß ich nicht – aber es hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben.

(Na gut, ich muss sagen, diesmal war Prüflingen beim Briefschreiben endlich stilles Wasser zur Verfügung gestellt. Bei den beiden vorherigen Versuchen habe ich immer unter Durst gelitten, weil ich kein Sprudelwasser trinke. Diesmal musste ich die Prüfer also gar nicht erst fragen – vor mündlichem Teil)

Vorbereitung/Empfehlungen: Mein Erfolg bei praktischem Teil ist dank

1. Anamnese-Schema die ich noch bei Nathalia Dähne Kurs „Vorbereitung auf die FSP“ gelernt habe.
2. Körperliche Untersuchung: Valeria Kurs „Tag im Praxis“ sehr empfehlenswert.
3. Gründliche Verarbeitung des Themas „Herzinsuffizienz und medikamentöse

Therapie bei der Herzinsuffizienz“ während dem mibeg Institut Medizin Kurs „Qualifizierung für Klinik und Praxis“

erreicht.

Meine Vorbereitung bestand aus mehreren Komponenten (*Chronologisch dargestellt*):

- **“Approcoaching”** von Valeria
- **mibeg Institut Medizin (6 Monaten)**
- Natalia Dähne (KP-Vorbereitung)
- **Simulationen mit M. Behrends** [behrends](#)

<http://approcoaching.com.tilda.ws/kurse> <https://www.anererkennung-nrw.de/mibeg-institut-medizin/>

<https://medizinwissen.org/course/einzeltraining-mit-matthias->

- **Mohamad Workshop und zusätzliche Privatstunden**

https://t.me/KP_Notizen (*es ist gemeinsame Gruppe*)

Ich habe täglich mindestens 5–6 Stunden intensiv gelernt 7 Tage pro Woche, häufig gemeinsam mit Lernpartnerinnen.

Über eine Telegram-Gruppe habe ich eine sehr gute Lernpartnerin gefunden und im Kurs noch eine weitere. Danke euch Mädels

In den letzten 3 Monaten vor der Prüfung habe ich besonders intensiv gelernt: von morgens bis abends, 7 Tage pro Woche.

Lernquellen

Meine wichtigsten Materialien waren:

- Vorbereitung auf die KP 444 - auswendig gelernt
- KP erfolgreich bestehen - auswendig gelernt
- Valeria Kurse Skripten - auswendig gelernt, obwohl es mir viel Zeit und Nerven gekostet hat, die Tippfehler immer wieder zu überprüfen und

nachzuschauen. Die Vorlesungen von Valeria sind aber **sehr** gut und eigentlich reichen für KP! Ihr Kurs heißt: „Approcoaching“

- 60 Fälle Chirurgie sorgfältig verarbeitet
- EKG für Isabel sorgfältig verarbeitet
- Kurzlehrbuch Pharmakologie - durchgelesen, mehrmals Antidiabetika, Antihypertensiva, ATB davon wiederholt.

Als Nachschlagewerke:

- Amboss
- Herold (Innere Medizin)
- Die MindMaps von Herrn Behrends (Muttersprachler)
- Müller (Chirurgie)
- Appetizer Chirurgie Youtube Channel (Muttersprachler)

Außerdem zusätzlich:

„Heidelberger Standardprozeduren „Last Minute Bildgebende Verfahren“ Braun
„Innere Medizin“

Ludwig „Repetitorium Innere Medizin“

Lernkarten MEX

MEX Innere Chirurgie

MEX Allgemein Medizin

Wennemuth „Taschenbuch Histologie“

Dölcker „Differenzialdiagnostik und Leitsymptome kompakt“

Uniklinik Aachen „Begleitskript Untersuchungsskript und Blockpraktikum

Orthopädie“ Okan Samanci „EKG-crushkurs“

Zahlreiche Video und Podcasts aus dem Amboss

Zahlreiche Video Mediknow (Youtube)

Kurse – meine persönliche Einschätzung

1. **„Approcoaching“ Kurs von Valeria** ist **sehr gut**, aber für mich persönlich allein nicht ausreichend gewesen, obwohl das **schon reichen konnte**, denn ich ihre Skripten durchgearbeitet und auswendig gelernt habe.

<http://approcoaching.com.tilda.ws/kurse>

(Beim zweiten Versuch hatte ich leider großes Pech mit der Kommission. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass der Vorsitzende persönlich unzufrieden mit mir war. Dies wirkte sich stark auf den Prüfungsverlauf aus: Der Ablauf wurde beschleunigt, er sprach teilweise leiser, sodass ich mehrfach um

Wiederholung bitten musste. Am Ende verließ ich die Prüfung sowohl physisch als auch psychisch erschöpft.

Nach Erhalt meines Prüfungsprotokolls fiel mir auf, dass das Protokoll aller drei Fachbereiche vom Vorsitzenden geführt wurde, und dass an einigen Stellen Abzüge erfolgten, obwohl meine Antworten korrekt waren. Dies erschütterte mein Vertrauen in das Bewertungssystem und verursachte erheblichen Stress.

Ich habe diesen Versuch bisher nicht beschrieben, da er für mich sehr belastend war und ich unsicher war, ob mir geglaubt würde. Erst nach meiner erfolgreichen dritten Prüfung habe ich den Mut gefunden, darüber zu berichten.

Dank dieser Erfahrung wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, sich maximal vorzubereiten. Deshalb verschob ich den Termin für die dritte Prüfung so weit wie möglich und bereitete mich intensiv vor, wobei ich noch mehr Zeit, Geld und Mühe investierte.

Ich möchte betonen, dass dies meine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen während dieser Prüfung sind. Ich bin überzeugt, dass eine faire und respektvolle Prüfungsatmosphäre entscheidend für die Bewertung der Kandidaten ist.)

2. Deshalb habe ich den **Kurs „Qualifizierung für Klinik und Praxis“** beim **mibeg Institut Medizin** in Köln **online** besucht. <https://mibeg-institute.de/weiterbildungen/medizin/anererkennung-gesundheitsberufe/qualifizierung-klinik-praxis>

Die Inhalte dort waren für mich sehr strukturiert, tiefgehend und praxisnah. Dort habe ich außerdem viele muttersprachliche Ärztinnen und Ärzte kennengelernt und eine feste Lernpartnerin gefunden.

Besonders hilfreich:

3) Matthias Behrends persönliche Simulationen

<https://medizinwissen.org/course/einzeltraining-mit-matthias-behrends>

Die Simulationen mit Herrn Behrends haben mir eine sichere Routine gegeben. Nach meinem zweiten Versuch hatte ich ein großes Misstrauen gegenüber der Prüfung entwickelt – durch die Simulationen konnte ich dieses Gefühl überwinden. Es waren einfach Simulationen von mündlichem Teil und auch ein Unterricht - Simulation des praktischen Teils. Dort hat er festgestellt, dass ich das stabil in 13 Minuten schaffe, und das hat mein Selbstvertrauen gestiegen.

Mit diesem netten und professionellen Muttersprachler habe ich bis letzten Tag vor der Prüfung vorbereitet. Ich bin ihm sehr dankbar für die Flexibilität, Kenntnisse, Art zu korrigieren oder Hinweise zu geben. Die Simulationen mit Herrn Behrends werde ich auf jeden Fall empfehlen! Auf jeden Fall.

4) Mohamad Notizen Workshop und Privatunterrichten

https://t.me/KP_Notizen - es ist gemeinsame Gruppe, schreib dort um an Workshop teilzunehmen. Sehr empfehlenswert.

Herr Mohamad vermittelt, wie man klinisch nach deutscher Denkweise argumentiert, und gibt viele praktische Hinweise zur Kommunikation mit Prüfern.

Besonders wertvoll ist seine Simulation eines sehr strengen Prüfers. Der Workshop dauert maximal zwei Wochen und eignet sich besonders für die letzte Phase der Vorbereitung.

Was ich persönlich nicht empfehlen würde:

- Multisprachen Hannover (2022) Leider war meine Erfahrung dort nicht gut:
- organisatorische Probleme
 - häufige technische Schwierigkeiten
 - Rechnung kam erst ein Jahr später
 - Preis etwa 2000 € für 1,5–2 Monate

Ein wichtiger Punkt für Kollegen aus Kriegsgebieten

In der Kenntnisprüfung wird häufig nach **sicheren und unsicheren Todeszeichen** gefragt. Die **offizielle Feststellung des Todes** auf Basis dieser Zeichen ist **Pflicht eines approbierten Arztes** in Deutschland.

Für Menschen aus Kriegsgebieten kann dieses Thema jedoch sehr belastend sein. Bei meiner ersten Prüfung wurde ich durch diese Frage stark **getriggert** und bekam **Flashbacks**. (Ich habe vor, in ein paar Tagen mein 1. Versuch beschreiben) Ich konnte nicht gut deswegen antworten und das war letztlich das Hauptargument, warum ich damals nicht bestanden habe.

Mein Rat:

Wenn ihr merkt, dass euch solche Themen emotional stark belasten, **verarbeitet**

zuerst das Trauma, bevor ihr (zum ersten Mal oder erneut) in die Prüfung geht.

- Sichere Todeszeichen: Totenflecken (Livores), Totenstarre (Rigor mortis), Zersetzung/Fäulnis. Nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen, z.B. Dekapazität.
- Unsichere Todeszeichen: Pulslosigkeit, Atemstillstand; Bewusstlosigkeit; Blässe oder Vertrocknung der Haut; Areflexie; Lichtstarre, weite Pupillen; Hornhauttrübung; Hypothermie.

Vorgehen beim Tod:

TZ überprüfen → gibt es sichere TZ? → Leichenschau machen → Totenschein ausfüllen. Bei nicht natürlichen/ ungeklärtem Tod → Polizei anrufen.

An alle, die nicht bestanden haben:

Mein herzliches Mitgefühl .

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie belastend diese Situation sein kann. Nach meinem ersten Versuch habe ich lange gebraucht, um wieder stabil lernen zu können und habe angefangen mit muttersprachlichen Psychologen zu arbeiten.

Nach dem zweiten Versuch habe ich zusätzlich medikamentöse Unterstützung (Antidepressiva) begonnen. Das hat mir sehr geholfen und meine Rückkehr zum Lernen deutlich erleichtert.

Wenn ihr gerade durch diese Phase geht, möchte ich euch eines sagen:

Ihr seid nicht allein.

Nehmt euch Zeit, euch zu erholen und vorbereitet zurückzukommen. Verschieben des nächsten Prüfungstermins so spät wie möglich, um ganz sicher zur Prüfung gehen zu können: Es geht um **euren Leben** und **eure Zukunft**.

Ich umarme euch herzlich .

Es gibt auch Vorteile, dass man sich so lang vorbereitet hat, na jetzt z.B. weiß ich warum bei Morbus Menier (Hörminderung bis Taubheit ist ein von 3 Symptomen) man Gentamicin verordnet, obwohl eigentlich das ototoxisches Medikament ist. Vorher hatte ich keine Zeit so tief in dem Lernstoff zu gehen (Allgemein Medizin). Zweitens bin ich viel resilienter geworden, als ich

eigentlich vorher schon war. Und drittens bin ich sehr stolz auf mich das ich das durch die Kenntnisprüfung gemacht habe.
Der größte Sieg meines Lebens!

09.03.2026 Bad Nauheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Jungbauer	Hanisch	Wunder

Klinischer Fall: pAVK

Patient, 70 Jahre alt, mit Schmerzen im rechten Bein seit 3 Tagen. Er kann nicht mehr als 150 Meter gehen.

Vorerkrankungen:

Hypertonie, Hyperlipidämie, Kein Diabetes mellitus, Nichtraucher

Medikation: Ramipril, Statine wurden in den letzten Monaten durch den Hausarzt pausiert

Sozialanamnese: Rentner, früher als Büroschreibkraft tätig

Verheiratet, ein erwachsenes Kind

Kein Sport im gesamten Leben

- Gewicht: 105 kg
- Größe: 183 cm

KU: Puls: unregelmäßig, Herz und Lunge: ohne pathologischen Befund

Rechtes Bein: Kalt, Keine Hautveränderungen, Puls in der A. poplitea und am Fuß nicht tastbar. In der Leiste kaum tastbar

Die Lagerungsprobe wurde durchgeführt, die Ergebnisse wurden jedoch nicht genannt. Ich habe vergessen, nach weiteren Details zu fragen.

ABI: 0,6

Ich habe nach apparativer Diagnostik gefragt.

Prof. Hanisch antwortete, dass wir uns in der Praxis befinden und nur Laborwerte vorliegen.

Labor: Hb und Leukozyten waren unauffällig.

Daraufhin habe ich entschieden, den Patienten ins Krankenhaus einzuweisen.

Ich habe einen Arztbrief geschrieben und den Patienten mit dem Rettungswagen geschickt.

Im Brief habe ich den Verdacht auf einen akuten arteriellen Verschluss bei Vorhofflimmern formuliert.

Innere Medizin

Der Prüfer begann mit folgendem Fall:

Ein Mann kommt mit Beinschwellung.

Ich fragte, ob einseitig oder beidseitig → Antwort: beidseitig.

Ich fragte nach Vorerkrankungen → keine.

Alter → 43 Jahre.

Ich fragte nach periorbitalen Schwellungen → ja.

→ Verdacht: **nephrotisches Syndrom.**

Leitsymptome (meine Antwort):, Periorbitale Ödeme, Beinödeme, Hypertonie

Der Prüfer korrigierte:

Hypertonie gehört nicht dazu, sondern eher zum **nephritischen Syndrom.**

Danach hatte ich einen Blackout und sagte etwa 1 Minute nichts.

Der Prüfer nannte: Ödeme, Albuminurie, Hypoalbuminämie

Therapiefrage: **Behandlung der Albuminurie**

→ Meine Antwort: ACE-Hemmer (nephroprotektiv)

Nachfrage: Warum nephroprotektiv?

→ Konnte ich nicht richtig erklären

Weitere Fragen -- Brustschmerz:

Ich fragte nach Charakter, Lokalisation, Stärke und Ausstrahlung.

→ Rechtsseitig, dumpf-brennend, ohne Ausstrahlung

→ Ich forderte EKG und Troponin → normal

→ Röntgen-Thorax → normal

→ Verdacht: muskuläre Schmerzen oder pulmonale Ursache

Kollaps im Krankenhaus:

Ich fragte nach Setting (intra-/extraklinisch) → intraklinisch

→ Reanimationsteam alarmieren

Prüfer: Sie sind das Reanimationsteam

→ Ich erklärte die Reanimation

Fragen zu:

- **Schockbaren und nicht schockbaren Rhythmen**
- **4H und HITS** → konnte ich nicht beantworten

Der Prüfer wurde unzufrieden und erklärte sie selbst.

Betablocker: Was sind sie? Wie einleiten?

Meine Antwort: hohe Dosis

→ Korrektur: mit niedriger Dosis beginnen und **steigern**

Diabetes mellitus:

- Komplikationen
- Untersuchung bei Polyneuropathie

Meine Antwort: Stimmgabel

Der Prüfer ließ mich die Untersuchung praktisch durchführen. → Ich machte es falsch

Er erklärte:

“Diese Stimmgabel sei für den Weber-Test (HNO) und nicht geeignet für Polyneuropathie.”

Allgemeinmedizin

- Normales EKG
- EKG mit AV-Block III°. → Therapie: DDD-Schrittmacher

Bild: Herpes Zoster → Therapie?

Viele kleine Fragen (Antibiotika, Fieber etc.), die ich beantworten konnte.

Chirurgie

Prof. Hanisch fragte:

Warum Transport mit Rettungswagen und nicht mit dem Auto?

→ Meine Antwort: unregelmäßiger Puls, Verdacht auf Vorhofflimmern und akuten arteriellen Verschluss (akut auf chronisch).

Er reagierte positiv.

Weiterer Fall: Ein schlanker junger Patient mit plötzlicher Atemnot.

Fragen: Asthma bekannt? → nein | Raucher? → nein | Hautveränderungen? → nein

Untersuchung:

- Rechts hypersonorer Klopfeschall
 - Atemgeräusch vermindert
- Verdacht: Spontanpneumothorax
- Röntgen-Thorax bestätigt Diagnose

Ich erklärte:

- Fehlendes Lungengewebe rechts (schwarz)
- Pleuralinie
- Mediastinalverlagerung nach links

Therapie: → Thoraxdrainage

Frage nach **Arten der Thoraxdrainage** → ausführlich beantwortet

Notfallsituation: RR 80, Puls 120, Atemnot

→ Sofortige Entlastung ohne Röntgen

→ Prüfer sehr zufrieden

Akutes Abdomen:

- Definition
- Ursachen (intra- und extraabdominell)
- Differentialdiagnosen
- Diagnostik
- Therapie

→ Strukturiert beantwortet

→ Sehr zufrieden

Chirurgie war mein bester Teil.

Ergebnis

Ich wurde gebeten, den Raum zu verlassen.

Nach ca. 8 Minuten wurde ich wieder hereingerufen.

Dr. Jungbauer (Innere Medizin) betonte nochmals meine Fehler, insbesondere zur Pharmakologie der Betablocker. (Viele Fragen über Betablocker gefragt:

Pharmakologie

Welche Rezeptoren?

Und Einsatz bei MI

Prognose verbessende oder nur Symptome verbessende

Wie konnten Sie einleiten?)

Prof. Hanisch sagte, dass er und der Kollege aus der Allgemeinmedizin nichts weiter hinzuzufügen haben.

Nach kurzer Pause:

Trotz der Fehler in der Inneren Medizin habe ich die Prüfung bestanden.

Die chirurgischen Antworten waren sehr gut, und auch die Allgemeinmedizin war zufriedenstellend.

Vorbereitung/Empfehlungen: Ich habe die Bücher 80 Fälle aus der Inneren Medizin und 50 Fälle aus der Chirurgie intensiv gelernt. Zusätzlich habe ich einen Kurs bei EZplus in Stuttgart besucht – der Kurs war wirklich sehr gut und hilfreich.

In den Monaten nach Weihnachten habe ich mich dann vor allem auf die hessischen Protokolle konzentriert und diese intensiv durchgearbeitet.

Ich wurde gefragt: was meine ich mit Protokolle durcharbeiten.

Durcharbeiten heißt: lesen und auswerten ~ evaluieren

Mein Tipp für euch zu den Protokollen: Es reicht nicht, sie nur mit einem Lernpartner/ einer Lernpartnerin zu üben. Wichtig ist vielmehr, dass ihr jede Frage wirklich genau versteht – warum sie so formuliert ist und welche Prinzipien dahinterstecken.

13.03.2026 Marburg		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
?	?	?

Klinischer Fall: Schwindel

65-jährige Frau mit Schwindel, sonst keine relevanten Vorerkrankungen. Es handelte sich um Drehschwindel seit etwa 2 Wochen.

Ich habe leider keine neurologische Untersuchung gemacht, weil ich sehr nervös war und es vergessen habe. Normalerweise sollte man aber unbedingt eine neurologische Untersuchung durchführen.

Ich habe ein EKG angeordnet – es war aktuell unauffällig.

Allgemeinmedizin

Bilder → 1. Trommelfell (Tympanic membrane)

- Lichtreflex beschreiben
- In welchem Quadranten und auf welcher „Uhrzeit“

2. Glaukom

- Welche Untersuchung sollte der Hausarzt durchführen?

3. Akne

- auf der Stirn und Wange

4. Bindehautblutung (Conjunctival bleeding)

- Ursachen
- Alles über Marcumar

5. HWI (Harnwegsinfektion)

- Therapie (als Hausarzt – was kann ich verschreiben?)
- Achillessehnenruptur durch welche Antibiotikagruppe

6. Impfungen

7. EKG:

- Vorderwandinfarkt (Anterior wall MI)

- Hinterwandinfarkt (Posterior wall MI)
- Therapie

Chirurgie

1. Alter Mann in der ZNA, vom Hausarzt überwiesen wegen Blut im Stuhl.

Ich habe zuerst gefragt, ob der Patient hämodynamisch stabil ist – er sagte ja.

Danach habe ich mit der Anamnese begonnen und kam schließlich auf die Differentialdiagnose kolorektales Karzinom.

Er hat sehr ausführlich nach kolorektalem Karzinom gefragt:

besonders Rektumkarzinom. Anokutane Linie, Lymphatische Metastasierung, Hämatogene Metastasierung → auch beim Kolonkarzinom

Außerdem: Diagnostik, Therapie, Chemotherapie, Radiotherapie

2. Komplikationen nach Schilddrüsenoperation

- Calcium alles
- Parathyreoidea alles

3. Akutes Abdomen: Definition, Ursachen, Extraabdominelle Ursachen

Er wollte besonders hören: Pneumonie, Hinterwandinfarkt

4. Metabolische Ursachen:

- DKA
 - Addison-Krise
 - Urämie
-

Innere Medizin

1. Fragen zum Fall (Schwindel)
 2. Differentialdiagnosen von Schwindel – alles besprochen
 3. **Zeichen** eines **Kleinhirnfarkts**
 4. **6 P** beim akuten arteriellen Verschluss
 5. **Pneumothorax**
 6. EKG-Diskussion (theoretisch)
 7. **Atropin**: Wirkmechanismus, maximale Dosis
 8. **Schock**: Definition, Therapie
 9. **HWI**: kompliziert vs. unkompliziert
 10. **Leberzirrhose** – klinische Zeichen
-

Vorbereitung/Empfehlungen:

Protokolle sind sehr wichtig. Sie geben eine gute Orientierung, wie man anfangen soll. Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die ihre Prüfungserfahrungen geteilt haben.

Ich habe parallel zur Arbeit gelernt – etwa 1–2 Stunden nach der Arbeit und am Wochenende.

Ab Dezember habe ich intensiver gelernt (3–4 Stunden täglich ohne Pause), zusammen mit einem Lernpartnerin. Dann allein

Viele Themen habe ich zuerst auf YouTube angeschaut, Notizen gemacht und später wiederholt.

Ich habe keinen Kurs gemacht – nur Selbststudium, ChatGPT, YouTube und Diskussionen mit meinem Mann, der sich ebenfalls auf die Prüfung vorbereitet hat (an einem anderen Termin – Gott sei Dank hat er auch bestanden).

Die Prüfer sind freundlich und helfen einem, zur richtigen Antwort zu kommen.

27.03.2026 Marburg		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
?	?	?

Klinischer Fall: Diabetis Mellitus Typ 2

Frau D klagt seit mehreren Wochen über Müdigkeit und Infektneigung.

In der weiteren Anamnese: häufiges Wasserlassen in der Nacht, Durst, schlechtes Sehen.

Innere Medizin

Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2.

Welche Antikörper gibt es bei Typ-1- Diabetes?

Welcher Wert zeigt den durchschnittlichen Blutzucker der letzten 2 Wochen- Fruktosamin. Erklärung, warum?

Was ist Diabetes Typ 3? Auch wichtig: Zustand nach Entfernung des Pankreas. Nach Entfernung welchen Teil ist das Risiko für Diabetes am größten?

Behandlung von Typ-2-Diabetes.

Merformin- wie wirkt es? Nebenwirkungen?

Was sind GLP-1-Analoga?

Wo werden die Inkretin-Mimetika im Körper gebildet? In welchem Teil des Darms, welche Zellen?

DPP-4- Hemmer, Mechanismus?

Kurz zum metabolischen Syndrom.

Typ-1, oberflächlich, Komplikationen, Behandlung von Komplikationen.

Diabetes insipidus, wo wird Vasopressin gebildet?

Cushing syndrom, nicht tief.

Nephrotisches Syndrom. Warum entsteht dabei die Hyperlipidämie?

Allgemeinmedizin

Was macht ein Hausarzt, was unterscheidet ihn von anderen Fachärzten?

Konjunktivitis (Bild): Ursachen, Behandlung.

Welche Allergene sind möglich bei allergischer Konjunktivitis?

Ein 45-jähriger Patient, Vorsorgeuntersuchung.

Aufklärung DRU. Wie beschreibt man Prostata bei der Palpation?

Welche Impfungen braucht ein 65-jähriger Patient mit Diabetes mellitus (nach STIKO, wollte auch RSV hören).

CT des Kopfs: Hirnatrophie, Hydrozephalus - mögliche Ursachen.

Arten von Demenz.

Alzheimer, vaskuläre Demenz, welche ist häufiger?

Chirurgie

Patient mit Blut im Stuhl, stabil, was tun?

Welche genetische Mutationen gibt es beim Kolonkarzinom (RAS, BRAF) und warum ist es wichtig zu erkennen?

Patient mit langstreckigem Verschluss an A. femoralis, a. Poplitea. Therapie?

Bei Diabetes: was ist besser für Bypass - künstliche Prothese oder Vene?- Vene.

Patient mit DM, Fieber, starke Schmerzen im Bein, Puls vorhanden, Entzündungswerte erhöht. Gefährliche Komplikation?- nekrotisierende Faszitis

Kurz über Behandlung.

Grundprinzipien der Behandlung der akuten Pankteatitis.

27.03.2026 Marburg		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Psychosomatik
Schoppet	Hanisch	Wiehn

Klinischer Fall: Thoraxschmerzen

Die Patientin berichtete über seit acht Stunden bestehende Brustschmerzen im linken Thorax, die sie als drückend und stechend beschrieb, ohne Ausstrahlung. Die Schmerzen verstärkten sich beim Einatmen. Zusätzlich bestand eine Belastungsdyspnoe bereits bei kurzen Strecken. Ich überprüfte zunächst die Vitalparameter (Puls und Blutdruck beidseitig) und verabreichte ein Schmerzmittel. Die Patientin gab an, dass es ihr aktuell besser gehe.

Fieber, Husten, Auswurf, Schwitzen, Gewichtsveränderungen oder andere vegetative Symptome verneinte sie. Anschließend stellte ich weitere anamnestische Fragen.

KU: Der Prüfer wies mich darauf hin, dass nur noch drei Minuten verbleiben. In dieser Zeit führte ich die Herz-, Lungen- und abdominale Untersuchung durch und erklärte dabei laut die einzelnen Untersuchungsschritte. Bei der körperlichen Untersuchung habe ich die Händedesinfektion vergessen und mich zweimal vor der Patientin entschuldigt. Bei der Herzuntersuchung nannte ich alle fünf Auskultationspunkte und auskultierte im 4.–5. ICR links medioklavikulär. Dabei lag das Stethoskop teilweise auf dem BH (ca. 15 %), was von den Prüfern bemerkt wurde. Anschließend informierte ich die Patientin, dass sie sich wieder anziehen könne.

Die Patientin fragte nach dem weiteren Vorgehen. Ich erklärte, dass ich zunächst ein EKG, eine Blutuntersuchung und eine Echokardiographie veranlassen würde. Der Prüfer teilte mir jedoch mit, dass die Zeit abgelaufen sei. Ich verließ das Zimmer, erklärte aber, dass die weitere Diagnostik fortgesetzt werde.

Labor/Bildgebung: Auf Nachfrage nannte ich EKG, Blutbild und Troponin. Der Prüfer übergab mir anschließend lediglich die Troponinwerte sowie einen EKG-Ausdruck. Das Troponin war unauffällig. Die Qualität des EKGs war jedoch schlecht, sodass ich pathologische Veränderungen zunächst nicht sicher erkennen konnte. Unter Zeitdruck musste ich anschließend direkt mit dem Arztbrief beginnen und wurde dafür ins erste Obergeschoss begleitet.

Briefschreiben

Ich erstellte innerhalb von 25 Minuten einen strukturierten Arztbrief mit dem Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom sowie den Differenzialdiagnosen Lungenembolie, Pneumothorax und Pleuritis.

Während des Schreibens überprüfte ich das EKG erneut und erkannte ein P-pulmonale sowie ein Q3T3-Muster, was auf eine Lungenembolie hinweist. Aufgrund des Zeitdrucks konnte ich den Brief jedoch nicht mehr innerhalb der vorgesehenen Zeit korrigieren und die Diagnose anpassen, sodass diese unverändert blieb.

Die klinische Untersuchung hatte initial eher für ein akutes Koronarsyndrom gesprochen. Nach dem Schreiben tauschte ich mich mit einer anderen Prüflingin aus. Dabei reflektierte ich, dass ich sowohl bei der körperlichen Untersuchung als auch im Arztbrief nicht alle Details optimal umgesetzt hatte. Sie berichtete ebenfalls, dass viele Prüflinge mit ihrem Brief unzufrieden waren.

Reflexion vor der mündlichen Prüfung

Ich nutzte die Zeit bis zur mündlichen Prüfung, um den Fall gedanklich zu analysieren. Insgesamt waren Anamnese, körperliche Untersuchung und Arztbrief strukturiert und korrekt durchgeführt.

Allerdings passte meine Verdachtsdiagnose nicht zu den EKG-Befunden, und auch die körperliche Untersuchung war nicht vollständig mit der EKG-Diagnose vereinbar.

Aber trotzdem habe ich mir bis eine Weile Sorgen gemacht. Ich habe Brief so geschrieben: Arztbrief:

Name: Frau X, Alter: 63 Jahre, Gewicht: 74 kg, Größe: 178 cm

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wir berichten über die 63-jährige Patientin Frau X, die sich am 27.03.2026 in unserer Praxis vorgestellt hat.

Verdachtsdiagnose: ACS

Vorerkrankungen: arterielle Hypertonie seit 2 Jahren

Aktuelle Anamnese:

Die 63-jährige Patientin stellt sich heute in unserer Praxis mit seit 8 Stunden bestehenden erstmaligen thorakalen Schmerzen links sowie belastungsabhängiger Dyspnoe vor.

Laut Patientin seien die Schmerzen 6/10 auf der NRS, ohne Ausstrahlung, stechend und drückend und verschlimmern sich beim Einatmen.

Zudem klagte sie über Atemnot bei kurzen Strecken und beim Fahrradfahren.

Die Fragen nach Husten, Orthopnoe, Auswurf, Fieber, Schwitzen, Gewichtsveränderung, Schwindel und Herzrasen wurden verneint.

Sie habe bislang keine Behandlung für die aktuellen Beschwerden erhalten.

Medikament: Metoprolol 5 mg täglich seit 2 Jahren

Voroperationen: keine

Allergien und Unverträglichkeiten: nicht bekannt

Sozialanamnese: ledig, Mitarbeiterin im Finanzamt

Familienanamnese:

Vater verstarb im Alter von 70 Jahren an einem Myokardinfarkt.

Mutter leidet seit dem 45. Lebensjahr an Brustkrebs und befindet sich aktuell in Chemotherapie. Weitere anamnestiche Angaben waren unauffällig und wurden nicht erwähnt!

Befunde:

Die 63-jährige Patientin befand sich in leicht reduziertem Allgemeinzustand und gutem Ernährungszustand. Sie war wach, orientiert und sprach flüssig.

Vitalzeichen: RR 140/80 mmHg, HF 72/min, AF 16/min, SpO2: nicht gemessen,

Temperatur: nicht gemessen.

Keine Zyanose, Blässe oder Ödeme.

Körperliche Untersuchung:

- Herz: regelmäßiger Rhythmus, keine pathologischen Herztöne, keine zusätzlichen Herzgeräusche

- ● Lunge: beidseits gut belüftet, keine Rasselgeräusche
- ● Abdomen: lebhaftes Darmgeräusche, keine Druckschmerzen, keine Abwehrspannung
- ● Extremitäten: frei beweglich, keine Ödeme, keine neurologischen Auffälligkeiten

Weiteres Vorgehen:

EKG, Notfalllabor, Echokardiographie Verdachtsdiagnose: ACS (Angina pectoris) Differenzialdiagnosen:

Lungenembolie, Pneumothorax, Pleuritis, Herzinsuffizienz

Therapie:

Überwachung der Vitalzeichen, Sauerstoffgabe bei Bedarf, Analgetika bei Bedarf, Einweisung ins Krankenhaus

Epikrise:

Die 63-jährige Patientin Frau X stellte sich mit seit 8 Stunden bestehenden thorakalen Schmerzen links sowie belastungsabhängiger Dyspnoe vor.

Die durchgeführten Untersuchungen (EKG, **klinische Untersuchung**) ergaben den Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom.

Die Patientin wurde in unserer Praxis überwacht und bei stabilem Allgemeinzustand durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung und Behandlung ins Krankenhaus eingewiesen.

Empfehlung: Verlaufskontrolle nach der Entlassung in unserer Praxis.

Psychosomatik

Dr. Wiehn wollte mit mir zuerst beginnen. Über den Arztbrief wurde zunächst nicht gesprochen. Gesprächsverlauf:

- ● Dr. Wiehn: „Haben Sie Psychosomatik im Studium gelernt?“
- ● Ich: „Nein“
- ● Dr. Wiehn: Sie haben das Stethoskop teilweise über den BH gelegt und gesagt, die Herztöne seien normal. Haben Sie die Herztöne korrekt gehört?
- ● Ich: Bei allen anderen Punkten habe ich die Herztöne korrekt gehört.

- ● Dr. Wiehn: Warum haben Sie die Patientin nicht gebeten, ihre BH auszuziehen?
- ● Ich: Ich wollte das nicht. (ich wollte nicht sagen, dass es sich um eine Schauspielpatientin handelt!)
- ● Dr. Wiehn: „Haben Sie das richtig gemacht?“
- ● Ich: Nein, das war mein Fehler. (Eigene Fehler zuzugeben wirkt bei Prüfern positiv.)

Fragen zu Psychosomatik:

- ● Was beachtet man bei einem psychosomatischen Patienten?
- ● Typen und Stadien von **Depression** und deren Behandlung
- ● **SSRI** im Detail, Behandlung bipolarer Störungen, **Lithium** (Wirkung und Nebenwirkungen), **Manie**
- ● **Essstörungen**: Details, Komplikationen, Therapie

Antworten: Alle Fragen habe ich korrekt beantwortet.

Weitere Fragen:

Was verschlimmert Beinödeme bei Patienten mit Essstörungen?

Ich: Beinverletzungen und Neigung zu Selbstverletzungen. (Prüfer erwartete die Antwort „Diuretika“ Ich war leicht überrascht und habe nachgefragt. Diuretika sind rezeptpflichtig. Diese Antwort gefiel Dr. Wiehn, er sagte ja und lachte.)

Dr. Wiehn bemerkte, dass ich bei diesem Beispiel leicht überrascht war. Er sagte, die Patientinnen klauten Tabletten von Oma, Opa und Eltern.

Ich habe gelacht, und alle haben gelächelt.

Chirurgie

Prof. Hanisch: Ein 65-jähriger Patient hat seit einigen Tagen Bauchschmerzen und Blut im Stuhl. Er kommt zu dir in die Notaufnahme. Was machen Sie?

Ich: Kurze Anamnese, Vitalparameter Kontrolle, Bauchuntersuchung und DRU.

Prof. Hanisch: Na ja, DRU – welche Ursachen bei DRU kann man finden?

(Jetzt wollte ich in diesem Bericht länger bleiben und Zeit sparen!)

Ich: Hämorrhoiden, Fissuren, Tumoren, Polypen.

Prof. Hanisch: Warum bluten Polypen?

Ich: Polypen bestehen aus dünnem, empfindlichem Gewebe, das durch harten Stuhl bluten kann.

Prof. Hanisch: Was noch?

Ich: Fisteln, obwohl das nicht häufig vorkommt und nicht typisch ist.

Prof. Hanisch: Können Sie nicht das ablehnen und sagen, gibt es medikamentöse Ursachen?

Ich: Ja, Blutverdünner wie Heparin, Marcumar, DOAK, ASS und NSAIDs.

Prof. Hanisch: Falls ein Tumor vorhanden ist, was machen Sie?

Ich: Biopsie und Staging, TMN – die Bedeutung von TMN und so weiter.

Prof. Hanisch: Wie machen Sie die Biopsie?

Ich: Durch Koloskopie, Rektoskopie und in diesem Fall direkt über das Rektum.

Prof. Hanisch: Jetzt hat der Patient einen T3N2M1-Tumor, was machen Sie?

Ich: Ich verlege den Patienten zur Tumorkonferenz.

Er hat gesagt: Ja, das ist richtig, aber wie wird behandelt?

Ich: Rektosigmoidresektion mit Hartmann-Kolostomie oder primärer Anastomose, je nach Ausmaß des Tumors.

Prof. Hanisch: Was kann man noch vor der OP machen?

Ich: Neoadjuvante Chemotherapie und Chemotherapie.

Prof. Hanisch: Wer ist bei einer Tumorkonferenz dabei?

Ich: Onkologe, Chirurg, Anästhesist, Radiologe, Pflegekraft. (Pathologe habe ich vergessen zu erwähnen).

Dann hatten wir noch 5 Minuten, und er hat über die Definition des **akuten Abdomens**, intraperitoneale und extraperitoneale Ursachen gefragt. Ich habe alles erwähnt. Zwischendurch kamen weitere Fragen:

Ich habe bei intraperitonealen Ursachen auch Ascending-Kolon-Tumoren genannt. Er hat das als intraabdominal bezeichnet, und ich habe zugestimmt (das braucht man hier nicht zu diskutieren.)

Als ich Hodentorsion genannt habe, hat er gesagt, das sei Ihre Fachrichtung, und ich habe alle Fragen beantwortet.

Die Zeit war um, deshalb konnte ich den Prüfer nicht mehr gezielt auf das Thema Inguinalhernie lenken. Chirurgen legen auf dieses Thema besonderen Wert, und wir hätten noch mindestens 5 Minuten darüber diskutieren können.

Innere Medizin

Prof. Schoppet: Welche Blutdruckwerte hat die Patientin? Sind sie normal oder hoch?

Ich: 140/80 mmHg. Das ist kontrolliert, da sie Metoprolol nimmt.

Prof. Schoppet: Ist dieser Blutdruck ohne Medikamente noch hoch oder niedrig?

Ich: Das kann normal sein oder grenzwertig. Die systolischen Werte liegen in Grad 1, die diastolischen Werte sind normal. Man kann von isolierter systolischer Hypertonie laut Stadium sprechen.

Prof. Schoppet: Bei welchen Menschen sind diese Werte hoch?

Ich: Diabetiker. Was noch? Menschen mit Schlaganfällen.

Prof. Schoppet: Menschen ab 70 Jahren – diese Angabe wird in der Literatur erst ab 2023 genannt. Dann hat er gefragt, wie hoch der DD sein muss.

Ich: Unter 140 mmHg.

Prof. Schoppet: Nein!

Ich: Dann unter 130 mmHg.

Prof. Schoppet: Ja.

Prof. Schoppet: Die Frau nimmt Metoprolol für ihren hohen Blutdruck. Ist das die richtige Behandlung?

Ich: Ja, der Blutdruck ist nach dieser Behandlung kontrolliert.

Prof. Schoppet: Sollte man diese Behandlung fortsetzen?

Ich: Nein. Die Reihenfolge ist ACE-Hemmer, ARB, Calciumkanalblocker, Diuretika und B-Blocker, zwei oder drei Kombinationen.

Prof. Schoppet: Richtig, manchmal kann man es auch so machen (er meinte,

alleine B-Blocker geben).

Prof. Schoppet: Was sind die Kontraindikationen von B-Blockern?

Ich: Asthma bronchiale. Er hat nicht mehr gesagt. Ich: Bradykardie, AV-Block.

Er: Welche?

Ich: AV-Block II und III.

Er: Und AV-Block I?

Ich: (nach ein paar Sekunden Pause) Ich werde bei AV-Block I vorsichtig sein.

Dann hat er mir eine Liste mit Blutwerten gegeben, von oben bis unten. Es stand: Anämie – normozytär, normochrom; renale Anämie – Ursache, Behandlung und Komplikationen. Er hat Fragen zu Ursache, Behandlung, Komplikationen, Dialyseindikationen und renaler Überwässerung gestellt. Am Ende gab es ein EKG-Bild einer Kammertachykardie: Was ist das und wie behandelt man das? Außerdem gab es ein Bild mit Pneumoperitoneum. Ich habe alles beantwortet, und er war zufrieden.

Am Ende hat sie mich gebeten, rauszugehen, und nach 15 Sekunden wieder angerufen und gesagt, dass ich die Prüfung bestanden habe. Dr. Wiehn hat gesagt, dass ich keine Psychosomatik studiert habe, aber trotz meiner Sprachbarriere habe ich es gut gemacht.

Prof. Hanisch hat am Ende gefragt, wo ich in meinem Heimatland gearbeitet habe – er meinte, in welcher Stadt. Dann habe ich mich bei der Prüfungskommission bedankt und verabschiedet. Der mündliche Teil unter Stress hat mir richtig Spaß gemacht. Die Diskussion war sehr professionell. Ich habe alle Fragen verstanden und beantwortet. Sprachlich hatte ich zwar Angst, aber ich konnte die Diskussion so zum Ende bringen, dass alle mich verstanden haben, und das war ausreichend. Eine Stunde war schnell um.

Vorbereitung/Empfehlungen: Ich habe keinen KP-Kurs besucht. Nach der FSP im August 2025 habe ich das EKG-Buch von Uwe Ganschow gelesen und gelernt. Außerdem habe ich Fallbücher zu Psychosomatik, Allgemeinmedizin, Innerer Medizin, Chirurgie sowie das Buch Dein Weg zur Approbation von Dr. Charlie gekauft. Die Fallbücher waren langweilig, habe ich gar nicht gelesen. Nur das Buch von Charlie habe ich intensiv durchgearbeitet (dreimal), zusätzlich eine 444-seitige (Vorbereitung zur Kenntnisprüfung) PDF, die den Inhalten zum Charlie Buch entspricht.

Die Prüfungsprotokolle waren sehr hilfreich.

Ich habe ein Jahr auf die Berufserlaubnis gewartet. Nach Erhalt im November 2025 waren die angebotenen Stellen bereits vergeben. Deshalb habe ich mich seit November 2025 intensiv mit meinem FSB-Kollegen vorbereitet – mit Protokollen, prüfungsrelevanten Übungen, Chat GPT, You Tube und Google. Außerdem habe ich an fünf kostenfreien Vorlesungen von Valeria teilgenommen. Den Kurs von Valeria Müller möchte ich empfehlen.

27.03.2026 Marburg		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Grimm	Adill	Appel

Klinischer Fall: Lungenembolie

Der Fall war eine Lungenarterienembolie (LAE): plötzliche Dyspnoe, Tachypnoe. Keine Immobilisation, kein Malignom, keine Reisen. Seit zwei Tagen war das linke Bein geschwollen und gerötet.

Ich habe teilweise einfach versucht, realistisch zu handeln: Ich wollte tatsächlich den Notruf 112 wählen, einen Zugang legen und habe noch der O₂-Flasche und einer Nasenkanüle gesucht – haha. Dann kam der zweite Prüfer und meinte nur, dass ich das alles gar nicht brauche.

Chirurgie

Wir haben mit der Chirurgie begonnen. Es wurden Fragen zur Ätiologie, Diagnostik und Therapie einer **Achillessehnenruptur** sowie zur Behandlung der **TVT** gestellt.

Es wurden Röntgenbilder eines **Pneumothorax** gezeigt. Außerdem wurde nach **FAST** gefragt – ich habe es erklärt und auch eFAST erwähnt. Der Prüfer meinte, dass man im Ultraschall keinen Pneumothorax sieht, wobei in AMBOSS das Barcode-Zeichen und das Seashore-Zeichen beschrieben sind ??

Es gab viele Fragen zur **Reanimation** und zum **Polytrauma**: Vorgehen in verschiedenen Situationen. **Ursachen von Oberbauchschmerzen**

Ein weiterer Fall: Verkehrsunfall – eine Person ist im Auto eingeklemmt, das Auto brennt. Was mache ich als Notarzt?

Es wurde ein CT mit freier Luft im Abdomen gezeigt – Ursachen und weiteres Vorgehen.

Ich sollte mindestens zwei Antiseptika nennen: ich nannte Chlorhexidin, Octenisept und Cutasept. Gewünscht war auch Betaisodona, das kannte ich nicht.

Erysipel: Bild gezeigt, Therapie gefragt. Danach: was tun bei Blasenbildung – Diagnostik und Therapie.

Fragen zu Osteosynthesearten und deren Indikationen, Frakturzeichen. Ich habe sogar selbst die Kadi-Läsion als Beispiel bei den Osteosynthesearten erwähnt. Insgesamt war der Prüfer zufrieden.

Allgemeinmedizin

Es wurde ein Bild von Impetigo contagiosa und Herpes gezeigt – Therapie?

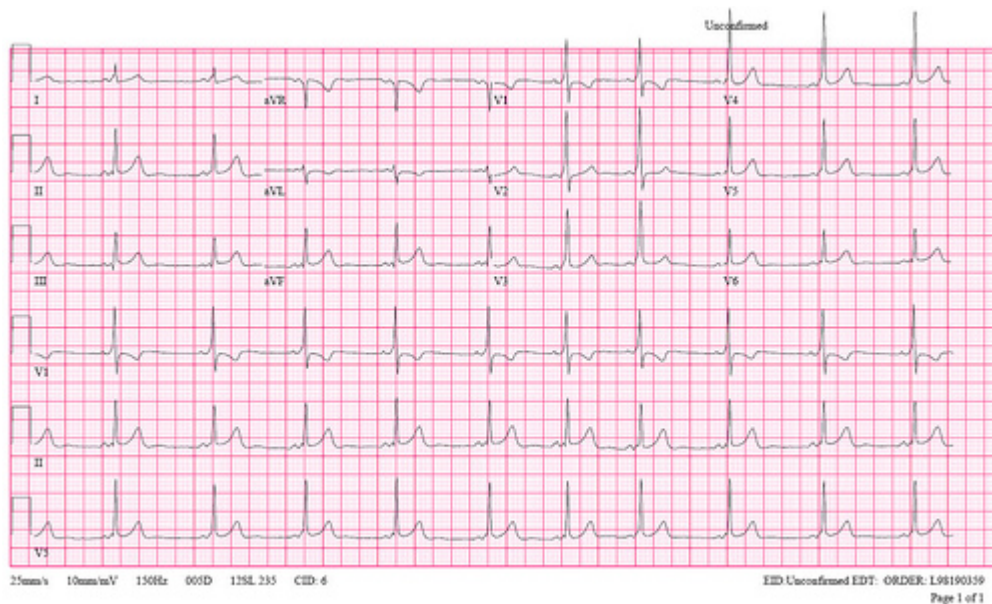
Frage: Was tun, wenn die Patientin Erzieherin im Kindergarten ist? Ich habe alles erklärt, inkl. ggf. Meldung ans Gesundheitsamt. Fragen zu Windpocke. Muss V. a. Windpocken melden sein?

Dann fragte er nach weiteren Hausmitteln – er wollte Honig und Zahnpasta hören. Ich erwähnte Honig bei kleinen Verbrennungen, Zahnpasta wusste ich nicht. Er meinte, sie habe bakterizide Eigenschaften.

Ein weiterer Fall: Patientin mit Flankenschmerzen und Fieber. Vorgehen? Was bei Verschlechterung?

→ Urosepsis, Schocktyp, Therapie.

Noch ein Fall: Patientin mit Herzrasen. EKG und 24h-EKG: **WPW-Syndrom**. Ich sagte: EPU und Ablation. Er ergänzte, dass dies nicht immer zwingend notwendig ist.



Sepsiskriterien: ich erklärte qSOFA und SOFA. Der Prüfer meinte, qSOFA werde nicht mehr verwendet, eher **NEWS2** und **MEWS**.

Ein Video mit Kussmaul-Atmung wurde gezeigt: wann tritt sie auf? Was erwartet man in der BGA? Was passiert mit dem BE?

Innere Medizin

Ich sollte die „**großen Fünf**“ nennen. Ich nannte die Big Six, daraufhin fragte er die anderen Prüfer, ob bei einer Perikardtamponade Schmerzen auftreten.

CT-Bild vom ersten Fall: ich sagte, ich sehe keine LAE, sondern eine Aortendissektion (sehr deutlich sichtbar).

Aus Stress sagte ich „abdominal“ meinte aber „thorakal“. Dann er bietet alle Strukturen benennen: Aorta, Truncus pulmonalis, Sternum usw.

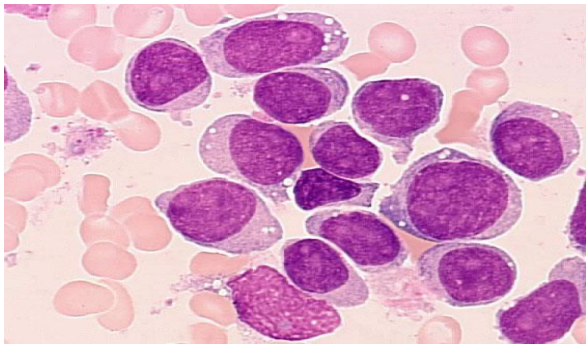
Fragen zur Klassifikation von **Aortenaneurysmen** sowie **Stanford-Klassifikation** und Therapie.

Gallenblase mit Stein, ohne Cholezystitis, asymptomatisch – Therapie?

Bild: zweiter Zeh mit Nekrose → Diagnose, Ursache, Stadium der **pAVK**.

EKG: zunächst **Torsade de pointes**, dann **monomorphe ventrikuläre Tachykardie** → Therapie, Advanced Life Support.

Blutbild mit Blasten → Diagnose, Therapie.



GFR: Berechnung und Einheiten. Ich sagte zuerst ml/min/1,73 m², dann korrigierte ich mich auf ml/min.

Warum wird so viel filtriert, obwohl wir nicht ständig urinieren?
→ Erklärung **Primär-** und **Sekundärharn**.

Sechs Ursachen der **chronischen Niereninsuffizienz**.

Pneumothorax nach Schrittmacherimplantation: Drainagearten.

Fragen zu Elektroden und **Implantation eines Herzschrittmachers** – Zugang über die V. subclavia, Lage der Elektroden.

Insgesamt habe ich alle Fragen beantwortet, außer „Zahnpasta bei Herpes“

Es gab noch viele kleine Fragen, die ich nicht mehr erinnere.

Am Ende wurde ich kurz rausgebeten, nach einer Minute wieder hereingerufen und mir wurde mitgeteilt, dass ich bestanden habe.

Sie fragten, wie ich mich vorbereitet habe, und sagten, dass ich sehr gut geantwortet habe.

Dann fragten sie nach meinen Plänen – ich sagte Innere Medizin oder Neurologie.

Der Vorsitzende bot mir eine Stelle in der Kardiologie an, und auch der Prüfer aus der Allgemeinmedizin sagte, er würde sich freuen, wenn ich bei ihm anfangen würde.

Vorbereitung/Empfehlungen: seit November: AMBOSS (Kurzversion), Dockcheck, Protokollelesen, Simulationen mit Kollegen. GPT hat mir geholfen, schwierige Themen einfach zu erklären und mit Merkhilfen zu lernen.

Ich habe keine Kurse besucht.

01.04.2026 Marburg		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Kaltwasser	Hillmeier	Brenks

Klinischer Fall: Akute Mezenteriale Ischämie

Ich bin in der Praxis. Seit gestern Abend leide sie unter plötzlich aufgetretenen Bauchschmerzen. Es seien diffuse Schmerzen, sie könne diese nicht genau lokalisieren. Sie habe gestern Abend Ibu 400 mg eingenommen, danach seien die Schmerzen besser geworden. Aber heute Morgen um 5:00 Uhr seien die Schmerzen wieder schlimmer geworden. Einmaliges Erbrechen, keine weiteren Symptome.

KU: nur diffuse Schmerzen im gesamten Abdomen. Ich habe zusätzlich die peripheren Pulse kontrolliert, Herz und Lunge auskultiert sowie den Blutdruck gemessen. Kurz neurologische Untersuchung. Alles war unauffällig bis auf die Bauchschmerzen.

Die Prüfer waren nicht im Zimmer, sondern hinter einer Glasscheibe. Sie haben nichts gesagt, deswegen habe ich meine Untersuchungsbefunde komplett dokumentiert.

Labor/Bildgebung: Danach habe ich Blut angefordert. Das war sehr lustig: Die Tür wurde ganz langsam geöffnet, nur ein Kopf kam rein und sagte:

„D-Dimer und Laktat leicht erhöht“ Dann wieder weg.

Dann habe ich ein EKG angefordert. Ich bekam ein EKG mit HF ca. 80/min:

normofrequente absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern

In den letzten 2–3 Minuten hat die Patientin Fragen gestellt, sie war unruhig und ängstlich und wollte über die nächsten Schritte, die Behandlung und die Risiken informiert werden.

VE: aHT, Herzerkrankung (sie sagte nur das; danach habe ich ein EKG angefordert → VHF), DM

Medikamente: 2 verschiedene Insuline, einige Medikamente gegen aHT, Pantoprazol

Medikamente Not: Ich habe nach den Medikamenten gefragt. Sie gab mir eine kleine Liste. Ich dachte, ich kann die Liste für den Arztbrief behalten, deswegen habe ich die Medikamente nicht extra notiert. Am Ende des Anamnesegesprächs hat eine Mitarbeiterin die Medikamentenliste wieder mitgenommen. Ich konnte die Medikamente danach nicht mehr gut im Brief dokumentieren.

→ Deswegen: UNBEDINGT Medikamente selbst notieren!

Medikamente Not 2: Es gab **keine Antikoagulation**. Ich habe nochmals nachgefragt, aber die Patientin sagte, dass sie nur diese Medikamente einnehme.

Chirurgie

Über 20 Minuten haben wir nur über meinen Fall und die mesenteriale Ischämie gesprochen. Er war etwas fordernd, aber nicht unangenehm. Wir haben alles von A bis Z besprochen, teilweise sehr detailliert (Amboss-Level).

A: Prüfer

B: Ich

1. Dialog

A: Was kann man in der Praxis machen?

B: Heparin geben und Sonographie, wenn möglich Duplex.

A: Warum Heparin?

B: Gute Steuerbarkeit und schnelle Wirkung.

A: Worauf schaut man bei mesenterialer Ischämie?

B: Die A. mesenterica superior ist die häufigste Lokalisation.

A: Was sind die Äste der A. mesenterica superior und welche Bereiche versorgt sie?

B: A. ileocolica, A. colica dextra, A. colica media → terminales Ileum, Colon ascendens, Flexura und ein Teil des Colon transversum.

A: Was kann man mit Duplex sehen?

B: Blutfluss und Gefäßverschluss.

A: Kann man das mit Sono gut sehen?

B: Eigentlich ja.

A: Warum nicht immer?

B: ...

A: Was liegt zwischen Ultraschallkopf und A. mesenterica superior?

B: Darm.

A: Und was ist im Darm?

B: Luft!

A: Genau, deshalb sieht man es oft schlecht.

2. Dialog

A: In welchem Stadium kann die Patientin sein?

B: Stadium 3.

A: Was sieht man in Stadium 3?

B: Peritonitiszeichen wie brettharter Bauch, diffuse Schmerzen, Abwehrspannung, Loslassschmerz, klinische Verschlechterung.

A: Haben Sie diese Befunde gesehen?

B: Nein, nur Schmerzen. Aber die Patientin berichtete über eine kurzfristige Besserung der Schmerzen in der Nacht. Das könnte durch Ibuprofen sein, aber auch ein „fauler Frieden“. Deshalb dachte ich an Stadium 3.

A: Aber wir haben keine Peritonitiszeichen → das ist Stadium

3. Dialog

A: Warum haben Sie an diese Verdachtsdiagnose gedacht?

B: Viele Risikofaktoren: Vorhofflimmern, aHT, DM und keine Antikoagulation.

A: Warum ist Vorhofflimmern ein Risiko?

B: Chaotische Vorhoferregung → Thrombenbildung.

A: Wo genau?

B: Im linken Vorhof.

(Hier wollte er: Vorhofohr → Thrombus → Embolie → Mesenterialarterie)

A: pf, nein. (Also Er wollte ich glaube hier bisschen detaliert hören über VHF mekanism, Thromboseinhalt, emboli pathophysiologie. Leider konnte ich diese Teil nicht gut erklären)

Also, zusätzlich haben wir über die Risiko Faktoren, Laktat, CT – Angiographie, Fogarty Katheter, Exploration Laparatomie, Second Look OP, andere Emboli Möglichkeiten (wie Schlaganfall oder so, aber sehr kurz)

Innere Medizin

Über verschiedene Themen haben wir gesprochen. Er war nett, freundlich.

1- A: Ein Fall, 40 Jahre Mann arbeite im Baustelle, habe er unten Rückenschmerzen.

B: Seit wann? Seit 15 LJ. Vermehrt es sich mit Bewegungen oder in Ruhe?

A: In Ruhe schlimmer.

B: Familie anamnese?

A: Vater habe diese Schmerzen auch

B: Es kann eine Rheumatische Krankheit sein, v.a. Morbus Bechterew oder Psoriasis arthrit.

A: Was machen Sie denn, wie können Sie das bestimmen?

B: Im Blut kann ich HLA-B27 sehen.

A: Können Sie damit diagnostizieren?

B: Nein. Ich brauche Röntgen und MRT auch.

A: Nein, im Blut, kann man was gucken und wenn es positiv ist, direkt ja Morbus Bechterew sagen?

B: Ich weiß nicht, können wir zusätzlich CRP, BSG auch anfordern, aber sie sind auch nur Hinweise, nicht 100% diagnostizieren.

A: Ja was noch?

B: Also meinen Sie noch im Blut?

A: Nein weiter

B: Röntgen und MRT. Hier gab er mir einen Röntgen mit Sakroileitis, (leider keine Bamboo Zeichen, Ich hab einen Foto ähnlich gefunden, am Ende gibts)

A: Was sehen Sie hier?

B: (Ich konnte hier nicht was gutes sehen, ich hab nur eine Einschätzung gemacht, aber er war sehr nett, er hat mir einige Tipps gegeben, danach selbst erklärt.) (Ich glaube, Knochenödeme oder Entzündung war richtig)

A: Therapie

B: Physiotherapie (Das wollte er auf jeden Fall hören, darüber bisschen selbst auch erklärt) + NSAR, ggf. TNF-α

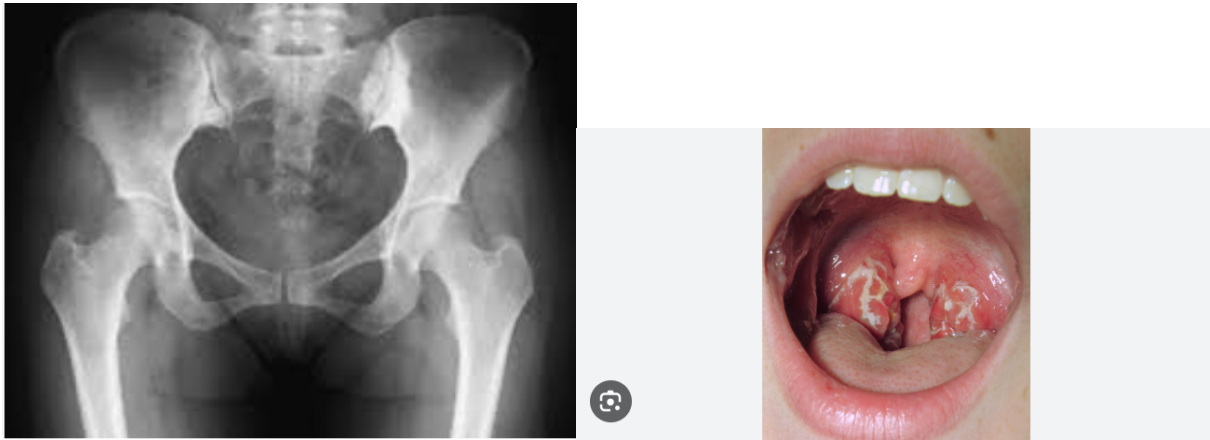
- 2- Über DM einige Frage gestellt, waren nicht schwer. Danach gab mir einen Urin Sticks Ergebnisse. Ich war schockiert für einige sekunde, ich hatte das nur während Studium gesehen, got sei dank es war sehr einfach zu beurteilen.
- 3- Ein Bild mit Tonsillitis, DD wollte er Hören. Streptekok, EBV, diphterie, kandida. Er wollte über EBV und Mononukleose Infektiose mehr sprechen. Die Fragen fällt mir leider nicht ein. Lernen Sie bitte EBV gut.
- 4- Er gab mir ein Ergebnisse von Urinstix, erstmal mit Leukosytose + Blut, danach mit Glukosurie.

Allgemeinmedizin

Wir haben über viele Themen gesprochen aber er war TOP! Toll! Sehr nett sehr freundlich.

- 1- Ein Bild mit rote Augen. Danach habe ich anfangen Fragen zu stellen, die Antworten: Keine Sehverlust, keine schmerzen, nicht ganz Juckreiz auch, zwischen schmerzen und juckreiz. Es gab keine prulan sekretion im Bild. Der Pat. habe das letzte Jahr auch gehabt, er war unter der Sonne, wenn es passiert ist. Ich habe allergisches Konjunktivitis gesagt und Antihistaminik Tropfen oder salbe gesagt. Er hat besser Tropfen gesagt.
- 2- Ein Bild mit einer alten Oma-Kopf mit malign melanom. Er wollte nur die Namen und welche is besser welche schlimmer hören; Malign melanom, spinaliom, basaliom. Zusätzlich wollte er die precursor lesion hören, aber ich konnte nicht antworten, er hat selbst gesagt. Aktinische Keratose.
- 3- Die Gleiche oma wolle unter der Sonne zeit verbringen, was können Sie empfehlen? Ich hab gesagt Sonnenhut, aber er hat gesagt, das schutz eher wenig, dann hab ich gesagt sonnenschutzcreme. Er hat darüber einige Frage gestellt, wie Lichtschutzfaktor (LSF). Warum 50 sei besser als 30, was beudetet diese Zahlen usw. Eigentlich ich konnte gar nix antworten, einfach 50 ist starker als 30 gesagt. Er hat selbs erklärt. Ich hab Oma empfohlen, dass sie nicht mittags rausgehen solle.
- 4- Was bedeutet Allgemeinmedizin?? Ich konnte nicht so viele gute definition Sätze machen, deswegen habe ich nachdem kurz definition angefangen direk die Aufgaben von Allgemeinarzt zu erklären. Gott sei dank hat er mich nicht gestoppt, habe ich viel Zeit gewonnen.

5- Alte Menschen Impfungen; v.a. Respiratorisches Synzytial-Virus wollte er hören



Vorbereitung/Empfehlungen: Die Prüfung ist nicht einfach. Man kann während der Prüfung mehrmals aufgeregt werden. Am wichtigsten ist es, sich mental unter Kontrolle zu haben. Ich konnte nicht alle Fragen beantworten, musste aber nicht, da ich bestanden habe. Bleiben Sie bitte gelassen und sprechen Sie mit einem hohen Selbstwertgefühl. Ich habe bisher Amboss, Doccheck, ChatGPT und Protokolle sehr häufig verwendet. Ich finde Amboss und ChatGPT sehr gut, aber am wichtigsten sind immer die Protokolle! Lesen Sie bitte alles und geben Sie sich Zeit für die Protokolle. Außerdem habe ich einen Notfallkurs bei Valeria gemacht, der auch sehr gut war. Insgesamt habe ich ungefähr 2,5 Monate gelernt, im letzten Monat intensiv. Ich brauchte noch eine Woche, um alles zu wiederholen. Nun ja, jetzt ist es sowieso vorbei. Ich wünsche allen viel Erfolg.

01.04.2026 Marburg Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Kaltwasser	Hillmeier	Brenks

Klinischer Fall: Akute Mezenteriale Ischämie

Patientin mit Diabetes Typ I, Vorhofflimmern (VHF), AH

Leitsymptom: akute Bauchschmerzen seit gestern

Kein Durchfall, kein Fieber

Befunde: erhöht Laktat und D-Dimer

EKG habe ich vergessen zu bestellen

Allgemeinmedizin

- Kompressionsstrümpfe: Klassen, Indikationen
- Varizen: Entstehung (Pathophysiologie)
- Was pumpt das Blut durch die Venen? → Muskelpumpe / Venenklappen
- Erysipel: Therapie
- Keilwirbel Körper (Wirbelsäule): Ursachen → in diesem Fall Multiples Myelom

Chirurgie

- Keilwirbel: Diagnostik, DEXA, Therapie → konservativ vs. operativ

Soll die Patientin lange im Bett liegen? ohne OP → Nein (frühe Mobilisation)
Schmerzbekämpfung

Weitere Themen;

- Erythema anulare (Borreliose)

Stadein, therapie nach Stadin

- FSME: Therapie und Komplikationen

Vorbereitung/Empfehlungen: Meine Vorbereitung war langsam über 1 Jahr.

Ich habe Online-Kurs von Valleria Müller besucht. Am Anfang hat es nur selten geklappt, aber im zweiten Halbjahr habe ich alles fleißig und regelmäßig durchgearbeitet.

Ich habe mich nur am Wochenende vorbereitet, weil ich in Vollzeit gearbeitet habe, und war einmal bei einer praktischen Unterricht: Tag im Praxis.

Die letzten drei Wochen habe ich intensiv gelernt und dafür Urlaub genommen.

Das von Valeriia bereitgestellte Material war für mich vollkommen ausreichend.

01.04.2026 Marburg Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Printz	Heuschen	Simons

Klinischer Fall: Diverticulitis

70-jähriger P. mit 2 Tagen bestehenden Unterbauchschmerzen (5 auf 10 NSS) li ohne Ausstrahlung. Nicht zum ersten Mal. Kamillentee lindert die Beschwerden. Keine Übelkeit, keine Erbrechen. Keine makroskopische Blutung im Stuhl (weich und braun). Keine Beschwerden beim Wasserlassen. Keine Nierenstein in der Vorgeschichte.

Kein Fieber. Keine Gewichtverlust. Appetit in den letzten Tagen etwas schlechter.

aHT bekannt.

Medikament Ramipril (5-0-0-0mg).

Keine OP. Keine Allergien. Nichtraucher, Alkohol in Gesellschaft.

Die Eltern sind an Herzkrankheiten gestorben. Keine Geschwister. Er wohnt allein. Die Frau ist vor 5 J gestorben. (mein Beileid)

KU: Inspektion unauffällig. Auskultation: vermehrte Borborygmi. Palpation: Abwehrspannung im Unterbauch li. (Nach Palpation NSAIR- Angebot)

DRU: unauffällig

Bildgebung: Sono: Sehr deutlich Divertikulitis

DD: Colitis ulcerosa, Nierenstein, Morbus Crohn, KRK, Appendizitis, Leistenhernie.

Therapie: Cefuroxim + Metronidazol + Metamizol

Überweisung für weitere Abklärung mit Koloskopie nach Akutenphase.

Wiedervorstellung in einer Woche.

Chirurgie

Pneumothorax Mechanismus, Symptomen, Pathophysiologie von Symptomen, Therapie.

Akutes Abdomen Definition, Ursachen nach Lokalisierung,

Cholestase Pathophysiologie, Diagnose, Laborbefunde, Bildgebende Diagnostik und denen Befunden. DD.

Was ist **Adnexitis**, **Ovarialzystenruptur**, **Extrauterin gravidität** und Definition und Wo sind die Einnistungsorten? Wann treten die Symptomen und Schmerzen i.d.R. bei Extrauterin gravidität auf?

Eine **petrochantäre Femurfraktur**, was sind die mögliche 3 OP- Verfahren?

Innere Medizin

Myokardinfarkt STEMI: Diagnostik, Therapie, Was ist dann **Drug eluting Stents**? Welche Medikamente werden dann in DES verwendet? (Everolimus, Zotarolimus etc.) Welche 4 Medikamentöse Therapie als Nachsorge? (1. Thrombozytenaggregationshemmer: Duale Plättchenhemmung, anschließend i.d.R. dauerhafte Monotherapie, ACE Hemmer, Betablocker und Statine.)

Was ist das Wirkungsmechanismus von **Statin** und **ACE Hemmer**? Welche Enzyme hemmt das Statine dann? Welche Nebenwirkungen haben die ACE Hemmer, B-Blocker und Statine?

Leberversagen: Ursachen (akut und chronisch).

Allgemeinmedizin

Fragen über den Fall. *Sie haben in Ihrem Fall bei der Untersuchung den Patienten gesagt, dass er Stippchen auf den Tonsillen gehabt hat. Warum haben Sie so gesagt? Woran haben Sie gedacht? Welche DD ist relevant mit Divertikulitis und diesem Befund?* / Ich habe gesagt, das war nicht meine Phantasie, dieser Herr hat wirklich Stippchen auf den Tonsillen gehabt, wollte ihn einfach Bescheid geben. (Ach soo dann weiter)

Blick Diagnose EKG mit Hinterwand Inferior STEMI (das EKG war so deutlich, könnte man wirklich von 50 M die Diagnose stellen) Welche Arteria ist hier zu? Und mit posterior? Und Anterior?

Bild vom Riesenzellerarteriitis: Diagnostik, Therapie, Überweisung. und Therapie wie lange? Wann und mit welcher Dosis müssen wir Prednisolon ausschleichen?

Ein Bild mit Abducensparase. Wie heißt das? Welche Seite und welcher Muskel? Welche weitere Hirnnerven sind für die Augenbewegungen zuständig?

Ein Bild vom Fibrinbeläge post OP 5. Tag: Was ist das? Gefährlich?

Wann lösen sie sich selbst ab? Was ist das Risiko Komplikation beim Ablösen?

Vorbereitung/Empfehlungen: Ich habe zwei Monate lang gelernt, einen Monat neben einer Teilzeitstelle und im letzten Monat (Urlaub gehabt) intensiv, täglich etwa 6-8 Stunden. Einige der Fragen wurden bereits im Workshop von Mohammed besprochen, weshalb ich das Gefühl hatte zu wissen, worauf die Prüfer hinauswollten.

Die offenen Vorlesungen von Valeria sind sehr interessant und hilfreich. Zwar habe ich ihre regulären Vorlesungen nicht besucht, aber selbst aus den offenen Vorlesungen habe ich sehr viel gelernt. Wenn ich die Prüfung nicht bestanden hätte, würde ich sie auf jeden Fall kaufen.

01.06.2026 Bad Neuheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Voss	Volkman	?

Klinischer Fall: Vorhofflimmern

Ein 69-jähriger Patient (80 kg) stellte sich aufgrund von seit gestern bestehendem Herzrasen und erhöhter Herzfrequenz vor. Laut Patient wurde mit seiner Armbanduhr ein Puls von etwa 120/min gemessen. Ähnliche Beschwerden habe er bereits früher gehabt.

In der Anamnese berichtete der Patient über einen Schlaganfall vor etwa 10 Jahren. Nach eigenen Angaben habe er anschließend keine ASS eingenommen. Weitere Beschwerden bestanden nicht.

Die vegetative Anamnese war unauffällig.

Medikamente

- * Bisoprolol 5 mg 1-0-0
- * Hydrochlorothiazid (HCT) 12,5 mg 1-0-0

Vorerkrankungen

- * Arterielle Hypertonie
- * Zustand nach Schlaganfall vor 10 Jahren

Operationen

- * Zustand nach operativ versorgter Klavikulafraktur

KU: Nach der Anamnese habe ich den Blutdruck gemessen, die Herzklappen auskultiert sowie die Karotiden, die A. subclavia und die A. brachialis untersucht. Außerdem habe ich auf ein Pulsdefizit geachtet. Während der Untersuchung habe ich alle Schritte laut erläutert, einschließlich der anatomischen Lokalisationen der Herzklappen.

Labor/Bildgebung: Anschließend erhielt ich ein EKG, das Vorhofflimmern mit Tachyarrhythmia absoluta zeigte.

Herr Voss fragte mich daraufhin, wie ich in der Notaufnahme weiter vorgehen würde. Da solche Patienten in der hausärztlichen Praxis in der Regel zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus überwiesen werden, erläuterte ich zunächst die Beurteilung der Herzfrequenz, des Herzrhythmus sowie die Berechnung des CHA₂DS₂-VASc-Scores.

Auf Nachfrage berechnete ich zunächst einen CHA₂DS₂-VASc-Score von 4 Punkten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Patient jedoch den zurückliegenden Schlaganfall noch nicht erwähnt. Nach Berücksichtigung der Schlaganfallanamnese ergab sich ein höheres thromboembolisches Risiko.

Ich schlug eine Frequenzkontrolle mittels Metoprolol 5 mg i.v. vor. Daraufhin erhielt ich ein weiteres EKG, das die Konversion in einen Sinusrhythmus zeigte. Anschließend fragte mich Herr Voss, wie ich weiter vorgehen würde. Ich antwortete, dass aufgrund des Vorhofflimmerns und des erhöhten Schlaganfallrisikos eine orale Antikoagulation eingeleitet werden sollte. Ich nannte Apixaban (Eliquis) mit einer Initialdosis von 10 mg zweimal täglich für eine Woche, anschließend 5 mg zweimal täglich. Zudem sollte der Patient seine bestehende Therapie mit Bisoprolol 5 mg täglich fortführen und sich zeitnah bei einem Kardiologen zur weiteren Abklärung und Verlaufskontrolle vorstellen.

CHA₂DS₂-VASc-Scores. 4 Punkt.

Alter 65–74 Jahre → 1 Punkt

* Arterielle Hypertonie → 1 Punkt

* Schlaganfall/TIA in der Vorgeschichte → 2 Punkte

Innere Medizin

In der Prüfung bei Herrn Voss begann das Gespräch mit dem Thema Vorhofflimmern. Er legte großen Wert auf die relevanten Schlüsselwörter. Ich erklärte das Thema ausführlich, ähnlich wie Valeria es beschrieben hatte. Außerdem erwähnte ich, dass im EKG neben dem Vorhofflimmern auch ventrikuläre Extrasystolen sowie eine ST-Strecken-Hebung in zwei Ableitungen vorlagen. Daraufhin sprachen wir über den Herzinfarkt. Herr Voss fragte nach

den Risikofaktoren. Ich nannte die üblichen Risikofaktoren wie arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Rauchen, Dyslipidämie und Adipositas. Allerdings wollte er zusätzlich die familiäre Prädisposition als wichtigen Risikofaktor hören. Darauf musste er mich selbst hinweisen, da mir dieser Punkt in dem Moment nicht eingefallen war.

Anschließend stellte er Fragen zur Herzinsuffizienz. Dabei fragte er nach den Symptomen, der Klassifikation, der Therapie sowie den eingesetzten Medikamenten und deren Nebenwirkungen. Diese Fragen konnte ich vollständig beantworten.

Danach zeigte er mir ein EKG mit einem AV-Block III. Grades. Ich erläuterte die Diagnose sowie die erforderlichen Therapiemaßnahmen. Mit meiner Antwort war er sehr zufrieden. DDD Schrittmacher usw.

Zum Schluss fragte er mich nach Diabetes mellitus. Ich erklärte die Erkrankung einschließlich Diagnostik, Therapie und medikamentöser Behandlung. Auch hier konnte ich die Fragen zügig beantworten, und Herr Voss zeigte sich mit meinen Antworten sehr zufrieden.

Allgemeinmedizin

Den Namen der Prüferin habe ich leider vergessen. In den bisherigen Protokollen habe ich ihren Namen nicht gesehen, daher war sie wahrscheinlich neu.

Sie stellte insgesamt drei Fälle vor und legte großen Wert darauf, dass man strukturiert und schrittweise vorgeht.

1. Fall

Eine 46-jährige Frau stellte sich mit seit einigen Tagen bestehender Schwellung des Unterschenkels vor. Dazu erhielt ich ein Bild. Der Unterschenkel war geschwollen und blass, zudem waren Kollateralvenen sichtbar. Außerdem zeigten sich drei bis vier kleine Rötungen.

Als Differenzialdiagnosen nannte ich eine tiefe Venenthrombose (TVT), eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) beziehungsweise einen akuten arteriellen Gefäßverschluss, eine chronisch-venöse Insuffizienz (CVI) mit Varikosis, ein Erysipel sowie eine Phlegmone. Die nekrotisierende Faszitis kam mir ebenfalls in den Sinn, erschien mir jedoch aufgrund des Befundes eher unwahrscheinlich.

Zu den genannten Differenzialdiagnosen erläuterte ich jeweils Diagnostik und Therapie. Allerdings war mir zunächst nicht klar, worauf die Prüferin hinauswollte.

Anschließend ergänzte sie, dass die Erkrankung typischerweise in der Kindheit auftritt und im Erwachsenenalter reaktiviert werden kann. Daraufhin vermutete ich Herpes zoster, wobei ich betonte, dass das Bild für einen Herpes zoster sehr atypisch sei. Dennoch war sie mit meiner Antwort zufrieden. Ich erläuterte anschließend ausführlich die Therapie, mögliche Komplikationen sowie Präventionsmaßnahmen, noch bevor sie gezielt danach fragte.

2. Fall

Eine 40-jährige Frau stellte sich mit rezidivierenden Harnwegsinfekten vor. Bei der Medikamentenanamnese ergab sich, dass sie Empagliflozin einnahm. Ich erklärte, dass Harnwegsinfektionen eine bekannte Nebenwirkung von SGLT2-Inhibitoren sind und dass das Medikament gegebenenfalls abgesetzt beziehungsweise überprüft werden sollte.

Anschließend stellte die Prüferin Fragen zur Pyelonephritis, deren Therapie sowie zur Urosepsis. Auch hierzu erläuterte ich Diagnostik und Therapie.

Danach fragte sie nach den Unterschieden zwischen komplizierten und unkomplizierten Harnwegsinfektionen. Ich erklärte die Definitionen sowie die jeweiligen Therapieansätze ausführlich, noch bevor sie gezielt danach fragte. Anschließend fragte sie mich, wie Fosfomycin eingenommen wird. Hier war ich unsicher und konnte die Frage nicht korrekt beantworten. Sie erklärte daraufhin selbst die richtige Einnahme.

Danach stellte sie Fragen zu Cotrimoxazol, insbesondere zum Wirkmechanismus, zu Nebenwirkungen und zu wichtigen Vorsichtsmaßnahmen. Diese Fragen konnte ich nicht vollständig beantworten. Ich erwähnte lediglich den Einsatz bei bestimmten immunsupprimierten Patienten sowie die Problematik möglicher Resistenzen. Sie akzeptierte die Antwort, hatte aber vermutlich etwas mehr erwartet.

Zum Schluss fragte sie nach den empfohlenen Impfungen für Bewohner von Pflegeheimen sowie für Kinder. Diese Fragen konnte ich zügig und umfassend beantworten, sodass sie zufrieden war.

Da noch etwa zwei Minuten Prüfungszeit übrig waren, sagte sie schließlich, dass sie keine weiteren Fragen habe, und beendete die Prüfung.

Chirurgie

Prüfer war Herr Volkmann. Zunächst zeigte er mir auf seinem Laptop ein Bild und stellte folgenden Fall vor: Eine ältere Patientin mit Demenz war gestürzt und wurde in die Notaufnahme gebracht. Er fragte nach dem weiteren Vorgehen. Ich erläuterte strukturiert die Anamnese, die Vitalparameter, sichere und unsichere Frakturzeichen sowie die pDMS-Kontrolle. Anschließend sprach

ich mögliche Frakturen, insbesondere eine Schenkelhalsfraktur, sowie die entsprechende Diagnostik und Therapie an. Auch nach möglichen Komplikationen wurde gefragt, die ich vollständig nennen konnte. Damit war er sehr zufrieden.

2. Fall

Danach zeigte er mir ein Video von einem Fußballspiel mit Verdacht auf eine Unterschenkel- oder OSG-Fraktur. Ich erwähnte die klinische Untersuchung sowie die notwendige Röntgendiagnostik. Im weiteren Verlauf stellte sich eine proximale Femurfraktur heraus. Ich begann sofort mit der Darstellung von Diagnostik und Therapie, woraufhin Herr Volkmann schmunzelnd meinte, dass wir etwas langsamer vorgehen sollten. Anschließend sprach ich das Kompartmentsyndrom an, erklärte die Logensymptomatik sowie die Pathophysiologie ausführlich. Damit war er ebenfalls sehr zufrieden.

3. Fall

Zum Schluss zeigte er mir erneut ein Bild. Es handelte sich um ein 14-jähriges Mädchen mit rechtsseitigen Unterbauchschmerzen. Ich vermutete eine Appendizitis, erläuterte die typischen klinischen Zeichen, die Laboruntersuchungen sowie die Sonographie. Anschließend zeigte er mir ein Ultraschallbild mit dem Kokardenphänomen, das ich korrekt erklärte.

Danach fragte er nach der operativen Therapie. Ich erklärte, dass die laparoskopische Appendektomie der Standard ist, und beschrieb ausführlich die Drei-Trokar-Technik. Auch damit war er sehr zufrieden.

Zusätzlich fragte er nach dem Vorgehen bei Patienten unter Marcumar vor einer Operation. Ich erklärte, dass bei elektiven Eingriffen eine rechtzeitige Umstellung beziehungsweise ein Bridging erfolgen sollte und dass bei Notfällen Vitamin K sowie Prothrombinkomplexkonzentrat gegeben werden können. Außerdem erwähnte ich, dass der INR-Wert vor einer Operation möglichst auf etwa 1,5 eingestellt werden sollte. Auch diese Antwort gefiel ihm. Da am Ende noch etwa fünf Minuten Zeit übrig waren, wollte er keine weiteren Fragen mehr stellen.

Vorbereitung/Empfehlungen: Die Vorbereitung dauerte etwa fünf Monate. Ich habe nur den Kurs mit Valeriia und die Protokolle genutzt. Ich glaube, mehr braucht man nicht. Vielen Dank, Valeria!

02.06.2026 Bad Neuheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Psychosomatik
Siele	Volkmann	Wiehn

Klinischer Fall: Depression

55-jährige Frau mit Leistungsminderung, Niedergeschlagenheit und depressiver Verstimmung seit 2 Monaten. Von den Zusatzsymptomen bestand nur Appetitverlust. Keine Suizidgedanken. Letzte internistische Abklärung o. p. B. Keine identifizierbaren Auslöser bei der Arbeit oder in der Familie (keine familiären Probleme).

Familiäre Vorgeschichte: nicht gefragt.

Noxen: nicht gefragt.

Vegetative Anamnese: o. p. B.

Vorerkrankung: arterielle Hypertonie.

Medikation: Nebivolol 5 mg ½-0-0.

Sozialanamnese: wohnt mit der Familie zusammen.

KU: Ich habe nur Lunge, Abdomen und Pulse untersucht. Die Patientin war körperlich beschwerdefrei.

Differentialdiagnosen:

- * Hypothyreose
- * chronische Nierenerkrankung
- * Vitamin-D-Mangel
- * Anämie

Weiteres Vorgehen:

- * Blutbild und klinische Chemie (Kreatinin, Vitamin D, TSH)
- * Psychoedukation und kognitive Verhaltenstherapie
- * ggf. Antidepressiva
- * Überprüfung der Indikation von Nebivolol (Depression kann als Nebenwirkung auftreten)

Es war insgesamt eher kurz, vielleicht 15 Minuten, aber ich habe bewusst langsam gesprochen.

Innere Medizin

Patient mit Gewichtsverlust und Schwäche in den letzten Monaten. Frage: Wie gehen Sie diagnostisch vor?

Ich sagte:

- * nach B-Symptomatik fragen
- * Karzinomdiagnostik einleiten

Dann fragte sie nach häufigen Tumoren. Ich sagte:

- * Darmkarzinom
- * Lungenkarzinom
- * Prostatakarzinom
- * Mammakarzinom

Welche Laboruntersuchungen?

→ Blutbild und Entzündungsparameter.

Welche Parameter schließen eher eine Infektion aus?

→ Procalcitonin.

Welche Bildgebung?

Ich sagte je nach Symptomatik zunächst Röntgen-Thorax. Sie meinte aber:

→ „Nein, ein Stamm-CT ist besser“

CT ergab keinen Tumor. Wie weiter?

→ Koloskopie.

Welche anderen Tumorerkrankungen?

→ Leukämien und Lymphome.

Welche Leukämien kennen Sie?

Ich sagte: * AML * CLL * CML

Dann fragte sie:

„Welche noch?“

Ich sagte:

→ Multiples Myelom?

Wie kann man Leukämien vermuten?

→ Leukozytose.

Dann meinte sie:

„Bei dieser Patientin wäre eine CLL eher unwahrscheinlich. Warum?“

Ich antwortete:

→ Weil die CLL häufig asymptomatisch verläuft.

Therapie der CLL?

→ „Watch and wait“ meistens.

Weitere Diagnostik beim multiplen Myelom?

Ich sagte:

→ Knochenmarkbiopsie.

Sie meinte:

→ „Nein, davor“

Dann sagte ich:

→ Elektrophorese.

Was erwartet man?

→ Erhöhte Gamma-Globuline mit M-Gradient.

Was macht man noch diagnostisch?

→ Immuntypisierung/Biopsie.

Dann fragte sie:

„Wie können Sie feststellen, wie weit die Erkrankung verbreitet ist?“

Ich sagte:

→ PET-CT.

Sie wollte eher:

→ Ganzkörperskelettszintigraphie.

Was passiert mit dem Knochen?

→ Pathologische Frakturen.

Deswegen sollte man Röntgenaufnahmen von Brustkorb, Wirbelsäule und Schädel anfordern (den Schrotschussschädel hat sie leider nicht gefragt).

Dann:

Oberbauchschmerzen – Ursachen?

Ich sagte:

- * Cholezystitis
- * Cholelithiasis
- * Pankreatitis
- * Ulkus

Was noch?

→ Myokardinfarkt.

Danach kurz Behandlung der einzelnen Erkrankungen außer MI und das war's.

Psychosomatik

ICD-Kriterien der unipolaren Depression.

Therapie nach Schweregrad:

- * Psychoedukation
- * kognitive Verhaltenstherapie
- * Antidepressiva ab mittelschwerer Depression

Ich sagte zusätzlich, dass wegen der langen Wartezeiten auf Psychotherapie (6–8 Wochen) manchmal frühzeitig medikamentös behandelt werden sollte, um keine Zeit zu verlieren.

Nebenwirkungen von Antidepressiva?

Ich nannte:

- * Tremor
- * Schlafstörungen
- * sexuelle Dysfunktion
- * erhöhte Suizidalität in den ersten Wochen

Dann fragte er:

„Was noch?“ Er wollte QTc-Verlängerung hören (das habe ich vergessen).

Danach allgemeine Begriffe zu Angststörungen:

- * Was ist eine generalisierte Angststörung?
- * Was ist eine Panikattacke?
- * Wovon haben die Patienten Angst?
- * Was ist Hypochondrie?
- * Unterschied zwischen generalisierter Angststörung und Hypochondrie?
(Angst vor allgemeinen Ereignissen vs. Angst, selbst krank zu sein.)

Dann:

- * Anorexia nervosa: wichtige Merkmale
- * Warum lebensgefährlich?
- * Bulimia nervosa: wichtige Merkmale

Und das war's.

Chirurgie

85-jährige Patientin mit Demenz, aber noch funktionell. Sie wurde im Altenheim auf dem Boden liegend gefunden. Wunden am linken Ober- und Unterschenkel. Verdachtsdiagnose?

→ Fraktur.

Dann zeigte er ein Bild: → pertrochantäre Fraktur des linken Femurs.
Operative oder konservative Therapie?

Ich sagte zunächst konservativ. Dann erklärte er sehr gut, warum operativ besser ist, und ehrlich gesagt hat er mich komplett überzeugt.

Er wollte vor allem wissen, was konservative Therapie in diesem Alter wirklich bedeutet: → 6 Wochen Immobilisation im Bett.
Und das funktioniert im Altenheim praktisch nicht.

Komplikationen der konservativen Therapie?

- * Thrombose
- * Dekubitus
- * Harnwegsinfekt
- * Pneumonie

Danach: Fraktur nach Fußballspiel. Diagnose?
→ V. a. Tibiafraktur und evtl. Fibulafraktur.

Röntgen in 2 Ebenen zeigte eine proximale Tibia- und Fibulafraktur (er erwähnte einen speziellen Namen, den ich leider nicht wusste).

Dann zeigte er ein Bild eines stark geschwollenen Unterschenkels nach der Fraktur und fragte: → „Was müssen Sie ausschließen?“

Antwort: → Kompartmentsyndrom.

Danach sagte er: → „Das war's.“

Deswegen gab es relativ wenige chirurgische Fragen; er hat das Gespräch früher beendet. Danach mussten wir kurz vor der Tür warten.

Kurz darauf sagten sie: „Sie haben bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Das war ein sehr kollegiales Gespräch.“

Vorbereitung/Empfehlungen:

- * Anfangs viel Amboss gelernt (ca. 50–59 %)

- * ca. 50 Fälle Allgemeinchirurgie bearbeitet

Dann begann ich aber parallel in der Inneren Medizin zu arbeiten, deshalb wurde es irgendwann zu viel.

Von Januar bis Mai: * Simulationen mit Freunden

Mitte April bis Mai: * Fälle von MEX

Die Protokolle habe ich mindestens 3-mal wiederholt, besonders im letzten Monat.

Zusätzlich: * Fragen mit Amboss IA oder ChatGPT geübt

- * eigene Notizen wiederholt

02.06.2026 Bad Neuheim		
Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Allgemeinmedizin
Bargon	Gille	Simons

Klinischer Fall: Akut Divertikulitis

Wie im Protokollen: 65j. Mann mit l. Unterbauch Schmerzen seit Gestern, Fieber 37,9°C, . Früher solche .Beschwerden vor 2:Jahren gehabt.

VE: BPH

Medikamenten: Duodart

Kein andere Auffälligkeiten.

Bitte schließen Colom Ca, CED, HWI und Leistenhernie durch Anamnese und körperliche Untersuchung aus.

Für Brief schreiben 30 Minuten mehr als genug. Ein Blatt mit 2 Seiten mit Überschriften' Anamnese, Befunde, Diagnose und' Weitere Prozedere' wurde uns gegeben.

Nach Briefschreiben, habe ich ungefähr 2 Stunden auf mündlicher Teil gewartet

Chirurgie

1. Zweizeitige Sigma Resektion und Hartmann OP Indikationen

Die Methode erzählen

Nach zweizeitiger minimal invasiv Sigma Resektion, wie schonen Sie die Anastomose? Worauf muss man beachten?

Antwort: Anastomose Dichtigkeit, gute Blutversorgung von beiden Enden und Vermeidung von Spannung in die Anastomose

2. Nach Sigma Resektion, kann es als Komplikation gefährliche Blutung auftreten, was könnte die Ursachen sein?

Antwort: Mesokolische Arterien Verletzung und Milz Verletzung und Ureter Verletzung

Prüfer: sehr gut aber Ureter liegt unten und ist nicht betroffen

3. Was ist Weber C Fraktur und Behandlung?

Antwort: Immer operativ, Syndesmose mit Stellschraube und Fibula mit kleinen Schrauben

4. Distale Radius Fraktur: Wie behandelt man das?

Antwort: Konservativ. Wie reponieren wir das?

Antwort: Zug in die Achse + Mädchen Fänger)

5. Welche Strukturen sind bei Maisonneuve Fraktur geschädigt?

Antwort: Proximale Fibula, Syndesmose und Membrana Interossea

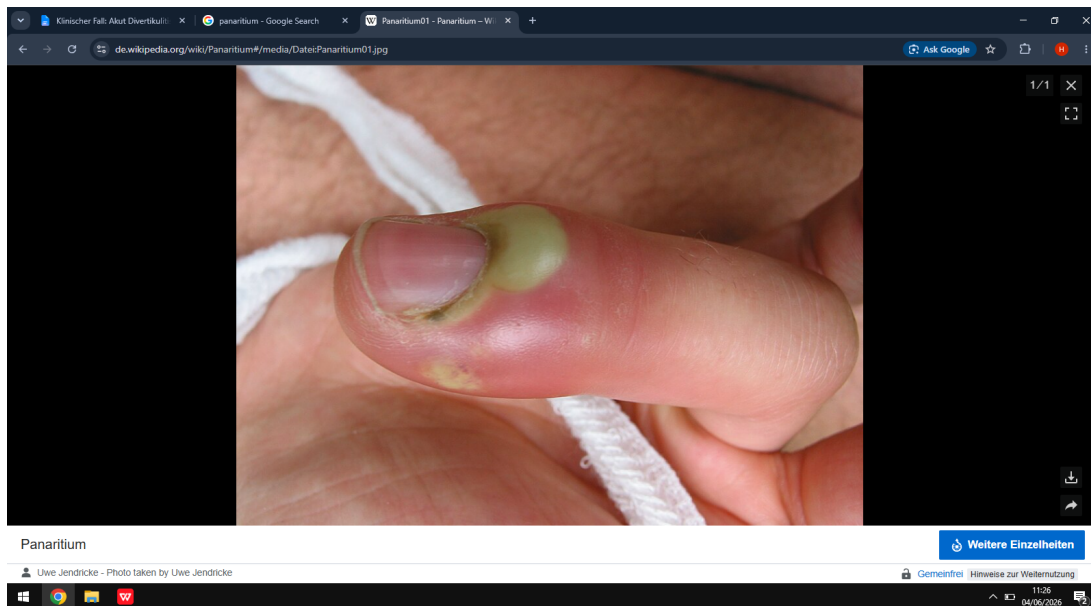
Der Prüfer sagte: malleolus Medialis auch

6. Grundlagen zur Fraktur Behandlung

Reposition, fixation, Ruhigstellung

7. Ein Bild von Zeigefinger gezeigt mit Rötung und Eiter um Nagel herum. Wie behandelt man das

Antwort: Drainage von Abszess



Dann ein Bild gezeigt von gleichen Finger nach drainage und gefragt, welche Anästhesie sollte man in diesem Fall durchführen.

Ich: lokale Anästhesie zur Nervenblock in diesem Bereich.

Dann hatte er seine Zeigefinger vor mir gelegt und sagte wo genau würden Sie spritzen? Ich war mir nicht sicher aber habe sowieso gezeigt dass am dorsalen Seite von Finger Grundgelenk. Er sagte ja auf dorsale Seite und auf beiden Seiten von Grundgelenk und er hatte auch den Name von dieser Methode genannt aber habe nicht verstanden.

8. Ein Bild gezeigt von Ikterus. Definition von Ikterus und Weiteres Vorgehen. Prähepatisch, intrahepatische und Posthepatische Ursachen Abklärung und relevanten Laborwerte. Alles normal außer gGT und AP leicht erhöht und der Patient hat nur Ikterus, keine Schmerzen usw. (Schmerzloses Ikterus). Diagnose?

Antwort: Entweder cholangiokarzinom oder Pankreaskopfkarzinom. Die Diagnose war Pankreaskopf Ca.

Bei OP von Pankreaskopfkarzinom, welche Teile sollten reseziert werden

Antwort: 2/3 Pankreas Teil Teil von Duodenum + Teil von Ductus Choledocus bis Gallenblase, aber Gallenblase bleibt. Ich musste das auf ein Tafel malen

Allgemeinmedizin

Bilder gezeigt: 1. Dupuytren Kontraktur: Welcher struktur ist betroffen

Antwort:Palmar aponeurose

Was ist die Behandlung?

Ich: Nadelfasziotomie

Er sagte nein, wir schicken den Patient zum Chirurg. Wir sind Allgemeinpraxis

2. Zweites Bild von Narbenhernie post cholezystektomie. Gibt es Gefahr von Inkarzeration?

Antwort:Nein

3. Ein langer Geschicht von Alkoholiker erzählt und am Ende gesagt dass er am Arm geschlafen hat und jetzt ist die Hand so geworden und mit seiner Hand 'Fallhand' gezeigt und fragte was ist passiert?

Antwort:N. Radialis Läsion/ parese

Wie behandelt man das?

Antwort: Braucht keine Behandlung außer Schiene, wird besser in ein Paar Tagen

Welche andere Nerven können im Handbereich betroffen sein?

Nervus ulnaris und Medianus

Dann über Schwurhand gefragt

4. Medikamente: Ramipril, HCT, Febuxostat, Sitagliptin, Dapagliflozin, Metformin. Die Gruppe, Wirkmechanismus und mindestens eine NW nennen.

Welches Medikament sollte vor OP abgesetzt werden und warum?

Antwort:Metformin wegen Laktatazidose

5. Ein 75J. Patient mit PaVK. Erzählen Sie Stadien nach Fontaine und weiteres vorgehen. Dann ein Zettel mit Werte gegeben, um ABI zu rechnen

Das war mittelschwer PAVK mit ABI 0,6

Dann andere Werte gegeben zur Berechnung. Die ABI wert: 2,1 (Mönckeberg mediasklerose. Auf Tisch lag ein Rechner, den habe ich benutzt zur Berechnung.

Innere Medizin

1. Patient mit BD: 90/60, puls: 120 Temp: 38,9°C. weiteres Vorgehen?

Antwort: qSofa Score, Septischer Schock. IV Zugang, Elektrolytlösung zufuhr, Aerobe und anaerobe Blutkultur, AB verabreichen und Fokussuche.

Wie hoch (Prozent?) ist die Letalität von Sepsis? Ich wusste das nicht. Er hat gesagt ja das ist schwer zu sagen, da es ist auf vielen Faktoren abhängig, aber allgemein ungefähr 10%.

2. Ein 25 jähriger Pt hat bewusstlosigkeit für kurze Zeit und jetzt ist er in die Notaufnahme gekommen. Alles ist jetzt Ok, VP normal, keine Beschwerden mehr. Wie gehen Sie weiter vor?

antwort: EKG schreiben

Dann ein Ek gezeigt. Das war ein AV Block von drittes Grad mit HF:50/min

Was ist Problem beim AV Block III

Antwort: komplette Unterbrechung von Impulsleitung von Vorhof zur Ventrikel

Was ist die Behandlung?

Antwort: HSM.

3. Ein 60 jähriger bekannt COPD Patient und chronischer Raucher, hat seit 2 Tagen Hämoptysen. Wie gehen Sie vor?

Antwort: (Röntgen Tx

. Dann ein Röntgen gezeigt mit Verschattung in r.lungenlappe.

Was machen Sie weiter?

Antwort: CT-Tx

Dann ein CT thorax gezeigt mit einer Raumforderung in r.lungenlappe

Sieht das bösartig aus oder nicht?

Antwort: ja Bösartig.

Warum?

Antwort: Hat Spiculae und unregelmäßige Grenze

Wie gehen Sie weiter vor?

Antwort: Biopsie, Staging mit CT abdomen, PET CT des Knochens und MRT schädel und EBUS.

Wie machen Sie Biopsie?

Ich: transthorakale CT gesteuerte Biopsie, da die Raumforderung peripher liegt.
Er sagte, dass heutzutage können wir mit Bronchoskopie auch das machen mit ein sehr kleiner biopsie Nadel.

Nach Staging, die nächsten Schritten?

Antwort: Tumorkonferenz einbeziehen. Dann hat gesagt, dass es ist T3N1M0.
Die genaue Behandlung erklären

Antwort: OP + adjuvante Chemotherapie

Was machen Sie vor OP?

Antwort: LUFU

Gibt es eine andere Möglichkeit außer Chemo und Radiotherapie?

Antwort: Ja Immuntherapie

Was ist Immuntherapie? erklären Sie das bitte

4. Ein bekannt Asthma Pt mit Asthma-Exazerbation? Wie behandeln Sie das?

Ich habe die Behandlung erzählt. Er hat über die Dosierung von Prednisolon gefragt.

Antwort: 50-100mg iv

Wie gehen Sie weiter?

Antwort: BGA

Ein BGA zeigt mit nur 3 Werte: PCO₂ (niedrig) PO₂: fast normal, PH: normal

Was ist hier passiert?

Ich: Hyperventilation

Prüf: Warum hyperventiliert der Patient?

Ich: Um Luft zu holen

Prüfer: sehr gut

Dann ein andere BGA zeigt mit PO₂ niedrig. Was ist das?

Ich: Hypoxämische respiratorische Insuffizienz

Dann BGA von gleichen Patienten nach 4 Stunden mit hoch PCO₂ Wert zeigt.

Prüf: Was ist passiert hier?

Ich: Hyperkapnische resp. Insuffizienz

Prüf: Ja warum ist es so geworden?

Ich: Weil die CO₂ akkumuliert sich

Prüf: Aber warum?

Ich: Atem depression

Pruf: Und warum Atem depression hier?

Ich: Weil der Pt nach 4 Stunden erschöpft ist

Pruf: Ganz genau

Ich hoffe ich habe alles geschrieben und etwas nicht vergessen.

Danach habe ich ein Minut draußen gewartet und Dr Bargon hat mich in die Zimmer angerufen und gefragt' wie ist Ihr Gefühl? Ich habe geantwortet "Ich fühle mich gut" Er sagte "ja richtig gut,Sie haben bestanden"

Die Atmosphäre war überall angenehm. Die Prüfern waren neutral aber mit richtige Antworten haben sie immer sehr freudlich reagiert. Wenn ihr z.B die Frage nicht versteht,immer sagt, sie wiederholen oder formulieren die Fragen so, damit du das gut verstehst. Und auch ein Tipp: bitte versuchst klar zu sprechen und deine Meinung deutlich äußern. Das war ein Problem bei mir. Ich habe mein ganzes Leben auf Englisch Medizin studiert, deswegen war mein Akzent oder Aussprache manchmal schwer für die Prüfern zu verstehen und ich musste vielmal meine Antwort wiederholen. Sie sind nicht so streng mit Aussprache oder akzent,sogar haben sie auch ein Paar Wörter auf Englisch gesprochen damit ich die Frage gut verstehe. Aber ich würde sagen bitte fokussiert ihr auch auf ihre Aussprache .

Vorbereitung/Empfehlungen: Insgesamt 1 Jahr

Letzte 3 Monaten intensiv und der letzte Monat super intensive(10-15 Stunden pro Tag)

Letzte 3-4 Monaten habe ich mit meiner Lernpartnerin Amena Hashemi einmal in der Woche Simulation und Fragen von Protokollen geübt und dann letzten Monat jeden Tag Simulationen gemacht. Das hat mir echt viel geholfen. Ich würde sagen, bitte ein gute und motivierte Lern Partner/ Partnerin finden und mit den Übungen anfangen.

Ich habe am Anfang FIA kurs besucht und ich würde sagen,das war überhaupt nicht Zeitverlust,sondern hat diesen Kurs mir geholfen,zur Orientierung,die KP Themen kennenzulernen und auch mein Sprache zu verbessern.

Dann habe ich Gott sei Dank Valeria Kurs gefunden und es war absolut top! 100% Prüfungsrelevant! Du bekommst alles, was nötig für die KP ist. Man braucht nichts mehr für die Prüfung nach dem Besuch dieses Kurses.

Das ist ein bisschen teuer und wird von Agentur nicht finanziert, aber ich würde sagen, bitte spart etwas Geld und investiert hier. Es lohnt sich! Ich habe im Feb auch 'Tag in Praxis' besucht. Das war extrem hilfreich. Man lernt die alle körperliche Untersuchungen am Fingertips.

Ich habe ein Paar Themen auch im Amboss gelesen, aber Amboss empfehle ich nicht. Es ist so detailliert und man verliert den Fokus.

Ich habe Chat Gpt und Doccheck auch benutzt. Wenn du etwas nicht verstehst, gib einfach im chat gpt. Es ist immer in einfachen Wörtern geklärt.

Ich habe keine Fallbücher gelesen, obwohl ich alle gekauft hatte, aber ich hatte keine Zeit dafür.

Tipps:

1. Wenn du etwas lernst, immer gleichzeitig Notizen von wichtigen Punkten machen und am Ende ein Paar Tage vor der Prüfung, diese Sachen wiederholen

2. Letzten Monat jede Nacht 1 Stunde vor Schlafengehen habe ich die Medikamenten (mit Dosierung, NW und Wirkmechanismus) und Laborwerte wiederholt. Am Ende hatte ich kein Problem mit Dosierung oder so und meine liebe Freundin Amena hat mir letzten Monat jeden Tag 5 Medikamenten in Whatsapp geschickt und ich musste die Gruppe, NW usw nennen. Während der Prüfung Medikamenten und Dosierungen waren gar kein Problem für mich.

3. Körperliche Untersuchung: Bitte immer Zuhause so viel wie möglich üben. Obwohl ich hatte 'Tag in Praxis' besucht und ich wusste alles in mein Gehirn, aber die letzte Woche vor der Prüfung ich habe alle körperliche Untersuchung an meinem Mann geübt und nur dann hatte ich bemerkt, dass ich mehr Übung brauchte, es lief nicht flüssig. Deshalb übte ich die ganze letzte Woche jeden Tag und spürte den Unterschied. Am Anfang konnte ich die komplette körperliche Untersuchung (Herz, Lunge, Bauch, Bein, Arm) in über 30 Minuten durchführen, am Ende aber nur noch in 15 Minuten.

02.06.2026 Bad Neuheim Bestanden		
Innere Medizin	Chirurgie	Psychosomatik
Neubauer-Saile	Volkmann	Wiehn

Klinischer Fall: Depression

Der Herr Volkmann hat mich aus dem Wartebereich am Erdgeschoss aufgerufen und in den Prüfungsraum auf dem zweiten Stock mitgebracht. Die Prüfer und Schauspielerin waren im gleichen Zimmer (ohne Schirm oder Wand inzwischen). Nach einer kurzen Vorstellung mit der Prüfungskommission begann der 1. Teil.

Eine 55-jährige Patientin stellte sich wegen seit ca. 2-3 Monaten progredientem Gewichtsverlust (ca. 4 kg) mit Appetitlosigkeit. Zudem klagte sie selbst über Antriebsstörung, Freudeverlust, Konzentrationsstörung. Nach Abfrage hat sie Schuldgefühl, Denkstörung, Gedächtnisstörung und psychomotorische Hemmung verneint. Eine direkte Frage über Suizidalität wurde auch verneint. Die Verstimmung war morgens etwas besser im Vergleich zu abends. Die vegetative Anamnese war bis auf Nachtschweiß unauffällig. Aus diesem Grund wurde vor paar Wochen auch eine hausärztliche Abklärung wurde durchgeführt, bei der jedoch keine bestimmte Diagnose gestellt werden konnte.

Als Vorerkrankungen nur arterielle Hypertonie bekannt, die mit Nebivolol 2,5 mg 1 x morgens eingestellt wird. 2x Kaiserschnitt OPs, Familie-/Reise-/Noxen-Anamnese unauffällig. Juristin von Beruf. Vollständig geimpft. Menstruale Anamnese nicht gefragt.

Die Anamnese dauerte etwa 12 Minuten (der Chirurg hat mir ein Zeichen darüber gegeben). Dann fing ich mit der körperlichen Untersuchung an.

KU: Zuerst mir die Hände desinfiziert. Messung der Vitalparameter erwähnt. Einseitiger Blutdruck gemessen (erwähnte auf die andere Seite auch zu messen). Puls nur kontrolliert, die Frequenz nicht gemessen, sowie nicht die Atemfrequenz und Körpertemperatur. Kurze Allgemeinuntersuchung durchgeführt (Ikterus, Anämiezeichen, Lymphknoten im Halsbereich) Neurologische Untersuchung angefangen (nur Gehirnnerven beim Sitzen untersucht). Die Patientin wurde angefordert sich hinzulegen, alle Herzpunkte (mit gleichzeitiger Palpation der Arteria radialis sowie Arteria carotis) auskultiert. Bauch oberflächlich und tief palpiert. Herr Dr. Wiehn hat noch mal Bescheid gegeben, dass nur etwa 1 Minute übrigbleibt. Ganz schnell Wirbelsäule Stauchungsschmerzen sowie Nierenklopfeschmerzen durchgeführt.

Labor/Bildgebung: Die Patientin kurz aufgeklärt über dem weiteren Vorgehen inklusiv Blutabnahme zur Laborkontrolle. An dieser Stelle betonte die Patientin, dass sie gerne eine Laborkontrolle hätte durchführen lassen würde, um etwas Konkretes festzustellen. Der Patientin wurde versichert, dass mindestens die Basis-Laborparameter bereits heute kontrolliert werden. Die Zeit war rum. Ich

sollte anschließend einen Brief schreiben. Das habe ich ausführlich geschrieben inklusiv kleine Begründungen über die weiteren Therapieempfehlungen. Die Zeit war genug dafür. Der mündliche Teil fing am Nachmittag an.

Die Frau Neubauer-Saile hat kurz über meiner vorherigen orthopädischen Erfahrung im Heimatland gesprochen und dann hat Dr. Volkmann mit chirurgischem Teil angefangen. Es war meistens Unfallchirurgie. Ein Laptop wurde von mir gestellt.

Chirurgie

Hr Volkmann: Sie sind in der Notaufnahme. Eine alte Omi aus Altenheim wegen einem Sturz heute Morgen in die Notaufnahme gebracht. Ein Bild wurde auf Laptop gezeigt (Schürfwunde sowie Prellung gleichen am linken Hüftbereich). Wie gehen Sie vor?

Ich: Primäre Untersuchung nach cABCDE Schema.

Hr Volkmann: Patientin im stabilen Allgemeinzustand, bewusst

Ich: Anamnese inklusive der Frage über die Ereignisse die den Sturz verursachen konnte

Hr Volkmann: Die Pflegeperson die die Patientin begleitet sagt, dass die Patientin vor dem Sturz ganz aktiv gewesen sei und dass bei ihr keine vorbekannten Erkrankungen entstehen.

Ich: Vitalparameter Messung, Trauma-Check

Hr Volkmann: Vitalparameter im Normbereich und keine anderen merkbaren Verletzungen außer dem gezeigten Körperteil.

Ich: Gezielte Untersuchung der linken Hüfte. Inspektion Befunde genannt. Das Bein war leicht innenrotiert. Das andere Bein war mit der Decke abgedeckt, deswegen konnte die Beinlänge nicht verglichen werden.

Hr Volkmann: Es gibt eine Beinverkürzung

Ich: Palpation- Hüfte Stauchungsschmerzen

Hr Volkmann: Patientin sagt Auua!!!

Ich: Verdachtsdiagnosen von Fraktur im proximalen Femurbereich und Luxation des Hüftgelenks.

Hr Volkmann: Was machen Sie weiter. (Hier habe ich vergessen pDMS zu nennen, aber musste unbedingt genannt werden).

Ich: Röntgen-Kontrolle

Hr Volkmann: welche Auftrag_

Ich: Becken Übersicht

Rö-Bild auf Laptop gezeigt, fast gleich wie unten



Ich: Pertrochantäre Fraktur, Intertrochantäre genau zu sagen.

Hr Volkmann: Intertrochantäre mit subtrochantärer Ausdehnung (da Trochanter minor auch gebrochen ist)

Ich: okk

Hr Volkmann: Wie behandeln Sie?

Ich: Nagelosteosynthese mit gamma Nagel

Hr Volkmann: Nagelosteosynthese reicht. Was wenn die Pt nimmt marcumar ein?

Ich: Trotzdem schnellmöglichste Op mit ggf. INR-Kontrolle und Umstellung auf Heparin
Hr Volkmann: Der Chirurg kann auch die Blutung intraop kontrollieren (typischer Satz)

Nächster Fall:

Ein Video von einem Fußballspiel gezeigt mit Unterschenkel Verletzung. Achsenabweichung merkbar. "Haben Sie es gesehen?" hat er gefragt?

Ich: Meinen Sie das Spiel oder die Verletzung?

Die Frau Neubauer hat laut gelacht

Hr Volkmann: Die Verletzung

Ich: Ja, Achsenabweichung ist sichtbar.

Hr Volkmann: weiter?

Ich: Körperliche Untersuchung

Klinisches Bild auf Laptop gezeigt- Stark geschwollenes Bein, mit Schürfwunde unter dem Knie.

Ich: Bild beschrieben.

Hr Volkmann: würden Sie es als offene oder geschlossene Fraktur bezeichnen?

Ich: da es sich nur um eine Schürfwunde handelt, ist eine geschlossene Fraktur

Hr Volkmann: Richtig. Dann was ist noch wichtig zu beurteilen?

Ich: Ausschluss eines Kompartment-Syndroms ist wichtig.

Hr Volkmann: was ist Kompartiment Syndrom?

Ich habe definiert.

Hr Volkmann: wie entsteht das in diesem Fall?

Ich: wegen intakter Faszie und geschlossenem Kompartiment, durch die Blutung aus der Fraktur kann sich der intrakompartimenteller Druck erhöhen

Hr Volkmann: Richtig. Venen sind früher als Arterien kollabiert und das führt zu mehr Blutversorgung des Beins in Vergleich zu Blutpumpen weg vom Bein (das hat er selbst geklärt)

Nächster Fall:

Anderes Bild von einem jungen Mädchen mit Händen auf dem Bauch und Schonhaltung. Hr Volkmann: 14 J Mädchen von ihrer Mutter in ZNA gebracht. Schmerzen im Unterbauch.

Vorgehen?

Ich: Anamnese bezüglich der Schmerzen, wann fingen die an? Wo fingen die an?

Hr Volkmann: seit gestern Abend, ungefähr um den Nabelbereich.

Ich: Haben die Schmerzen sich abgelagert?

Hr Volkmann: das können Sie auf dem Bild sehen

Ich: Ja stimmt, sieht wie rechten Unterbauch aus. Dann V.a. Appendizitis

Hr Volkmann: wie bestätigen Sie?

Ich: klassische Untersuchungspunkte beschrieben.“ DRU würde ich in diesem Fall verzichten, da die Pt nur 14 j alt ist“

Hr Volkmann: richtig

Dann hat die Frau Neubauer-Saille gefragt“ wieso!!!“. Hr Volkmann hat selbst geklärt. Hr Volkmann:“ wie viel Minuten habe ich noch?“ Fragte er seiner Kollegen.

*Fr Neubauer: 2-3, aber ich glaube das reicht.
Chirurgischer Teil war durch.*

Innere Medizin

Fr Neubauer- Saille: Ein Pt hat Schlückstörung. Was wären Ihre V.D.?

Ich habe von vergrößerten Tonsillen angefangen. Dann Zenker Divertikel genannt.

Fr Neubauer- Saille: die Hauptsymptome davon ich nicht Dysphagie.

Ich war ein bisschen verwirrt. Auch Auf Amboss die Leitsymptome ist Dysphagie (das habe ich natürlich nicht gesagt)

Fr Neubauer- Saille: was ist die Hauptsymptome von Zenker? Ich: Mundgeruch.

Fr Neubauer- Saille: Diagnose?

Ich: Rö mit Kontrast (Brei) oder Endoskopie.

Fr Neubauer- Saille: Therapie?

Ich: Divertikulektomie und Myotomie

Fr Neubauer- Saille: nicht Di-verti-kulektomie, sonst Di-verti-kulOTOMIE (hat sie betont) Ich war wieder bisschen verwirrt, weil auf Amboss' Divertikel-Exzision' steht.

Fr Neubauer- Saille: welche andere Möglichkeiten?

Ich: Motilitätsstörungen wie z.B. Achlasie, Nussknackerösophagus, Korkzieherösophagus

Fr Neubauer- Saille: Achlasie definition, Rö-Befund und Behandlung

Ich: Definiert, Sekt Glas. Behandlung: Botulinum Toxin und Chirurgie

Fr Neubauer- Saille: Botulinum, ja kann man bei älteren Menschen probieren. Welche Chirurgie?

Ich habe Ballon dilatation und submukosale Myotomie gesagt. Sie hat etwas hinzugefügt, erinnere mich jetzt nicht.

Fr Neubauer- Saille: in letzten etwa 25 Jahren hat sich eine neue Krankheit entwickelt, die meistens junge Männer betrifft.

Hier wusste ich nicht, dass sie immer noch auf Thema Ösophagus ist. Ich habe paar Sekunden überlegt und dann 'Morbus Bechterew' gesagt (obwohl ist nicht neues entwickelt).

Fr Neubauer- Saille: nein, Eosiniphilische Ösophagitis, haben sie darüber gehört? Ich: ja
Dann hat sie das selbst ein bisschen geklärt und keine Frage darüber gestellt.

Nächstes Thema

Fr Neubauer- Saille: Ursachen von Synkope

Ich: kardiale, reflektorische

Fr Neubauer- Saille: welche kardiale?

Ich: Herzrhythmusstörungen wie VHF

Sie wollte etwas anders hören. Hat mir ein paar mir ein paar Zeichen gegeben. Fiel mir nicht ein.

Fr Neubauer- Saille: andere Typen?

Ich: Reflektorische

Fr Neubauer- Saille: nennen wir etwas anderes als 'Reflektorische'

Ich: vaso-vagale

Fr Neubauer- Saille: Ja, welche ursachen davon?

Ich: Carotis sinus syndrom und lange Stehen

Fr Neubauer- Saille: lange stehen ist nicht die Ursache von Vaso-vagale, sondern von einem anderen Typ

Ich: Orthostatisch

Fr Neubauer- Saille: Ja

Hier noch ein paar Sachen aber nur Kleinigkeiten und damit war innere Medizin vorbei.

Psychosomatik

Hr Wiehn: welche psychiatrische Krankheiten stellen sich mit ösophagealer Auffälligkeiten vor?

Ich: Anorexie und Bulimie

Hr Wiehn: Nur Bulimie. Andere somatische Zeichen der Bulimie?

Ich: Russel Zeichen, Schleimdrüenschwellung, Zahnkaries

Hr Wiehn: Laborparameter und welche Elektrolytenstörungen?- Na, K und Cl Mangel

Welche Angststörungen?

Ich: alle 3 genannt. Generalisierte Angststörung sollte ich definieren

Hr Wiehn: welche bestimmte Kriterien?

Wusste ich nicht

Hr Wiehn: hat selbst geklärt. Angst wegen Gesundheit oder Krankheit der Angehörigen

(nie gehört oder gelesen)

Bei welcher Krankheit sorgt man sich wegen eigener Krankheiten?

Ich: Somatoforme Störungen, Hypochondrie genau zu sagen

Hr Wiehn: typische Geschichte davon?

Ich: mehrere und Verschiedene Arztbesuche (Doctor Shopping)

Hr Wiehn: was machen Sie als Hausarzt?

Ich: Ich versuche eine gute Beziehung mit Pt zu machen und typischerweise nehmen solche Pt viele Schmerzmedikamenten ein. Ich erkläre NW davon und versuche die auszuschleichen.

Hr Wiehn: Naja, nicht immer nehmen die Schmerzmittel ein, weil die davon auch ängstlich sind. Ich habe okk gesagt.

Welche psychiatrischen Erkrankungen in heutiger Welt erwarten Sie? Ich:

Angststörungen

Er hat bejaht, was noch?

Ich: Alkoholkrankheit

Hr Wiehn: ummmmmm, ja wenn es Alkohol gibt's, dann kann passieren. Was noch?

Ich: Depression?

Wollte was anderes hören. Hat gesagt "wegen so viele Kriege"

Ich: ahh ja, PTBS.

Er hat Definition und Therapie davon gefragt. Als Therapie Antidepressiva bei schweren Fällen und Psychotherapie wie EMDR

Hr Wiehn: was noch?

Ich: ummmmmm Gruppetherapie?

Hr Wiehn: naja, wegen Spracheinschränkungen zwischen verschiedene Migranten kann manchmal schwierig sein.

Weiterr wusste ich nicht

Hr Wiehn: Aufklärung der Situation- hat er hinzugefügt, konnte ich nicht ganz richtig verstehen aber habe zugestimmt.

Dann war die Zeit um. Ich sollte das Zimmer für kurze verlassen. Nach etwa 1 Minuten wieder einggerufen. Fr Neubauer-Saille teilte mit, dass ich bestanden habe. Alle gratulierten und nach weiteren Plänen gefragt.

Kann sein dass ich ein paar Fragen vergessen habe, aber die wichtigste und außergewöhnliche Fragen habe ich versucht ausführlich mitzuteilen.

Vorbereitung/Empfehlungen: Approcoaching Kurs von Valleria als Hauptquelle zum Lernen, und das ist auch tief genug und ausreichend. Vielen Dank an Valleria

Amboss nur für ein paar Themen von Psychiatrie.

Protokolle sind extrem wichtig, nicht nur durchzulesen sonst auch zu wiederholen. Nicht für zum Ende lassen, sonst hat man Palpationen, wenn man die Formulierung der Fragen zuerst kurz vor der Prüfung guckt.

Was mir besonders geholfen hat war die Simulationen mit meiner Lernpartnerin Enisá. Sie hat auch am 01.06. bestanden.

Die alle 3 Prüfer waren nett und hilfsbereit, insbesondere Hr Wiehn. Fr Neubauer-Saille war eher ernst aber hilfsbereit. Ich konnte mich gut äußern und Vorgehen war wichtiger als genaue Antwort.

Tipp: Während der Mittagspause war die Schauspielerin auch im Wartebereich. Sie hat mich gesehen, kam zu mir und fragte ob ich das Ergebnis schon bekommen hatte. Ich sagte nein, ich musste noch den 3. Teil ablegen. Da ich sehr nervös aussah, hat sie das bemerkt und mir mitgeteilt, dass sie sich beim Anamnesegespräch sehr wohl gefühlt hat. Sie gab mir eine

durchweg positive Rückmeldung. Das hat mein Selbstvertrauen ein bisschen gesteigert. Den gleichen Eindruck konnte ich auch bei den Prüfern vor und nach dem dritten Teil gewinnen.

Obwohl es sich nicht um eine Sprachstandprüfung handelt, bin ich der Meinung, dass ein guter erster Teil den dritten Teil erleichtert hat. Deswegen wäre es nur ein Vorschlag, die „Kommunikation“ beim ersten Teil nicht zu unterschätzen.
